



CORAIL Cemented Hip Prosthesis

Directory

en		Page 3
da		Side 13
de		Seite 23
es		Página 34
fi		Sivu 45
fr		Page 55
id		Halaman 66
it		Pagina 77
nl		Pagina 88
no		Side 99
pt		Página 109
ru		Стр. 120
sv		Sida 132

CORAIL Cemented Hip Prosthesis

IMPORTANT INFORMATION – Please read before use

Some products may not be licensed in all jurisdictions.



STERILE

See product label for method

Instructions for use (IFU) website

For access to the e-IFU and any additional languages visit www.e-IFU.com

Implant card, patient information leaflet (PIL) and website

The implant card (and implant card label) is provided in the package with the implant. The information in the patient information leaflet (PIL) is based on the information in this IFU. The ePIL can be found on the website below.

For access to the ePIL visit www.ic.jnjmedicaldevices.com

CAUTION: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician.

DEVICE DESCRIPTION

This is a metal femoral hip stem. A Total Hip Prosthesis is composed of individually packaged metal femoral hip stem, modular metal or ceramic femoral head and 2 piece metal-backed Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE), ceramic or all UHMWPE acetabular components designed to replace the natural articular surface of the hip joint.

MATERIALS

The information below lists the substances in the implant. Additional trace substances may be present due to the manufacturing process. Please contact the address below for additional information.

Example of Acronym used on label(s):	Material Description:	Material nominally contains the following substance(s):
S1	Stainless steel alloy	Iron (63%) Chromium (21%) Nickel (10%) Manganese (3%) Molybdenum (3%) Less than 1% of Niobium and Nitrogen

HOW SUPPLIED

These device(s) are individually packaged and supplied STERILE. Remove from the package using accepted aseptic technique only after the correct size has been determined. Do not use these components if the sterile packaging appears damaged or unintentionally opened.

INTENDED USE

Intended User

These devices are not to be used by unqualified personnel. It is essential that the surgeon and operating room staff are fully conversant with the appropriate surgical technique for the implant and associated instruments.

Intended use – Total hip prosthesis

Total hip arthroplasty is intended to replace the damaged hip joint articulation in patients where there is evidence of sufficient sound bone to seat and support the components.

WARNING: Use only DePuy modular femoral heads and DePuy acetabular components with DePuy modular femoral stems. The taper size of the femoral head **MUST** be matched to the taper size of the femoral stem.

Cemented components

This femoral stem labelled “For cemented use only” is intended for use with bone cement.

Patient Population

The intended patient population are the skeletally mature where there is evidence of sufficient sound bone to seat and support the components.

INDICATIONS

Total hip replacement is indicated in the following conditions:

1. A severely painful and/or arthritic joint (typically due to non-inflammatory degenerative joint disease)
2. Failed previous hip surgery
3. Acute fracture of the femoral head or neck

CONTRAINDICATIONS

1. Active local or systemic infection.
2. Loss of musculature, neuromuscular compromise or vascular deficiency in the affected limb rendering the procedure unjustified.
3. Poor bone quality, such as osteoporosis, where, in the surgeon's opinion, there could be considerable migration of the prosthesis or a significant change of the fracture of the femoral shaft and/or the lack of adequate bone to support the implant(s).
4. Charcot's or Paget's disease.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

- Implants and trials components from different manufacturers or implant systems should never be used together.
- Hip prosthesis components should never be reimplanted. Even though the implant appears undamaged, the implant may have developed microscopic imperfections which could lead to failure.
- Always use a trial prosthesis for trial purposes. Trials should not be assembled with any components intended for permanent implantation. Trials must have the same configuration size, etc., as the corresponding components to be permanently implanted.
- Single use devices manufactured by DePuy have not been designed to undergo or withstand any form of alteration, such as disassembly, cleaning or re-sterilization, after a single patient use. Reuse can potentially compromise device performance and patient safety.
- Do not alter or modify implants in any way.
- Quality bone stock is critical to ensure fixation of the device. Consider bone grafting and other reinforcement techniques, especially when performing revision surgery, to seat and support the device.

CAUTION: The following conditions, singularly or concurrently, tend to impose severe loading on the affected extremity, thereby placing the patient at higher risk for failure of the hip replacement:

1. Obesity or excessive patient weight.
2. Manual labor.
3. Moderate to high demand sports participation.
4. High levels of patient activity.
5. Likelihood of falls.

6. Active alcohol or drug misuse.
7. Other disabilities, as applicable.

CAUTION: The following conditions singularly or concurrently, tend to adversely affect the fixation of hip replacement implants:

1. Marked osteoporosis or poor bone stock.
2. Metabolic disorders or systemic pharmacological treatments leading to progressive deterioration of solid bone support for the implant (e.g., diabetes mellitus, steroid therapies, immunosuppressive therapies, etc.).
3. History of general or local infections.
4. Severe deformities leading to impaired fixation or improper positioning of the implant.
5. Tumors of the supporting bone structures.
6. Allergic reactions to implant materials (e.g., bone cement, metal).
7. Tissue reactions to implant corrosion or implant wear debris.
8. Disabilities of other joints (i.e., knees and ankles).

NOTE: Diabetes, at present, has not been established as a contraindication. However, because of the increased risk for complications such as infection, slow wound healing, etc., the physician should carefully consider the advisability of hip replacement in the severely diabetic patient.

The surgical and postoperative management of the patient must be carried out with due consideration for all existing conditions. Mental attitudes or disorders resulting in a patient's failure to adhere to the surgeon's orders may delay postoperative recovery and/or increase the risk of adverse effects including implant or implant fixation failure.

Excessive physical activity or trauma to the replaced joint may contribute to premature failure of the hip replacement by causing a change in position, fracture, and/or wear of the implants.

EXPECTED CLINICAL BENEFITS

TOTAL HIP PROSTHESIS

Total hip arthroplasty is expected to provide increased patient mobility and reduce pain by replacing the damaged hip joint articulation in skeletally mature patients where there is evidence of sufficient sound bone to seat and support the components.

SUMMARY OF SAFETY AND CLINICAL PERFORMANCE

Some countries or regions have hip replacement registries which monitor the performance of hip implants. This registry data was analysed and shows that for a person's first total hip operation generally 95% (95 out of 100) last more than 10 years. This means that at 10 years about 5% (5 out of 100) of patients may have had additional operations to remove part(s).

For revision hip replacement, generally 80% last more than 10 years. This device meets this general implant lifetime. The risk of additional operations for an individual patient will depend on patient specific factors such as their anatomy, medical condition, and lifestyle (e.g. weight and activity level), the surgical procedure and process.

A device specific SSCP can be found at the following link:
<http://ec.europa.eu/tools/eudamed>

Note: The Eudamed link will only be available after the Eudamed database goes live.

Reporting of Serious Incidents

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Serious incident means any incident that directly or indirectly led, might have led or might lead to any of the following:

- a) the death of a patient, user or other person,
- b) the temporary or permanent serious deterioration of a patient's, user's or other person's state of health,
- c) a serious public health threat.

INFORMATION FOR USE

Preoperative

THE SURGEON SHOULD DISCUSS ALL PHYSICAL AND MENTAL LIMITATIONS PARTICULAR TO THE PATIENT AND ALL ASPECTS OF THE SURGERY AND THE PROSTHESES WITH THE PATIENT BEFORE SURGERY. The discussion should include the limitations and possible consequences of joint replacement, the necessity to follow the surgeon's instructions postoperatively and the information provided in the patient leaflet.

The preoperative planning and surgical techniques for implantation of these hip replacement components evolved from the surgical experience gained during the development of many hip prostheses. Surgeons should not begin the clinical use of any hip prosthesis before they have thoroughly familiarized themselves with its specific implantation technique. Surgical technique brochures are available from DePuy.

Intraoperative

It is recommended that components at least one size larger and one size smaller than were preoperatively determined be available at surgery to accommodate intraoperative selection of the appropriate size(s).

Protective covers should be left on until the components are ready to be implanted. Do not use components if they have been dropped or have

impacted a hard surface. Damage to the component may not be visible but could cause early failure of the prosthesis. The surgical instruments identified in the surgical technique have been designed for this arthroplasty procedure and must be used as shown in the surgical technique brochure. Before implanting a ceramic femoral head, the male taper on the femoral stem should be wiped clean of any blood, bone chips or other foreign materials. Foreign material between the head and the femoral stem taper may impede proper seating of the head on the stem. This could affect the performance of the femoral head or the locking mechanism between the femoral head and the femoral stem.

When performing revision surgery, it is imperative that any fibrous membrane encapsulating the failed prosthesis be removed in its entirety. Residual fibrous membranes may interfere with implant fixation. Review any pre-existing devices for damage to mating surfaces that would prevent adequate seating or locking of the new device. Improper selection, placement, or positioning of implants may result in unusual stress conditions and a subsequent reduction in the functional life of the implant. Note that a femoral stem placed in varus increases the stress on the proximal medial femoral cortex and may lead to loosening of the implant. Prior to closure, the surgical site should be thoroughly cleansed of bone chips, extraneous bone cement, ectopic bone, etc. Foreign particles at the metal/plastic or ceramic/plastic or ceramic/ceramic interface may cause excessive wear. Range of motion should be thoroughly checked for improper mating, instability, or impingement and corrected as appropriate.

Postoperative

Strict adherence by the patient to the surgeon's instructions and warnings is extremely important. Accepted practices should be followed in postoperative care.

The patient should be released from the hospital with complete written instructions and warnings regarding exercises and therapies and any limitations on their activities. Component malposition or the use of constrained hip or total hip with modular skirted head or tapered sleeve can decrease joint range of motion and can increase the potential for component wear, impingement premature dislocation or revision. In these cases, the surgeon should inform the patient that high range of motion activities should be avoided.

A continuing periodic patient follow-up is recommended because of the unknown functional lifetime of the implant in the specific patient, particularly with respect to the maintenance of implant fixation and bearing surfaces. Radiological investigations should be performed at each follow-up and compared with previous radiological investigations and correlated with the

clinical assessment of the patient. If any radiological changes are observed, such as the occurrence of radiolucencies, bone resorption, or any changes in the position of an implant, these changes should be closely monitored to determine whether they are static or progressive and the patient treated appropriately.

ADVERSE EVENTS AND COMPLICATIONS

The following are generally the most frequently encountered adverse events and complications in hip arthroplasty:

General

The incidence and severity of complications in hip replacement are usually greater in revisions than in primary operations. Common problems encountered in revision surgery may include difficulty in placement of the incision, removal of ectopic bone and old bone cement, positioning and fixation of components, and/or obtaining adequate bony support. In general, increased operative time, blood loss, and risk of infection, pulmonary embolus and wound hematoma can be expected with revision procedures.

1. Change in position of the prosthetic components, often related to the factors listed in WARNINGS AND PRECAUTIONS.
2. Early or late loosening of the prosthetic components, often related to factors listed in WARNINGS AND PRECAUTIONS.
3. Fatigue fracture of the femoral stem, often related to factors listed in WARNINGS AND PRECAUTIONS.
4. Excessive wear or fracture of the bearing components due to: intraoperative damage to the prosthetic components, loose cement, bone fragments, metallic particles, ceramic particles or other factors listed in WARNINGS AND PRECAUTIONS.
5. Early or late infection.
6. Peripheral neuropathies. Subclinical nerve damage may also occur as a result of surgical trauma.
7. Tissue reactions, osteolysis, and/or implant loosening caused by metallic corrosion, allergic reactions, wear or particulate debris (such as loose cement, metallic, polyethylene or ceramic particles).
8. Residual pain in the hip.

Intraoperative

1. Femoral shaft perforation, fissure, or fracture, which may require the use of internal fixation.
2. Trochanteric fracture.
3. Damage to blood vessels (e.g. iliac, obturator and femoral artery).

4. Temporary or permanent nerve damage (e.g. femoral, obturator or isolated peroneal nerve).
5. Subluxation or dislocation of the hip joint due to implant size or configuration selection, positioning of components and/or muscle and fibrous tissue laxity.
6. Lengthening or shortening of the affected extremity.
7. Surgical delay.

Early Postoperative

1. Cardiovascular disorders including venous thrombosis, pulmonary embolism and myocardial infarction.
2. Hematoma and/or delayed wound healing.
3. Subluxation or dislocation.
4. Disassociation of modular components.

Late Postoperative

1. Trochanteric avulsion from excessive muscular tension, weight-bearing, or inadvertent intraoperative weakening of the trochanter.
2. Aggravation of problems in the ipsilateral or contralateral knee and ankle joints due to leg length discrepancy, femoral medialization and/or muscular deficiencies.
3. Femoral fracture due to trauma or excessive loading, particularly in the presence of poor bone stock caused by severe osteoporosis, bone defects from previous surgery, intraoperative reaming procedures, or bone resorption.
4. Bone resorption which may contribute to the deterioration of fixation and eventual loosening of the implant.
5. Decrease in joint mobility and range of motion (e.g. maybe caused by periarticular calcification or ossification).
6. Traumatic arthrosis of the ipsilateral knee secondary to intraoperative positioning, of the extremity during surgery.
7. Subluxation or dislocation.
8. Disassociation of modular components.

MRI SAFETY INFORMATION

 MRI Safety Information A patient with the DePuy Corail Cemented construct may be scanned under the following conditions. Failure to follow these conditions may result in injury to the patient.	
Name/Identification of device	Corail Cemented Hip Prosthesis
Nominal value(s) of Static Magnetic Field [T]	1.5 T or 3.0 T
Maximum Spatial Field Gradient [T/m and gauss/cm]	30 T/m (3,000 gauss/cm)
RF Excitation	Circularly Polarized (CP)
RF Transmit Coil Type	Whole body transmit coil, Head RF transmit-receive coil
Operating Mode	Normal Operating Mode
Maximum Whole Body SAR	2.0 W/kg (Normal Operating Mode)
Maximum Head SAR	Use of a head coil is not required for scanning of the hip
Limits on Scan Duration	2.0 W/kg whole body average SAR Scan for up to 15 minutes followed by 15 minutes cooling period (may be repeated up to three times in a single imaging session)
MR Image Artifact	The presence of this implant is not expected to produce an image artefact extending further than 108mm
Additional instructions or information essential for safe use in the MR environment	*Check all components of the hip construct for additional MR labelling information

DISPOSAL

Safely dispose of all devices used in accordance with local procedures and guidelines.

INTERPRETATION OF SYMBOLS

D/DP

DEPUY

REF

Catalog Number

LOT

Batch Code



Caution



Consult Instructions
for Use



www.e-IFU.com
US / Canada 800-255-2500
EU: +800 8888 2020
EU: +32 2 4037222

e-IFU website



Manufacturer



Use by Date

Sterile

Sterile

Sterile R

Sterilized using irradiation



Do not re-sterilize



Do not use if package is
damaged



Do not re-use



MR Conditional



Packaging unit

MATERIAL

Material(s) of construction

MD

Medical Device



Double sterile barrier
system



Recyclable



RT / LT

Right/left

MADE IN

Made in

S

Stainless steel

SIZE/SZ/DIA/IN/ft/DEG/GRP/lb/OD/ID

Size/size/diameter/inches/feet/degrees/group/pounds/
outer diameter/inner diameter

CORAIL Cemented hofteprotese

VIGTIG INFORMATION – bedes gennemlæst før brug

Visse produkter er muligvis ikke godkendt til salg i alle jurisdiktioner.



STERILE

Se produktmærkaten vedrørende metode

Hjemmeside med brugsanvisning

Den elektroniske brugsanvisning samt brugsanvisninger på andre sprog kan findes på www.e-IFU.com

Implantatkort, indlægsseddel (PIL) og hjemmeside

Implantatkortet (og implantatkortets etiket) leveres i pakken med implantatet. Oplysningerne i indlægssedlen (PIL) er baseret på oplysningerne i denne brugsanvisning. Den elektroniske indlægsseddel (ePIL) kan findes på nedenstående hjemmeside.

Der er adgang til ePIL på www.ic.jnjmedicaldevices.com

FORSIGTIG: I henhold til amerikansk lov (USA) må dette produkt kun sælges af en læge eller på en læges bestilling.

BESKRIVELSE AF ENHEDEN

Dette er et femurhofteskaft af metal. En total hofteprotese består af et individuelt pakket femurhofteskaft af metal, et modulært femurhoved af metal eller keramik og 2-delte acetabulumkomponenter af metalbeklædt polyethylen med ultrahøj molekylvægt (UHMWPE), keramik eller helt i UHMWPE, som er designet til at erstatte hofteleddets naturlige ledflade.

MATERIALER

Oplysningerne nedenfor angiver stofferne i implantatet. Yderligere sporstoffer kan være til stede på grund af fremstillingsprocessen. Kontakt nedenstående adresse for at få yderligere oplysninger.

Eksempel på akronym anvendt på mærkat(er):	Materiale-beskrivelse:	Materialet indeholder nominelt følgende stoffer:
S1	Rustfri stållegering	Jern (63 %) Krom (21 %) Nikkel (10 %) Mangan (3 %) Molybdæn (3 %) Mindre end 1 % niobium og nitrogen

LEVERING

Disse enheder er pakket individuelt og leveres STERILE. Tag først produktet ud af emballagen ved brug af godkendt aseptisk teknik, når den korrekte størrelse er blevet fastlagt. Disse komponenter må ikke anvendes, hvis den sterile emballage ser ud til at være beskadiget eller utilsigtet er blevet åbnet.

TILSIGTET ANVENDELSE

Tilsigtet bruger

Disse enheder må ikke bruges af ukvalificeret personale. Det er af afgørende betydning, at kirurgen og personalet på operationsstuen er fuldstændigt fortrolige med den relevante kirurgiske teknik i forbindelse med implantatet og eventuelle tilknyttede instrumenter.

Tilsigtet anvendelse – total hofteprotese

Total hofteartroplastik er beregnet til at erstatte det beskadigede hofteled hos patienter, hvor der er evidens for tilstrækkelig sund knogle til at placere og understøtte komponenterne.

ADVARSEL: Brug kun modulære DePuy-femurhoveder og DePuy-acetabulumkomponenter med modulære DePuy-femurskafter. Femurhovedets konusstørrelse SKAL matche femurskaftets konusstørrelse.

Cementerede komponenter

Dette femurskaft, der er mærket "Kun til cementeret brug", er beregnet til brug med knoglecement.

Patientpopulation

Den tilsigtede patientpopulation har fuldt udviklet skelet, hvor der er evidens for tilstrækkelig sund knogle til at placere og understøtte komponenterne.

INDIKATIONER

Total hofteudskiftning er indiceret under følgende forhold:

1. Led med kraftige smerter og/eller svær arthritis (typisk på grund af ikke-inflammatorisk degenerativ ledsygdom)
2. Mislykket tidligere hofteoperation
3. Akut fraktur på femurhoved eller -hals

KONTRAINDIKATIONER

1. Aktiv lokal eller systemisk infektion.
2. Tab af muskulatur, neuromuskulær skade eller vaskulær insufficiens i den berørte ekstremitet, der gør indgrebet uforsvarligt.
3. Ringe knoglekvalitet såsom osteoporose, hvor der efter kirurgens mening kan forekomme betydelig migration af protesen eller en signifikant ændring af femurskafets fraktur og/eller mangel på tilstrækkelig knogle til understøttelse af implantatet/implantaterne.
4. Charcots eller Pagets sygdom.

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

- Implantater og prøvekomponenter fra forskellige producenter eller implantatsystemer må aldrig bruges sammen.
- Hofteprotesekomponenter må aldrig genimplanteres. Selvom implantatet virker ubeskadiget, kan det have udviklet mikroskopiske defekter, der kan føre til svigt.
- Brug altid en prøveprotese til prøveformål. Prøvekomponenter må ikke monteres med komponenter, der er beregnet til permanent implantation. Prøvekomponenter skal have samme konfiguration, størrelse osv. som de tilsvarende komponenter, der skal implanteres permanent.
- Anordninger til engangsbrug, der er fremstillet af DePuy, er ikke konstrueret til at undergå eller kunne tåle nogen form for ændring som f.eks. adskillelse, rengøring eller resterilisering efter anvendelse til en enkelt patient. Genbrug kan potentielt kompromittere enhedens ydeevne og patientens sikkerhed.
- Implantater må ikke ændres eller modificeres på nogen måde.
- God knoglemasse er afgørende for at sikre fiksering af enheden. Overvej knogletransplantation og andre forstærkningsteknikker, især når der udføres revisionskirurgi, for at placere og støtte enheden.

FORSIGTIG: Følgende tilstande har, hver for sig eller sammen, tendens til at udsætte den berørte ekstremitet for alvorlig belastning og derved udsætte patienten for højere risiko for svigt af hofteprotesen:

1. Fedme eller overdreven patientvægt.
2. Manuelt arbejde.
3. Moderat til meget krævende sportsudøvelse.
4. Høje niveauer af patientaktivitet.
5. Sandsynlighed for fald.
6. Aktivt alkohol- eller stofmisbrug.
7. Andre former for funktionsnedsættelse, alt efter hvad der er relevant.

FORSIGTIG: Følgende tilstande har, hver for sig eller sammen, en tendens til at påvirke fikseringen af hofteudskiftningsimplantater negativt:

1. Markant osteoporose eller dårlig knoglemasse.
2. Metaboliske lidelser eller systemiske farmakologiske behandlinger, der fører til progressiv forringelse af fast knoglestøtte til implantatet (f.eks. diabetes mellitus, behandling med steroider, behandling med immunsuppressiva osv.).
3. Generelle eller lokale infektioner i anamnesen.
4. Alvorlige deformiteter, der fører til forringet fiksering eller forkert placering af implantatet.
5. Tumorer i de understøttende knoglestrukturer.
6. Allergiske reaktioner på implantatmaterialer (f.eks. knoglecement, metal).
7. Vævsreaktioner på implantatkorrosion eller slidrester fra implantatet.
8. Funktionsnedsættelse i andre led (dvs. knæ og ankler).

BEMÆRK: Diabetes er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt som en kontraindikation. På grund af den øgede risiko for komplikationer, såsom infektion, langsom sårheling osv., bør lægen dog nøje overveje tilrådeligheden af hofteudskiftning hos patienter med svær diabetes.

Den kirurgiske og postoperative behandling af patienten skal udføres under behørig hensyntagen til alle eksisterende forhold. Psykiske holdninger eller lidelser, der medfører, at patienten ikke følger kirurgens anvisninger, kan forsinke postoperativ bedring og/eller øge risikoen for komplikationer, herunder implantat- eller implantatfikseringsfejl.

Overdreven fysisk aktivitet eller traume for det udskiftede led kan forårsage positionsændring, fraktur og/eller slid på implantaterne og dermed bidrage til for tidligt svigt af hofteprotesen.

FORVENTEDE KLINISKE FORDELE

TOTAL HOFTEPROTESE

Total hofteartroplastik forventes at give øget patientmobilitet og reducere smerter ved at erstatte det beskadigede hofteled hos patienter med fuldt

udvokset skelet, hvor der er evidens for tilstrækkelig sund knogle til at placere og understøtte komponenterne.

SAMMENFATNING AF SIKKERHED OG KLINISK YDEEVNE

Visse lande eller regioner har hofteproteseregistre, som monitorerer hofteimplantaters ydeevne. Disse registerdata blev analyseret og viser, at for en persons første totale hofteoperation holder 95 % (95 ud af 100) af proteserne generelt mere end 10 år. Dette betyder, at efter 10 år skal omkring 5 % (5 ud af 100) af patienterne muligvis have foretaget yderligere operationer for at fjerne en del/dele. Generelt holder 80 % mere end 10 år ved en revisionshofteudskiftning. Denne enhed opfylder denne generelle implantatlevetid. For en individuel patient afhænger risikoen for yderligere indgreb af patientspecifikke faktorer såsom anatomi, medicinsk tilstand og livsstil (f.eks. vægt og aktivitetsniveau), den kirurgiske procedure og proces.

En enhedsspecifik SSCP kan findes på følgende link:

<http://ec.europa.eu/tools/eudamed>

Bemærk: Eudamed-linket vil først være tilgængeligt, når Eudamed-databasen er blevet lanceret.

Indberetning af alvorlige hændelser

Enhver alvorlig hændelse, der har fundet sted i forbindelse med enheden, skal indberettes til producenten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten har hjemsted.

En alvorlig hændelse betyder enhver hændelse, der direkte eller indirekte har ført, måske har ført eller kan føre til et af følgende:

- a) dødsfald for en patient, bruger eller anden person
- b) midlertidig eller permanent alvorlig forringelse af en patients, brugers eller anden persons helbredstilstand
- c) en alvorlig trussel mod folkesundheden.

OPLYSNINGER OM ANVENDELSE

Præoperativt

KIRURGEN SKAL DRØFTE ALLE PATIENTSPECIFIKKE FYSISKE OG MENTALE BEGRÆNSNINGER SAMT ALLE ASPEKTER AF OPERATIONEN OG PROTESERNE MED PATIENTEN INDEN INDGREBET. Drøftelsen skal omfatte begrænsningerne ved og de mulige konsekvenser af ledudskiftning, nødvendigheden af at følge kirurgens anvisninger postoperativt samt oplysningerne i patientbrochuren.

Den præoperative planlægning og de kirurgiske teknikker til implantation af disse hofteprotesekomponenter har udviklet sig på baggrund af den kirurgiske erfaring, der er opnået under udviklingen af mange hofteproteser. Kirurger bør ikke påbegynde klinisk brug af nogen hofteprotese, før de

har gjort sig grundigt bekendt med dens specifikke implantationsteknik. Brochurer om kirurgisk teknik fås hos DePuy.

Peroperativt

Det anbefales, at komponenter, der er mindst en størrelse større og en størrelse mindre end den, der blev fastlagt inden operationen, er til rådighed under indgrebet for at tage højde for peroperativt valg af de(n) relevante størrelse(r).

Beskyttelsesdæksler skal blive siddende, indtil komponenterne er klar til at blive planteret. Komponenterne må ikke bruges, hvis de er blevet tabt eller har ramt en hård overflade. Skader på komponenten er muligvis ikke synlige, men kan forårsage tidligt protesesvigt. De kirurgiske instrumenter, som er specificeret i den kirurgiske teknik, er blevet designet til denne artroplastikprocedure og skal benyttes som vist i brochuren om kirurgisk teknik. Inden implantation af et keramisk femurhoved skal femurskaffets hankonus tørres ren for blod, knoglesplinter eller andre fremmedlegemer.

Når der udføres revisionskirurgi, er det bydende nødvendigt, at enhver fibrøs membran, der indkapsler den svigtede protese, fjernes i sin helhed. Resterende fibrøse membraner kan interferere med implantatfiksering. Gennemgå eventuelle præeksisterende enheder for beskadigelse af sammenpassede flader, der ville forhindre passende placering eller fiksering af den nye enhed. Forkert valg eller placering af implantater kan resultere i usædvanlige belastningsforhold og en efterfølgende reduktion i implantatets funktionelle levetid. Bemærk, at et femurskaffet, der er placeret i varus, øger belastningen på den proksimale, mediale, femorale cortex og kan føre til, at implantatet løsner sig. Inden lukning skal operationsstedet renses grundigt for knoglesplinter, uvedkommende knoglecement, ektopisk knogle osv. Fremmedlegemer på grænseflader mellem metal/plast, keramik/plast eller keramik/keramik kan forårsage kraftig slidage. Bevægelsesområdet skal omhyggeligt kontrolleres for forkert sammenpasning, ustabilitet eller kollision og korrigeres efter behov.

Postoperativt

Det er yderst vigtigt, at patienten nøje overholder kirurgens anvisninger og advarsler. Følg godkendt praksis ved postoperativ behandling.

Patienten skal udskrives fra hospitalet med komplette skriftlige anvisninger og advarsler vedrørende øvelser og terapier samt eventuelle begrænsninger af vedkommendes aktiviteter. Fejllacering af komponenten eller anvendelse af begrænset hofte eller total hofte med et modulært hoved med kappe eller en konisk manchete kan reducere leddets bevægelighed og kan øge potentialet for komponentslidage, impingement, præmatur dislokation eller revision. I disse tilfælde skal kirurgen informere patienten om, at aktiviteter med stor bevægelighed bør undgås.

En løbende periodisk patientopfølgning anbefales på grund af implantatets ukendte funktionelle levetid i den specifikke patient, især med hensyn til vedligeholdelse af implantatfiksering og lejeoverflader. Der skal foretages røntgenundersøgelser ved hver opfølgning og disse skal sammenlignes med tidligere røntgenundersøgelser og korreleres med den kliniske vurdering af patienten. Hvis der observeres radiologiske forandringer såsom forekomst af røntgengennemskinelighed, knogleresorption eller enhver ændring af et implantats position, skal de pågældende forandringer monitoreres nøje for at fastlægge, om de er statiske eller progressive, og patienten skal behandles i overensstemmelse hermed.

BIVIRKNINGER OG KOMPLIKATIONER

Følgende er generelt de hyppigst forekommende uønskede hændelser og komplikationer ved hofteartroplastik:

Generelt

Forekomsten og alvorlighedsgraden af komplikationer ved hofteudskiftning er sædvanligvis større ved revisioner end ved primære indgreb. Almindelige problemer, der opstår ved revisionskirurgi, kan omfatte vanskeligheder med placering af snittet, fjernelse af ektopisk knogle og gammel knoglecement, placering og fiksering af komponenter og/eller opnåelse af tilstrækkelig knoglestøtte. Generelt kan der forventes øget operationstid, blodtab og risiko for infektion, lungeemboli og sårhæmatom ved revisionsprocedurer.

1. Ændring i protesekomponenternes position, ofte relateret til faktorer, der er anført i ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER.
2. Tidlig eller sen løsning af protesekomponenterne, ofte relateret til faktorer, der er anført i ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER.
3. Træthedbrud på femurskaftet, ofte relateret til faktorer, der er anført i ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER.
4. Kraftig slitage eller brud på lejekomponenterne på grund af: Peroperativ skade på protesekomponenterne, løs cement, knoglefragmenter, metalpartikler, keramiske partikler eller andre faktorer, der er anført i ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER.
5. Tidlig eller sen infektion.
6. Perifere neuropatier. Subklinisk nerveskade kan også forekomme som følge af kirurgisk traume.
7. Vævsreaktioner, osteolyse og/eller løsning af implantatet forårsaget af metallisk korrosion, allergiske reaktioner, slid eller partikelrester (såsom løs cement, metal-, polyethylen- eller keramikpartikler).
8. Tilbageværende smerter i hoften.

Peroperativt

1. Perforation, fissur eller fraktur på femurskafte, hvilket kan kræve brug af intern fiksering.
2. Trochanterfraktur.
3. Skader på blodkar (f.eks. arteria iliaca, obturatoria og femoralis).
4. Midlertidig eller permanent nerveskade (f.eks. nervus femoralis, obturatorius eller isoleret nervus peronealis).
5. Subluksation eller dislokation af hoftedeledet på grund af implantatstørrelse eller konfigurationsvalg, placering af komponenter og/eller slaphed i muskel- og bindevæv.
6. Forlængelse eller forkortelse af den berørte ekstremitet.
7. Kirurgisk forsinkelse.

Tidligt postoperativt

1. Kardiovaskulære lidelser, herunder venetrombose, lungeemboli og myokardieinfarkt.
2. Hæmatom og/eller forsinket sårheling.
3. Subluksation eller dislokation.
4. Adskillelse af modulære komponenter.

Sent postoperativt

1. Overrivning af trochanter på grund af overdreven muskelspænding, vægtbelastning eller utilsigtet peroperativ svækkelse af trochanter.
2. Forværring af problemer i de ipsilaterale eller kontralaterale knæ- og ankelled på grund af uoverensstemmelse mellem benlængder, medialisering af femur og/eller muskelinsufficiens.
3. Femurfraktur på grund af traume eller overdreven belastning, især ved forekomst af dårlig knoglemasse forårsaget af svær osteoporose, knogledefekter som følge af tidligere operation, peroperative udrømningsprocedurer eller knogleresorption.
4. Knogleresorption, som kan bidrage til forringelse af fiksering og eventuel løsning af implantatet.
5. Fald i ledmobilitet og bevægelsesområde (kan f.eks. være forårsaget af periartikulær forkalkning eller ossifikation).
6. Traumatisk artrose i det ipsilaterale knæ sekundært til peroperativ positionering af ekstremiteten under operationen.
7. Subluksation eller dislokation.
8. Adskillelse af modulære komponenter.

OPLYSNINGER OM MR-SIKKERHED



Oplysninger om MR-sikkerhed

En patient med DePuy Corail Cemented-produktet kan scannes under følgende forhold. Manglende overholdelse af disse betingelser kan medføre skade på patienten.

Navn/identifikation af enheden	Corail Cemented hofteprotese
Nominell(e) værdi(er) for statisk magnetfelt [T]	1,5 T eller 3,0 T
Maksimal rumlig feltgradient [T/m og gauss/cm]	30 T/m (3.000 gauss/cm)
RF-excitation	Cirkulært polariseret (CP)
RF-senderspoletype	Helkrops-senderspole, hoved-RF-sender/modtagerspole
Betjeningstilstand	Normal betjeningstilstand
Maksimal SAR for hele kroppen	2,0 W/kg (normal betjeningstilstand)
Maksimal SAR for hovedet	Brug af en hovedspole er ikke påkrævet ved scanning af hoften
Grænser for scanningsvarighed	2,0 W/kg gennemsnitlig SAR for hele kroppen Scan i op til 15 minutter efterfulgt af en 15 minutters afkølingsperiode (kan gentages op til tre gange i en enkelt billedbehandlingssession)
MR-billedartefakt	Tilstedeværelsen af dette implantat forventes ikke at producere et billedartefakt, der spreder sig mere end 108 mm
Yderligere anvisninger eller oplysninger, som er afgørende for sikker brug i MR-miljøet	*Kontrollér alle komponenter i hofteproduktet for yderligere MR-mærkningsoplysninger

BORTSKAFFELSE

Bortskaf alt anvendt udstyr på sikker vis i overensstemmelse med lokale procedurer og retningslinjer.

SYMBOLFORKLARING

D/DP

DEPUY



Forsigtig



Producent



Steriliseret ved brug af stråling



Må ikke genbruges



Fremstillingsmateriale(r)



Kan genindvindes



Katalognummer



Se brugsanvisningen



Anvendes inden



Må ikke resteriliseres



MR-betinget



Medicinsk udstyr

RT / LT

Højre/venstre



Batchkode



www.e-IFU.com
US / Canada 800-255-2500
EU: +800 8888 2020
EU: +32 2 4037222

Websted med elektronisk
brugsanvisning



Steril



Må ikke anvendes, hvis
emballagen er beskadiget



Emballageenhed



Dobbelt steril
barrieresystem



Fremstillet i

S

Rustfrit stål

SIZE/SZ/DIA/IN/ft/DEG/GRP/lb/OD/ID

Størrelse/størrelse/diameter/tommer/fod/grader/gruppe/
pund/udvendig diameter/indvendig diameter

CORAIL Cemented Hüftprothese

WICHTIGE INFORMATIONEN – Bitte vor Gebrauch lesen

Einige Produkte sind möglicherweise nicht in allen Gerichtsbarkeiten lizenziert.



STERILE

Methode siehe Produktetikett

Gebrauchsanweisung und Website

Für den Zugriff auf die elektronische Gebrauchsanweisung (e-IFU) und auf alle weiteren Sprachen besuchen Sie uns unter www.e-IFU.com

Implantatkarte, Patienteninformationsblatt (PIL) und Website

Die Implantatkarte (und das Etikett der Implantatkarte) sind in der Verpackung des Implantats enthalten. Die Informationen im Patienteninformationsblatt (PIL) basieren auf den Informationen in dieser Gebrauchsanweisung. Das ePIL ist auf der unten stehenden Website zu finden.

Für den Zugriff auf das elektronische Patienteninformationsblatt (ePIL) besuchen Sie uns unter www.ic.jnjmedicaldevices.com

ACHTUNG: Laut US-Amerikanischer Bundesgesetze darf dieses Produkt nur von Ärzten oder im Auftrag von Ärzten verkauft werden.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Es handelt sich um einen Femurschaft aus Metall. Eine Hüfttotalprothese besteht aus einem Femurschaft aus Metall, einem modularen Femurkopf aus Metall oder Keramik und zweiteiligen Pfannenkomponenten aus Polyethylen mit ultrahoher Molekülmasse (UHMWPE) mit Metallverstärkung, aus Keramik oder komplett aus UHMWPE. Die Komponenten sollen die natürliche Gelenkfläche des Hüftgelenks ersetzen und sind jeweils einzeln verpackt.

MATERIALIEN

Im Folgenden sind die im Implantat enthaltenen Substanzen aufgeführt. Bedingt durch den Herstellungsprozess können außerdem Spurenstoffe enthalten sein. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die untenstehende Adresse.

Beispiel für ein Akronym, das auf dem/den Etikett(en) verwendet wird:	Materialbeschreibung:	Das Material enthält nominell die folgenden Substanzen:
S1	Rostfreie Stahllegierung	Eisen (63 %) Chrom (21 %) Nickel (10 %) Mangan (3 %) Molybdän (3 %) Weniger als 1 % Niob und Stickstoff

LIEFERFORM

Diese(s) Produkt(e) werden einzeln verpackt und STERIL geliefert. Erst nach Bestimmung der korrekten Größe mit einer anerkannten aseptischen Methode aus der Verpackung nehmen. Verwenden Sie diese Komponenten nicht, wenn die sterile Verpackung Beschädigungen aufweist oder versehentlich geöffnet wurde.

VERWENDUNGSZWECK

Vorgesehener Benutzer

Diese Produkte dürfen nicht von unqualifiziertem Personal benutzt werden. Es ist unbedingt erforderlich, dass der Chirurg und das OP-Personal gut mit den entsprechenden chirurgischen Techniken für das Einsetzen des Implantats und die Verwendung der zugehörigen Instrumente vertraut sind.

Verwendungszweck – Hüfttotalprothese

Die totale Hüftarthroplastik ist für den Ersatz eines beschädigten Hüftgelenks bei Patienten vorgesehen, bei denen nachweislich ausreichend gesundes Knochengewebe vorhanden ist, um die Komponenten anzubringen und zu stützen.

WARNHINWEIS: Verwenden Sie nur modulare DePuy Femurköpfe und DePuy Hüftpfannenkomponenten mit modularen DePuy Femurschaften. Die Konusgröße des Femurkopfes MUSS auf die Konusgröße des Femurschafts abgestimmt werden.

Komponenten zur Verwendung mit Zement

Dieser Femurschaft mit der Aufschrift „Nur zur Verwendung mit Zement“ ist zur Verwendung mit Knochenzement bestimmt.

Patientenpopulation

Die vorgesehene Patientenpopulation verfügt über ein ausgereiftes Skelett und nachweislich ausreichend gesundes Knochengewebe, um die Komponenten anzubringen und zu stützen.

INDIKATIONEN

Eine Hüfttotalprothese ist bei den folgenden Erkrankungen indiziert:

1. Ein stark schmerzhaftes und/oder arthritisches Gelenk (typischerweise aufgrund einer nichtentzündlichen degenerativen Gelenkerkrankung)
2. Gescheiterte frühere Hüftoperation
3. Akute Fraktur des Femurkopfes oder -halses

KONTRAINDIKATIONEN

1. Aktive lokale oder systemische Infektion.
2. Muskelsubstanzverlust, neuromuskuläre Gefährdung oder Gefäßmangel in der betroffenen Extremität, aufgrund derer das Verfahren nicht verantwortet werden kann.
3. Schlechte Knochensubstanz, z. B. Osteoporose, wodurch nach der Einschätzung des Chirurgen eine erhebliche Verschiebung der Prothese oder eine signifikante Frakturgefahr des Femurschafts nicht auszuschließen und/oder keine ausreichende Knochenstütze für das/die Implantat(e) gewährleistet wäre.
4. Morbus Charcot oder Morbus Paget.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

- Implantate und Testkomponenten von verschiedenen Herstellern oder Implantatsystemen sollten niemals zusammen verwendet werden.
- Hüftprothesenkomponenten sollten niemals wiederholt implantiert werden. Auch wenn das Implantat unbeschädigt zu sein scheint, kann es mikroskopisch kleine Unvollkommenheiten aufweisen, die das Material unbrauchbar machen können.
- Verwenden Sie zu Testzwecken immer eine Testprothese. Die Tests sollten keine Komponenten beinhalten, die für eine dauerhafte Implantation vorgesehen sind. Testkomponenten müssen die gleiche Konfigurationsgröße usw. haben wie die entsprechenden Komponenten, die dauerhaft implantiert werden sollen.
- Einmalprodukte aus der Herstellung von DePuy sind nach Verwendung bei einem Patienten nicht dafür ausgelegt, dass Änderungen in Form von Zerlegen, Reinigen oder erneutem Sterilisieren vorgenommen werden dürfen. Eine Wiederverwendung kann die Leistungsfähigkeit des Produkts beeinträchtigen und die Sicherheit des Patienten gefährden.
- Implantate dürfen in keiner Weise verändert oder modifiziert werden.
- Die Qualität des Knochenmaterials ist entscheidend für die Anbringung der Implantate. Ziehen Sie Knochentransplantationen und andere

Verstärkungstechniken in Betracht, insbesondere bei der Durchführung von Revisionseingriffen, um das Implantat zu platzieren und zu stützen.

ACHTUNG: Die folgenden Bedingungen, die einzeln oder gleichzeitig vorliegen können, üben eine schwere Belastung auf die betroffene Extremität aus. Bei diesen Patienten besteht folglich ein höheres Risiko, dass der Hüftgelenkersatz versagt:

1. Adipositas oder übermäßiges Gewicht des Patienten
2. Körperliche Arbeit
3. Moderate bis sehr anspruchsvolle sportliche Aktivität
4. Hohe Patientenaktivität
5. Wahrscheinlichkeit von Stürzen
6. Aktiver Alkohol- oder Drogenmissbrauch
7. Gegebenenfalls andere Behinderungen

ACHTUNG: Die folgenden Bedingungen neigen einzeln oder gleichzeitig dazu, sich ungünstig auf die Anbringung von Hüftprothesenimplantaten auszuwirken:

1. Ausgeprägte Osteoporose oder schlechte Knochenqualität.
2. Stoffwechselstörungen oder systemische pharmakologische Behandlungen, die zu einer fortschreitenden Verschlechterung der festen Knochenstütze für das Implantat führen (z. B. Diabetes mellitus, Steroidtherapien, Therapien mit Immunsuppressiva usw.).
3. Vorgeschichte von allgemeinen oder lokalen Infektionen.
4. Schwere Missbildungen, die zu einer beeinträchtigten Fixierung oder unsachgemäßen Positionierung des Implantats führen.
5. Tumoren der tragenden Knochenstrukturen.
6. Allergische Reaktionen auf Implantatmaterialien (z. B. Knochenzement, Metall).
7. Gewebereaktionen auf Implantatkorrosion oder Abriebpartikel des Implantats.
8. Verminderte Leistungsfähigkeit anderer Gelenke (d. h. Knie und Knöchel).

HINWEIS: Diabetes ist derzeit nicht als Kontraindikation etabliert. Wegen des erhöhten Risikos für Komplikationen wie Infektionen, langsame Wundheilung usw. sollte der Arzt jedoch den Einsatz eines Hüftgelenkersatzes bei Patienten mit schwerem Diabetes sorgfältig abwägen.

Die chirurgische und postoperative Behandlung des Patienten muss unter Berücksichtigung aller bestehenden Erkrankungen erfolgen. Psychische Probleme oder Störungen, die dazu führen, dass ein Patient die Anweisungen des Chirurgen nicht befolgen kann, können die postoperative Genesung verzögern und/oder das Risiko unerwünschter Auswirkungen, einschließlich des Versagens der Implantate oder der Implantatfixierung, erhöhen.

Übermäßige körperliche Aktivität oder ein Trauma des ersetzten Gelenks kann zu einem vorzeitigen Versagen des Hüftgelenkersatzes durch Positionsänderung, Fraktur und/oder Verschleiß der Implantate beitragen.

ERWARTETER KLINISCHER NUTZEN

HÜFTTOTALPROTHESE

Die totale Hüftarthroplastik soll für eine erhöhte Patientenmobilität sorgen und die Schmerzen verringern. Dies geschieht, indem das beschädigte Hüftgelenk bei Patienten mit ausgewachsenem Skelett ersetzt wird, bei denen nachweislich ausreichend gesunde Knochen vorhanden sind, um die Komponenten anzubringen und zu stützen.

KURZBERICHT ÜBER SICHERHEIT UND KLINISCHE LEISTUNG

In einigen Ländern oder Regionen gibt es Register für Hüftprothesen, die die Leistung von Hüftimplantaten überwachen. Diese Registerdaten wurden analysiert und zeigen, dass bei der ersten Hüfttotaloperation einer Person in der Regel 95 % (95 von 100) der Implantate mehr als 10 Jahre halten. Das bedeutet, dass sich nach 10 Jahren etwa 5 % (5 von 100) der Patienten zusätzlichen Operationen zur Entfernung von Teilen unterziehen müssen. Bei einer Revisionsoperation einer Hüftprothese haben in der Regel 80 % der Implantate eine Lebensdauer von mehr als 10 Jahren. Dieses Produkt erfüllt diese allgemeine Implantatlebensdauer. Das Risiko zusätzlicher Operationen für einen einzelnen Patienten hängt von patientenspezifischen Faktoren wie der Anatomie, dem Gesundheitszustand und dem Lebensstil (z. B. Gewicht und Aktivitätsniveau), dem chirurgischen Eingriff und dem Verfahren ab.

Eine produktspezifische SSCP ist unter dem folgenden Link zu finden:
<http://ec.europa.eu/tools/eudamed>

Hinweis: Der Eudamed-Link wird erst nach Inbetriebnahme der Eudamed-Datenbank verfügbar sein.

Meldung schwerwiegender Vorfälle

Jeder schwerwiegende Vorfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Benutzer und/oder Patient ansässig ist, gemeldet werden.

Als schwerwiegender Vorfall gilt jeder Zwischenfall, der direkt oder indirekt zu einem der folgenden Ereignisse geführt hat, geführt haben könnte oder führen könnte:

- a) Tod eines Patienten, Benutzers oder einer anderen Person,
- b) vorübergehende oder dauerhafte ernsthafte Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, eines Benutzers oder einer anderen Person,
- c) ernsthafte Bedrohung für die öffentliche Gesundheit.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Präoperativ

DER CHIRURG SOLLTE VOR DER OPERATION ALLE KÖRPERLICHEN UND KOGNITIVEN EINSCHRÄNKUNGEN DES PATIENTEN UND ALLE ASPEKTE DES EINGRIFFS UND DER PROTHESEN MIT DEM PATIENTEN BESPRECHEN. Das Gespräch sollte die Grenzen und möglichen Folgen des Gelenkersatzes, die Notwendigkeit, die Anweisungen des Chirurgen postoperativ zu befolgen, und die im Patienteninformationsblatt enthaltenen Informationen thematisieren.

Die präoperative Planung und die Operationstechniken für die Implantation dieser Hüftprothesenkomponenten wurden auf Grundlage der chirurgischen Erfahrungen, die bei der Entwicklung vieler Hüftprothesen gesammelt wurden, konzipiert. Chirurgen sollten nicht mit dem klinischen Einsatz einer Hüftprothese beginnen, bevor sie sich nicht gründlich mit der spezifischen Implantationstechnik vertraut gemacht haben. Broschüren zur Chirurgietechnik sind bei DePuy erhältlich.

Intraoperativ

Es wird empfohlen, dass bei der Operation Komponenten zur Verfügung stehen, die mindestens eine Größe größer und eine Größe kleiner sind als präoperativ festgelegt wurde, um die intraoperative Auswahl der geeigneten Größe(n) zu ermöglichen.

Die Schutzabdeckungen sollten so lange verschlossen bleiben, bis die Komponenten für die Implantation entnommen werden. Verwenden Sie keine Komponenten, die heruntergefallen sind oder auf eine harte Oberfläche aufgeprallt sind. Beschädigungen der Komponenten sind möglicherweise nicht sichtbar, können aber ein frühes Versagen der Prothese verursachen. Die im Rahmen der Operationstechnik bestimmten chirurgischen Instrumente wurden für dieses arthroplastische Verfahren entwickelt und müssen wie in der Broschüre zur Operationstechnik dargestellt verwendet werden. Vor der Implantation eines keramischen Femurkopfes sollte der Außenkonus am Femurschaft von Blut, Knochensplittern oder anderen Fremdmaterialien gereinigt werden. Fremdmaterialien zwischen dem Kopf und dem Femurschaftkonus können den korrekten Sitz des Kopfes auf dem Schaft beeinträchtigen. Dies könnte die Leistung des Femurkopfes oder den Verriegelungsmechanismus zwischen Femurkopf und Femurschaft beeinträchtigen.

Bei der Durchführung eines Revisionseingriffs ist es unbedingt erforderlich, dass jede faserige Membran, die die defekte Prothese umhüllt, vollständig entfernt wird. Restbestände von faserigen Membranen können die Implantatfixierung stören. Überprüfen Sie alle bereits vorhandenen

Produkte auf Beschädigungen der Fügeflächen, die einen adäquaten Sitz oder eine Verriegelung des neuen Produkts verhindern würden. Eine unsachgemäße Auswahl, Platzierung oder Positionierung von Implantaten kann zu ungewöhnlichen Belastungsbedingungen und einer anschließenden Reduzierung der Funktionsdauer des Implantats führen. Beachten Sie, dass ein in Varusstellung platzierter Femurschaft die Belastung der proximalen medialen Femurkortikalis erhöht und zu einer Lockerung des Implantats führen kann. Vor dem Verschluss sollte die Operationsstelle gründlich von Knochensplittern, fremdem Knochenzement, ektopischem Knochen usw. gereinigt werden. Fremdpartikel an der Schnittstelle Metall/Kunststoff, Keramik/Kunststoff oder Keramik/Keramik können zu übermäßigem Verschleiß führen. Der Bewegungsumfang sollte gründlich auf unsachgemäße Verbindungen, Instabilität oder Einklemmungen überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden.

Postoperativ

Die strikte Befolgung der Anweisungen und Warnhinweise des Chirurgen durch den Patienten ist äußerst wichtig. Bei der postoperativen Versorgung sollten anerkannte Praktiken befolgt werden.

Der Patient sollte mit vollständigen schriftlichen Anweisungen und Warnhinweisen bezüglich Übungen und Therapien und eventuellen Einschränkungen seiner Aktivitäten aus dem Krankenhaus entlassen werden. Eine Fehlpositionierung der Komponenten oder die Verwendung einer Zwangshüfte oder Gesamthüfte mit modularem Sockelkopf oder konischer Hülse kann den Bewegungsumfang des Gelenks einschränken und das Potenzial für Komponentenverschleiß, Impingement, vorzeitige Dislokation oder Revision erhöhen. In diesen Fällen sollte der Chirurg den Patienten darüber aufklären, dass Aktivitäten mit hohem Bewegungsumfang vermieden werden sollten.

Aufgrund der unbekannten funktionellen Lebensdauer des Implantats bei dem jeweiligen Patienten wird eine fortlaufende, regelmäßige Patientennachsorge empfohlen, insbesondere im Hinblick auf die Erhaltung der Implantatfixierung und der Lageroberflächen. Röntgenuntersuchungen sollten bei jedem Nachsorgetermin durchgeführt, mit früheren Röntgenuntersuchungen verglichen und mit der klinischen Beurteilung des Patienten abgeglichen werden. Wenn radiologische Veränderungen beobachtet werden, wie das Auftreten von Strahlendurchlässigkeit, Knochenresorption oder Veränderungen der Position eines Implantats, sollte dies genau überwacht werden, um festzustellen, ob die Veränderungen statisch oder progressiv sind. Der Patient sollte entsprechend behandelt werden.

UNERWÜNSCHTE EREIGNISSE UND KOMPLIKATIONEN

Im Folgenden werden die häufigsten unerwünschten Ereignisse und Komplikationen bei der Hüftarthroplastik aufgeführt:

Allgemein

Die Inzidenz und der Schweregrad von Komplikationen beim Hüftgelenkersatz sind bei Revisionen in der Regel größer als bei primären Operationen. Häufige Probleme, die bei Revisionseingriffen auftreten, können Schwierigkeiten bei der Platzierung der Inzision, der Entfernung von ektopischem Knochen und altem Knochenzement, der Positionierung und Fixierung von Komponenten und/oder dem Erhalt eines adäquaten Knochenbetts sein. Im Allgemeinen ist bei Revisionseingriffen mit erhöhter Operationszeit, Blutverlust und einem erhöhten Risiko für Infektionen, Lungenembolien und Wundhämatome zu rechnen.

1. Veränderung der Position der Prothesenkomponenten, oft in Verbindung mit den unter **WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN** aufgeführten Faktoren.
2. Frühe oder späte Lockerung der Prothesenkomponenten, oft in Verbindung mit Faktoren, die unter **WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN** aufgeführt sind.
3. Ermüdungsfraktur des Femurschafts, oft in Verbindung mit Faktoren, die unter **WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN** aufgeführt sind.
4. Übermäßiger Verschleiß oder Fraktur der Auflagekomponenten durch: intraoperative Schädigung der Prothesenkomponenten, losem Knochenzement, Knochenfragmente, Metallpartikel, Keramikpartikel oder andere Faktoren, die unter **WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN** aufgeführt sind.
5. Frühe oder späte Infektion.
6. Periphere Neuropathien. Subklinische Nervenschäden können auch als Folge eines chirurgischen Traumas auftreten.
7. Gewebereaktionen, Osteolyse und/oder Implantatlockerung aufgrund von Metallkorrosion, allergischen Reaktionen, Abnutzung oder partikelförmigen Ablagerungen (wie loser Zement, Metall-, Polyethylen- oder Keramikpartikel)
8. Restschmerz in der Hüfte.

Intraoperativ

1. Perforation, Riss oder Fraktur des Femurschafts, die eine interne Fixierung erfordern können.
2. Trochanterfraktur.
3. Schädigung der Blutgefäße (z. B. Arteria iliaca, obturatoria und femoralis).

4. Vorübergehende oder dauerhafte Nervenschädigung (z. B. Nervus femoralis, obturatorius oder isolierter Nervus peroneus).
5. Subluxation oder Dislokation des Hüftgelenks aufgrund der ungünstigen Auswahl der Implantatgröße oder -anordnung, der Positionierung von Komponenten und/oder der Schwäche von Muskel- und Fasergewebe.
6. Dehnung oder Verkürzung der betroffenen Extremität.
7. Chirurgische Verzögerung.

Unmittelbar Postoperativ

1. Kardiovaskuläre Störungen, einschließlich Venenthrombose, Lungenembolie und Myokardinfarkt.
2. Hämatom und/oder verzögerte Wundheilung.
3. Subluxation oder Dislokation.
4. Dissoziation von modularen Komponenten.

Später Postoperativ

1. Trochanterabriss durch übermäßige Muskelspannung, Gewichtsbelastung oder unbeabsichtigte intraoperative Schwächung des Trochanters.
2. Verschlimmerung von Problemen in den ipsilateralen oder kontralateralen Knie- und Sprunggelenken aufgrund von Beinlängenunterschieden, femoraler Medialisierung und/oder muskulären Defiziten.
3. Femurfraktur aufgrund eines Traumas oder einer übermäßigen Belastung, insbesondere bei schlechter Knochenqualität aufgrund von schwerer Osteoporose, Knochendefekten aus früheren Operationen, intraoperativen Bohrverfahren oder Knochenresorption.
4. Knochenresorption, die zur Verschlechterung der Fixierung und schließlich zur Lockerung des Implantats beitragen kann.
5. Verminderung des Gelenk-Bewegungsumfangs (kann beispielsweise durch eine periartikuläre Verkalkung oder Verknöcherung verursacht werden).
6. Traumatische Arthrose des ipsilateralen Knies nach intraoperativer Positionierung der Extremität während der Operation.
7. Subluxation oder Dislokation.
8. Dissoziation von modularen Komponenten.

INFORMATIONEN ZUR MRT-SICHERHEIT



Informationen zur MRT-Sicherheit

Ein Patient mit der DePuy Corail Zementkonstruktion kann unter den folgenden Bedingungen gescannt werden. Die Nichtbeachtung dieser Bedingungen kann zu Verletzungen des Patienten führen.

Bezeichnung/Identifikation des Produkts	Corail Cemented Hüftprothese
Nennwert(e) des statischen Magnetfelds [T]	1,5 T oder 3,0 T
Maximaler räumlicher Gradient [T/m und Gauß/cm]	30 T/m (3.000 Gauß/cm)
HF-Anregung	Zirkular polarisiert (CP)
Typ der HF-Spule	Ganzkörperspule, HF-Kopfspule mit Sende- und Empfangsmodus
Betriebsmodus	Normaler Betriebsmodus
Maximale Ganzkörper-SAR	2,0 W/kg (Normaler Betriebsmodus)
Maximale Kopf-SAR	Bei Aufnahmen der Hüfte ist keine Kopfspule erforderlich.
Begrenzungen der Scan-Dauer	2,0 W/kg durchschnittlicher Ganzkörper-SAR-Wert Scan von bis zu 15 Minuten, gefolgt von einer 15-minütigen Abkühlphase (kann bis zu dreimal in einer einzigen Bildgebungssitzung wiederholt werden)
MR-Bild-Artefakt	Es wird nicht erwartet, dass das Vorhandensein dieses Implantats ein Bildartefakt erzeugt, das sich weiter als 108 mm erstreckt
Zusätzliche Anweisungen oder Informationen, die für die sichere Verwendung in der MR-Umgebung wichtig sind	* Prüfen Sie alle Komponenten der Hüftkonstruktion auf zusätzliche MR-Kennzeichnungsinformationen

ENTSORGUNG

Alle verwendeten Produkte gemäß den örtlich gültigen Verfahren und Richtlinien sicher entsorgen.

BEDEUTUNG DER SYMBOLE

D/DP

DEPUY



Artikelnummer



Chargencode



Achtung



Gebrauchsanweisung
lesen



www.e-IFU.com
US / Canada 800-255-2500
EU: +800 888 2020
EU: +32 2 4037222

e-IFU-Website



Hersteller



Verwendbar bis



Steril



Durch Bestrahlung
sterilisiert



Nicht resterilisieren



Bei beschädigter
Verpackung nicht
verwenden



Nicht wiederverwenden



Bedingt MR-sicher



Verpackungseinheit



Konstruktionsmaterial(ien)



Medizinprodukt



Doppeltes
Sterilbarrieresystem



Wiederverwertbar



RT / LT

Rechts/Links



Hergestellt in

S

Rostfreier Stahl

SIZE/SZ/DIA/IN/ft/DEG/GRP/lb/OD/ID

Größe/Größe/Durchmesser/Zoll/Fuß/Grad/Gruppe/Pfund/
Außendurchmesser/Innendurchmesser

Prótesis de cadera CORAIL Cemented

INFORMACIÓN IMPORTANTE – Leer antes de usar

Es posible que algunos productos no tengan licencia en todas las jurisdicciones.



STERILE

Consulte la etiqueta del producto sobre el método

Sitio web de las instrucciones de uso

Para acceder a las instrucciones de uso electrónicas y a otros idiomas, visite www.e-IFU.com

Tarjeta de implante, folleto de información para el paciente (PIL, por sus siglas en inglés) y sitio web

La tarjeta del implante (y la etiqueta de la tarjeta del implante) se incluye en el paquete junto con el implante. La información incluida en el prospecto del paciente se basa en la información de estas instrucciones de uso. El prospecto electrónico para el paciente puede encontrarse en el sitio web que figura abajo.

Para acceder al prospecto para el paciente electrónico, visite www.ic.jnjmedicaldevices.com

ADVERTENCIA: Las leyes federales de los EE. UU. restringen la venta de este dispositivo únicamente a médicos o bajo prescripción facultativa

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO:

Este es un vástago de cadera femoral de metal. Una prótesis total de cadera se compone de un vástago de cadera femoral de metal envasado individualmente, una cabeza femoral modular de metal o cerámica y componentes acetabulares de 2 piezas de polietileno de peso molecular ultraalto (UHMWPE, por sus siglas en inglés) con revestimiento de metal, cerámicos o completamente de UHMWPE diseñados para reemplazar la superficie articular natural de la articulación de la cadera.

MATERIALES

La información que se proporciona a continuación incluye las sustancias del implante. Es posible que haya presentes sustancias residuales adicionales provenientes del proceso de fabricación. Póngase en contacto con la dirección que aparece a continuación para obtener más información.

Ejemplo de acrónimo utilizado en la(s) etiqueta(s):	Descripción del material:	El material contiene en principio las siguientes sustancias:
S1	Aleación de acero inoxidable	Hierro (63 %) Cromo (21 %) Níquel (10 %) Manganeso (3 %) Molibdeno (3 %) Menos de un 1 % de niobio y nitrógeno

CÓMO SE SUMINISTRA

Estos productos se envasan individualmente y se suministran ESTÉRILES. No los retire del envase utilizando una técnica aséptica aceptada hasta haber determinado el tamaño correcto. No utilice estos componentes si el envase estéril parece dañado o abierto accidentalmente.

USUARIO PREVISTO

Usuario previsto

Únicamente debe usar estos productos sanitarios el personal cualificado. Es esencial que cada cirujano y miembro del personal del quirófano esté totalmente familiarizado con la técnica quirúrgica adecuada para el implante y los instrumentos relacionados.

Uso previsto: prótesis total de cadera

La artroplastia total de cadera está diseñada para reemplazar la articulación de la cadera dañada en pacientes en los que hay evidencia de suficiente hueso sano para asentar y sostener los componentes.

ADVERTENCIA: Utilice únicamente cabezas femorales modulares de DePuy y componentes acetabulares de DePuy con vástagos femorales modulares de DePuy. El tamaño del cono de la cabeza femoral DEBE coincidir con el tamaño del cono del vástago femoral.

Componentes cementados

Este vástago femoral marcado como “Solo para uso cementado” está diseñado para usarse con cemento óseo.

Población de pacientes

La población objetivo de pacientes son los esqueléticamente maduros en los que hay evidencia de suficiente hueso sano para asentar y sostener los componentes.

INDICACIONES

La artroplastia total de cadera está indicada en las siguientes condiciones:

1. Una articulación con dolor intenso y/o artrítica (generalmente, debido a enfermedad articular degenerativa no inflamatoria)
2. Cirugía de cadera anterior fallida
3. Fractura aguda de cabeza o cuello femorales

CONTRAINDICACIONES

1. Infección local o sistémica activa.
2. Pérdida de musculatura, compromiso neuromuscular o deficiencia vascular en la extremidad afectada que hagan que el procedimiento no esté justificado.
3. Calidad ósea deficitaria, como osteoporosis, en la que, según la opinión del cirujano, se podría producir un desplazamiento importante de la prótesis o existir una probabilidad alta de fractura de la diáfisis femoral y/o falta de masa ósea suficiente para soportar el implante o los implantes.
4. Enfermedad de Charcot o enfermedad de Paget.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Nunca deben utilizarse juntos implantes y componentes de prueba de diferentes fabricantes o sistemas de implantes.
- Nunca deben reimplantarse los componentes de prótesis de cadera. Aunque el implante no parezca estar dañado, es posible que el implante haya desarrollado imperfecciones microscópicas que podrían provocar fallos.
- Utilice siempre una prótesis de prueba para fines de prueba. Las pruebas no deben ensamblarse con ningún componente destinado a la implantación permanente. Las pruebas deben tener el mismo tamaño de configuración, etc., que los componentes correspondientes que van a ser implantados de forma permanente.
- Los dispositivos de un solo uso fabricados por DePuy no se han diseñado para resistir ningún tipo de alteración, como desmontarlos, limpiarlos o reesterilizarlos, después de utilizarlos en un solo paciente. La reutilización puede afectar al funcionamiento del dispositivo y a la seguridad del paciente.
- No altere ni modifique los implantes de ningún modo.

- Una reserva ósea de calidad es fundamental para garantizar la fijación del dispositivo. Considere el injerto óseo y otras técnicas de refuerzo, especialmente al realizar una cirugía de revisión, para asentar y sostener el dispositivo.

PRECAUCIÓN: Las siguientes condiciones, de manera única o simultánea, tienden a imponer una carga intensa en la extremidad afectada, lo que coloca al paciente en un mayor riesgo de fracaso de la artroplastia de cadera:

1. Obesidad o peso excesivo del paciente.
2. Trabajo manual.
3. Participación en deportes de exigencia de moderada a alta.
4. Altos niveles de actividad del paciente.
5. Probabilidad de caídas.
6. Abuso de alcohol o drogas.
7. Otras discapacidades, según corresponda.

PRECAUCIÓN: Las siguientes condiciones, de forma única o simultánea, tienden a afectar negativamente la fijación de los implantes de artroplastia de cadera:

1. Osteoporosis marcada o reserva ósea deficiente.
2. Trastornos metabólicos o tratamientos farmacológicos sistémicos que conducen a un deterioro progresivo del soporte óseo sólido para el implante (por ejemplo, diabetes mellitus, tratamientos con esteroides, tratamientos inmunodepresores, etc.).
3. Historial de infecciones generales o locales.
4. Deformidades graves que provocan una fijación deficiente o un posicionamiento inadecuado del implante.
5. Tumores de las estructuras óseas de soporte.
6. Reacciones alérgicas a los materiales del implante (por ejemplo, cemento óseo, metal).
7. Reacciones de los tejidos a la corrosión del implante o restos del desgaste del implante.
8. Discapacidades de otras articulaciones (p. ej., rodillas y tobillos).

NOTA: En la actualidad, la diabetes no se ha establecido como contraindicación. Sin embargo, debido al mayor riesgo de complicaciones como infecciones, cicatrización lenta de heridas, etc., el médico debe considerar cuidadosamente la conveniencia de una artroplastia de cadera en el paciente con diabetes grave.

El tratamiento quirúrgico y posoperatorio del paciente debe llevarse a cabo teniendo en cuenta todas las condiciones existentes. Las actitudes o los trastornos mentales que provoquen que el paciente no cumpla las órdenes

del cirujano pueden retrasar la recuperación posoperatoria y/o aumentar el riesgo de efectos adversos, incluidos el fallo del implante o de la fijación del mismo.

La actividad física excesiva o el traumatismo en la articulación reemplazada pueden contribuir a un fallo prematuro de la artroplastia de cadera al causar un cambio de posición, fractura y/o desgaste de los implantes.

BENEFICIOS CLÍNICOS ESPERADOS

PRÓTESIS TOTAL DE CADERA

Se espera que la artroplastia total de cadera aumente la movilidad del paciente y reduzca el dolor mediante el reemplazo de la articulación de la cadera dañada en pacientes esqueléticamente maduros en los que hay evidencias de suficiente hueso sano para asentar y sostener los componentes.

RESUMEN DE SEGURIDAD Y RENDIMIENTO CLÍNICO

Algunos países o regiones cuentan con registros de la artroplastia de cadera que supervisan el rendimiento de los implantes de cadera. Los datos de estos registros se analizaron y muestran que, por lo general, la primera artroplastia total de cadera de una persona tiene una duración superior a 10 años en el 95 % (95 de cada 100) de los casos. Esto significa que a los 10 años aproximadamente el 5 % (5 de cada 100) de los pacientes puede precisar operaciones adicionales para la extracción de una o varias piezas. En el caso de una revisión de la artroplastia de cadera, el 80 % suele durar más de 10 años. Este dispositivo cumple con esta vida útil del implante. El riesgo de operaciones adicionales de un paciente individual dependerá de los factores específicos del paciente, como su anatomía, estado de salud y estilo de vida (por ejemplo, peso y nivel de actividad), el procedimiento quirúrgico y el proceso.

Puede encontrar un resumen de seguridad y rendimiento clínico específico del dispositivo en el siguiente enlace:
<http://ec.europa.eu/tools/eudamed>

Nota: El enlace de Eudamed solo estará disponible después de que la base de datos de Eudamed entre en funcionamiento.

Notificación de incidentes graves

Los incidentes graves que se hayan producido en relación con el producto deberán comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que residan el usuario o paciente.

Un incidente grave es cualquier incidente que, directa o indirectamente, haya provocado, podría haber provocado o podría provocar cualquiera de las situaciones siguientes:

- a) la muerte de un paciente, un usuario u otra persona,
- b) el deterioro grave temporal o permanente del estado de salud de un paciente, un usuario u otra persona,
- c) una grave amenaza para la salud pública.

INFORMACIÓN DE USO

Preoperatorio

EL CIRUJANO DEBE COMENTAR TODAS LAS LIMITACIONES FÍSICAS Y MENTALES CONCRETAS DEL PACIENTE Y TODOS LOS ASPECTOS DE LA CIRUGÍA Y LAS PRÓTESIS CON EL PACIENTE ANTES DE LA CIRUGÍA. La conversación debe incluir las limitaciones y las posibles consecuencias de la artroplastia articular, la necesidad de seguir las instrucciones del cirujano en la fase posoperatoria y la información proporcionada en el prospecto para el paciente.

La planificación preoperatoria y las técnicas quirúrgicas para la implantación de estos componentes de reemplazo de cadera evolucionaron a partir de la experiencia quirúrgica adquirida durante el desarrollo de muchas prótesis de cadera. Los cirujanos no deben comenzar el uso clínico de ninguna prótesis de cadera sin antes haberse familiarizado completamente con su técnica de implantación específica. Hay folletos de técnicas quirúrgicas disponibles a través de DePuy.

Intraoperatorio

Se recomienda que los componentes de al menos un tamaño más grande y un tamaño más pequeño que los que se determinaron preoperatoriamente estén disponibles en el momento de la intervención quirúrgica para permitir la selección intraoperatoria del tamaño apropiado.

Las cubiertas protectoras deben dejarse colocadas hasta que los componentes estén listos para su implantación. No utilice componentes si se han caído o han impactado contra una superficie dura. Es posible que el daño del componente no sea visible, pero podría causar un fallo prematuro de la prótesis. Los instrumentos quirúrgicos identificados en la técnica quirúrgica están diseñados para este procedimiento de artroplastia y se deben usar como se muestra en el folleto de técnica quirúrgica. Antes de implantar una cabeza femoral de cerámica, el cono macho del vástago femoral debe limpiarse de cualquier resto de sangre, fragmentos óseos u otros materiales extraños. Un material extraño entre la cabeza y el cono del vástago femoral puede impedir el asentamiento adecuado de la cabeza en el vástago. Esto podría afectar al funcionamiento de la cabeza femoral o al mecanismo de bloqueo entre la cabeza y el vástago femoral.

Al realizar una cirugía de revisión, es imperativo que se retire en su totalidad cualquier membrana fibrosa que encapsule la prótesis fallida.

Las membranas fibrosas residuales pueden interferir en la fijación del implante. Revise los dispositivos preexistentes para detectar daños en las superficies de contacto que impidan el asentamiento o bloqueo adecuados del nuevo dispositivo. La selección, la colocación o el posicionamiento incorrectos de los implantes pueden dar lugar a condiciones de tensión inusuales y una reducción posterior de la vida funcional del implante. Tenga en cuenta que un vástago femoral colocado en varo aumenta la tensión sobre la corteza femoral medial proximal y puede provocar el aflojamiento del implante. Antes del cierre, el lecho quirúrgico debe limpiarse a fondo de fragmentos óseos, cemento óseo extraño, hueso ectópico, etc. Las partículas extrañas en las interfaces de metal/plástico, cerámica/plástico o cerámica/cerámica pueden causar un desgaste excesivo. La amplitud de movimiento debe revisarse minuciosamente para detectar un acoplamiento inadecuado, inestabilidad o impacto y corregirse según corresponda.

Posoperatorio

Es sumamente importante que el paciente siga estrictamente las instrucciones y advertencias del cirujano. Deben seguirse las prácticas aceptadas en los cuidados posoperatorios.

El paciente debe ser dado de alta del hospital con instrucciones y advertencias escritas completas sobre ejercicios y tratamientos y cualquier limitación en sus actividades. La colocación incorrecta de los componentes o el uso de una cadera constreñida o una cadera total con una cabeza modular con faldón o camisa cónica pueden disminuir el rango de movimiento de la articulación y puede aumentar el potencial de desgaste, pinzamiento, dislocación prematura o revisión de los componentes. En estos casos, el cirujano debe informar al paciente que deben evitarse las actividades de alto rango de movimiento.

Se recomienda un seguimiento periódico continuo del paciente debido a la vida útil funcional desconocida del implante en el paciente específico, particularmente con respecto al mantenimiento de la fijación del implante y las superficies de apoyo. Deben realizarse investigaciones radiológicas en cada seguimiento y compararse con las investigaciones radiológicas anteriores y correlacionarse con la evaluación clínica del paciente. Si se observa cualquier cambio radiológico, como la aparición de radiotransparencias, resorción ósea o cualquier cambio en la posición de un implante, estos cambios deben supervisarse de cerca para determinar si son estáticos o progresivos y tratar al paciente adecuadamente.

ACONTECIMIENTOS ADVERSOS Y COMPLICACIONES

A continuación, se presentan los acontecimientos adversos y complicaciones observados con mayor frecuencia en la artroplastia de cadera:

General

La incidencia y la gravedad de las complicaciones en la artroplastia de cadera suelen ser mayores en las revisiones que en las operaciones primarias. Los problemas frecuentes que se encuentran en la cirugía de revisión pueden incluir dificultad en la colocación de la incisión, la extracción de hueso ectópico y cemento óseo viejo, la colocación y fijación de los componentes, y/o la obtención de un soporte óseo adecuado. En general, se puede esperar un mayor tiempo operativo, pérdida de sangre y riesgo de infección, embolia pulmonar y hematoma de la herida con los procedimientos de revisión.

1. Cambio de posición de los componentes protésicos, a menudo relacionado con los factores enumerados en ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES.
2. Aflojamiento temprano o tardío de los componentes protésicos, a menudo relacionado con los factores enumerados en ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES.
3. Fractura por fatiga del vástago femoral, a menudo relacionada con los factores enumerados en ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES.
4. Desgaste excesivo o rotura de los componentes de carga debido a daño intraoperatorio a los componentes protésicos, cemento suelto, fragmentos óseos, partículas metálicas, partículas cerámicas u otros factores enumerados en ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES.
5. Infección temprana o tardía.
6. Neuropatías periféricas. También puede producirse daño nervioso subclínico como consecuencia de un traumatismo quirúrgico.
7. Reacciones tisulares, osteólisis y/o aflojamiento del implante causados por la corrosión del metal, reacciones alérgicas, desgaste o restos de partículas (como cemento suelto o partículas metálicas, de polietileno o de cerámica).
8. Dolor residual en la cadera.

Intraoperatorio

1. Perforación, fisura o fractura de la diáfisis femoral, que pueden requerir el uso de una fijación interna.
2. Fractura trocantérea.
3. Daño a los vasos sanguíneos (por ejemplo, arteria ilíaca, obturatriz y femoral).
4. Daño nervioso temporal o permanente (por ejemplo, nervio femoral, obturador o peroneo aislado).
5. Subluxación o luxación de la articulación de la cadera debido al tamaño del implante o la selección de la configuración, el posicionamiento de los componentes y/o la laxitud muscular y del tejido fibroso.

6. Alargamiento o acortamiento de la extremidad afectada.
7. Retraso quirúrgico.

Posoperatorio inicial

1. Trastornos cardiovasculares, incluidos trombosis venosa, embolia pulmonar e infarto de miocardio.
2. Hematoma y/o retraso en la cicatrización de heridas.
3. Subluxación o luxación.
4. Disociación de componentes modulares.

Posoperatorio tardío

1. Avulsión del trocánter por tensión muscular excesiva, carga de peso o debilitamiento intraoperatorio accidental del trocánter.
2. Agravamiento de problemas en las articulaciones de la rodilla y el tobillo homolaterales o contralaterales debido a la discrepancia en la longitud de las piernas, la medialización femoral y/o las deficiencias musculares.
3. Fractura de fémur debido a traumatismo o carga excesiva, particularmente en presencia de una reserva ósea deficiente causada por osteoporosis grave, defectos óseos de cirugías previas, procedimientos de fresado intraoperatorio o resorción ósea.
4. Resorción ósea que puede contribuir al deterioro de la fijación y un eventual aflojamiento del implante.
5. Disminución de la movilidad articular y la amplitud de movimiento (p. ej., quizá causada por una calcificación u osificación periarticular).
6. Artrosis traumática de la rodilla homolateral secundaria al posicionamiento intraoperatorio, de la extremidad durante la cirugía.
7. Subluxación o luxación.
8. Disociación de componentes modulares.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA RM

Información de seguridad de la RM Un paciente con el dispositivo DePuy CORAIL Cemented puede someterse a exploración en las siguientes condiciones. El incumplimiento de estas condiciones puede provocar lesiones al paciente.	
Nombre/identificación del dispositivo	Prótesis de cadera CORAIL Cemented

Valor(es) nominal(es) del campo magnético estático [T]	1,5 T o 3,0 T
Gradiente de campo espacial máximo [T/m y gauss/cm]	30 T/m (3000 gauss/cm)
Excitación de RF	Polarización circular (PC)
Tipo de bobina de transmisión por RF	Bobina de transmisión de cuerpo entero, bobina de transmisión-recepción por RF de la cabeza
Modo de funcionamiento	Modo de funcionamiento normal
SAR máxima de cuerpo entero	2,0 W/kg (modo de funcionamiento normal)
SAR máxima de cabeza	El uso de una bobina de cabeza no es necesario para explorar la cadera
Límites en la duración de la exploración	Velocidad de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés) promedio de cuerpo entero de 2,0 W/kg Realice una exploración de hasta 15 minutos seguida de un periodo de enfriamiento de 15 minutos (puede repetirse hasta tres veces en una sola sesión de imagen clínica)
Artefacto de imagen de RM	No se espera que la presencia de este implante produzca un artefacto de imagen que se extienda más de 108 mm.
Instrucciones adicionales o información esencial para un uso seguro en el entorno de RM	Compruebe todos los componentes de la prótesis de cadera para obtener información del etiquetado adicional de RM.

ELIMINACIÓN

Elimine de forma segura todos los dispositivos usados de conformidad con los procedimientos y las directrices locales.

INTERPRETACIÓN DE SÍMBOLOS

D/DP

DEPUY



Precaución



Fabricante

REF

Número de catálogo



Consulte las instrucciones de uso

LOT

Código de lote



Sitio web de las instrucciones de uso electrónicas



Fecha de caducidad

Sterile

Estéril

Sterile R

Esterilizado mediante irradiación



No reesterilizar



No utilizar si el embalaje está dañado



No reutilizar



Compatible con determinadas condiciones de RM



Unidad de envasado

MATERIAL

Materiales de fabricación

MD

Producto sanitario



Sistema de doble barrera estéril



Reciclable



RT / LT

Derecha/izquierda

MADE IN

Fabricado en

S

Acero inoxidable

SIZE/SZ/DIA/IN/ft/DEG/GRP/lb/OD/ID

Tamaño/tamaño/diámetro/pulgadas/pies/grados/grupo/libras/diámetro exterior/diámetro interior

CORAIL Cemented -lonkkaproteesi

TÄRKEÄÄ – Lue ennen käyttöä

Jotkin tuotteet eivät ehkä ole lisensoituja kaikilla lainkäyttöalueilla.

**STERILE****Katso menetelmä tuotemerkinnöistä**

Käyttöohjeet (IFU) -verkkosivusto

Sähköinen käyttöohje ja käyttöohjeet muilla kielillä ovat saatavissa osoitteessa www.e-IFU.com

Implanttikortti, pakkausseloste (PIL) ja verkkosivusto

Implanttikortti (ja implanttikortin etiketti) toimitetaan pakkauksessa implantin mukana. Pakkausselosteen (PIL) tiedot perustuvat näiden käyttöohjeiden tietoihin. Sähköinen pakkausseloste on saatavilla alla olevassa verkkosivustossa.

Sähköiset tuotetiedot (ePIL) voi lukea osoitteessa www.ic.jnjmedicaldevices.com

HUOMIO: Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tämän laitteen saa myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksellä.

LAITTEEN KUVAUS

Tämä on metallinen reisiluun lonkkavarsi. Lonkan kokoproteesi koostuu yksittäin pakatusta metallisesta reisiluun lonkkavarresta, modulaarisesta metallisesta tai keraamisesta reisiluupäästä ja 2 osan metallitaustaisesta UHMWPE-polyeteeni-, keramiikka- tai täysin UHMWPE-valmisteisesta lonkkamaljakomponentista, jotka on suunniteltu korvaamaan lonkkanivelen luonnollinen nivelpinta.

MATERIAALIT

Alla olevissa tiedoissa luetellaan implantin sisältämät aineet. Valmistusprosessista johtuen tuotteessa voi olla jäämiä muista aineista. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä alla olevaan osoitteeseen.

Esimerkki merkinnöissä käytetyistä lyhenteistä:	Materiaalin kuvaus:	Materiaali sisältää nimellisesti seuraavia aineita:
S1	Ruostumaton terässeos	Rauta (63 %) Kromi (21 %) Nikkeli (10 %) Mangaani (3 %) Molybdeeni (3 %) Alle 1 % niobiumia ja typeä

TOIMITUSTAPA

Nämä laitteet on pakattu yksittäin ja toimitetaan STERIILEINÄ. Poista pakkauksesta käyttämällä hyväksyttyä aseptista menetelmää vasta, kun oikea koko on määritetty. Älä käytä näitä komponentteja, jos steriili pakkaus vaikuttaa vaurioituneelta tai se on auennut tahattomasti.

KÄYTTÖTARKOITUS

Suunniteltu käyttäjä

Vain pätevä henkilökunta saa käyttää näitä laitteita. On olennaisen tärkeää, että kirurgi ja leikkaussalihenkilökunta tuntevat implanttiin liittyvän asianmukaisen leikkaustekniikan sekä käytettävät instrumentit.

Käyttötarkoitus – lonkan kokoproteesi

Koko lonkan proteesileikkauksessa korvataan potilaan vaurioitunut lonkkanivelen nivelliitos, kun on näyttöä siitä, että luu on riittävän terve komponenttien asentamiseen ja tukemiseen.

VAROITUS: Käytä vain DePuy:n modulaarisia reisiluun päitä ja DePuy:n lonkkamaljakomponentteja DePuy:n modulaaristen reisiluun varsien kanssa. Reisiluun pään kapenevan koon PITÄÄ vastata reisiluun varren kapenevaa kokoa.

Sementoidut komponentit

Tämä reisiluun varsi, jossa on merkintä "Vain sementoituun käyttöön", on tarkoitettu käytettäväksi luusementin kanssa.

Potilaspopulaatio

Toimenpide on tarkoitettu luustoltaan kehittyneille potilaille, kun on näyttöä siitä, että luu on riittävän terve komponenttien asentamiseen ja tukemiseen.

KÄYTTÖAIHEET

Lonkan kokotekonivel on tarkoitettu seuraaviin tapauksiin:

1. vaikeasti kivulias ja/tai niveltulehduksellinen nivel (tavallisesti ei-tulehduksellisen nivelrikon vuoksi)
2. aiempi epäonnistunut lonkkaleikkaus
3. akuutti reisiluun pään tai kaulan murtuma.

VASTA-AIHEET

1. aktiivinen paikallinen tai systeeminen infektio
2. lihaksiston heikkous, neuromuskulaarinen vajavaisuus tai raajan vaskulaarinen heikkous, joka tekee toimenpiteen perusteettomaksi
3. heikko luun laatu, esimerkiksi osteoporoosi, joka kirurgin arvion mukaan saattaa aiheuttaa proteesin huomattavan siirtymisen tai merkittävän murtumismahdollisuuden reisiluun varteen, ja/tai riittämätön luuaines implantin (implanttien) tukemiseen
4. Charcot'n tai Pagetin tauti.

VAROITUKSET JA VAROTOIMET

- Eri valmistajien tai implanttijärjestelmien implantteja ja koekomponentteja ei saa koskaan käyttää yhdessä.
- Lonkkaproteesin komponentteja ei pidä koskaan implantoida uudelleen. Vaikka implantti vaikuttaisi vahingoittumattomalta, siihen on voinut kehittyä mikroskooppisia vikoja, jotka voivat aiheuttaa toimintahäiriön.
- Käytä aina koepteesia kokeilutarkoituksiin. Koekomponentteja ei saa yhdistää mihinkään pysyvään implantointiin tarkoitettuihin komponentteihin. Koekomponenttien määrityskoon jne. on oltava samat kuin pysyvästi implantoitavissa komponenteissa.
- DePuyn valmistamia kertakäyttöisiä laitteita ei ole suunniteltu yhdelle potilaalle käyttämisen jälkeen kestämään minkäänlaista muuntelua, kuten purkamista, puhdistamista tai uudelleensterilointia. Laitteen uudelleenkäyttö voi vaarantaa laitteen toimivuuden ja potilaan turvallisuuden.
- Implantteja ei saa muuttaa tai muunnella millään tavalla.
- Laadukas luukanta on kriittisen tärkeä tekijä laitteen kiinnittymisen kannalta. Harkitse luunsirtoa ja muita tukimenetelmiä laitteen asentamiseen ja tukemiseen, etenkin korjausleikkauksia tehtäessä.

HUOMIO: Seuraavilla tekijöillä on yksin tai samanaikaisesti esiintyessään tapana aiheuttaa vaikeaa kuormitusta kohteena olevaan raajaan, mikä suurentaa potilaan lonkan tekonivelleikkauksen epäonnistumisen riskiä:

1. potilaan liikalihavuus tai ylipaino
2. manuaalinen työ
3. kohtalaisen ja raskaan liikunnan harrastaminen

4. potilaan huomattava aktiivisuus
5. kaatumisen todennäköisyys
6. aktiivinen alkoholin tai huumeiden väärinkäyttö
7. muut mahdolliset vammat.

HUOMIO: Seuraavilla tekijöillä on yksin tai samanaikaisesti esiintyessään tapana vaikuttaa haitallisesti lonkan tekonivelimplanttien kiinnittymiseen:

1. merkittävä osteoporoosi tai heikko luukanta
2. aineenvaihduntahäiriöt tai systeemiset lääkähoidot, jotka aiheuttavat etenevää implantin kiinteän luutuen heikentymistä (esim. diabetes mellitus, steroidihoito, immunosuppressiiviset hoidot jne.)
3. aiemmat yleiset tai paikalliset infektiot
4. vaikeat epämuodostumat, jotka johtavat implantin heikentyneeseen kiinnittymiseen tai virheelliseen sijoittamiseen
5. tukevien luurakenteiden kasvaimet
6. implanttimateriaalien (esim. luusementti, metalli) aiheuttamat allergiset reaktiot
7. implantin korroosion tai implantin kulumisjäämien aiheuttamat kudokset
8. muiden nivelten (esim. polvet ja nilkat) vammat.

HUOMAUTUS: Diabetesta ei tällä hetkellä määritetä vasta-aiheeksi. Komplikaatioiden, kuten infektioiden, haavojen hitaan paranemisen jne., suurentuneen riskin vuoksi lääkärin on kuitenkin harkittava huolellisesti lonkan tekonivelen suositeltavuutta vaikeasti diabeettisten potilaiden kohdalla.

Potilaan kirurgisessa ja leikkauksenjälkeisessä hoidossa on otettava huomioon kaikki olemassa olevat tilat. Asenteet tai mielenterveyden häiriöt, joiden vuoksi potilas ei noudata kirurgin ohjeita, voivat viivästyttää leikkauksenjälkeistä paranemista ja/tai suurentaa haittavaikutusten, kuten implantin tai sen kiinnityksen vika, riskiä.

Liika aktiivisuus tai tekonivelen vamma voivat osaltaan aiheuttaa lonkan tekonivelen ennenaikaisen toimintahäiriön aiheuttamalla implanttien asennon muutoksen, murtuman ja/tai kuluman.

ODOTETTAVISSA OLEVAT KLIINiset HYÖDYt LONKAN KOKOPROTEESI

Lonkan tekonivelleikkauksen odotetaan parantavan potilaan liikkuvuutta ja vähentävän kipua, kun luustoltaan kehittyneiden potilaiden vaurioitunut lonkkanivelen nivelliitos korvataan, jos on näyttöä riittävän terveestä luusta komponenttien asentamiseen ja tukemiseen.

TURVALLISUUTTA JA KLIINISTÄ TOIMIVUUTTA KOSKEVA YHTEENVETO

Joissakin maissa tai joillakin alueilla on lonkan tekonivelrekistereitä, jotka seuraavat lonkkaimplanttien toimivuutta. Tämän rekisterin tiedot analysoitiin, ja ne osoittivat, että henkilön ensimmäinen lonkan kokotekonivelleikkaus kestää yleisesti ottaen 95 %:ssa tapauksista (95/100) yli 10 vuotta. Tämä tarkoittaa, että 10 vuoden kuluttua noin 5 %:lla (5/100) potilaista on voinut olla lisäleikkauksia, joissa osia on poistettu. Korjausleikatuista lonkan tekonivelistä yleensä 80 % kestää yli 10 vuotta. Tämä laite täyttää tämän implantin odotetun käyttöiän. Yksittäisen potilaan lisäleikkausten riski vaihtelee potilaskohtaisten tekijöiden, kuten anatomian, terveydentilan ja elämäntapojen (esim. paino ja aktiivisuustaso), sekä kirurgisen toimenpiteen ja prosessin mukaan.

Laitekohtaiseen turvallisuutta ja kliinistä toimivuutta koskevaan yhteenvetoon pääsee seuraavan linkin kautta: <http://ec.europa.eu/tools/eudamed>

Huomautus: Eudamed-linkki on käytettävissä vasta, kun Eudamed-tietokanta on aktiivinen.

Vakavista vaaratilanteista ilmoittaminen

Kaikista laitteeseen liittyvistä vakavista tapahtumista on ilmoitettava valmistajalle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käyttäjä ja/tai potilas on.

Vakavalla tapahtumalla tarkoitetaan mitä tahansa tapahtumaa, joka suoraan tai epäsuorasti johti, on saattanut johtaa tai saattaa johtaa johonkin seuraavista:

- a) potilaan, käyttäjän tai muun henkilön kuolema
- b) potilaan, käyttäjän tai muun henkilön terveydentilan tilapäinen tai pysyvä vakava heikkeneminen
- c) vakava kansanterveyden uhka.

TIETOA KÄYTÖSTÄ

Ennen leikkausta

KIRURGIN TULEE KESKUSTELLA KAIKISTA POTILASTA KOSKEVISTA FYYSISISTÄ JA HENKISISTÄ RAJOITTEISTA JA KAIKISTA LEIKKAUKSEN JA PROTEESIN PUOLISTA POTILAAN KANSSA ENNEN LEIKKAUSTA. Keskustelun tulisi sisältää nivelen korvaamisen rajoitukset ja mahdolliset seuraukset, kirurgin ohjeiden noudattaminen leikkauksen jälkeen ja potilasselosteessa annetut tiedot.

Leikkausta edeltävä suunnittelu ja näiden lonkan tekonivelkomponenttien kirurgiset implantointimenetelmät on kehitetty useiden lonkkaproteesien kehityksen aikana saadun kirurgisen kokemuksen perusteella. Kirurgien ei pidä aloittaa minkään lonkkaproteesin kliinistä käyttöä, ennen kuin he ovat tutustuneet perusteellisesti kyseisen proteesin implantointimenetelmään. Kirurgisia menetelmiä esittelevät esitteet ovat saatavilla DePuy-yhtiöltä.

Leikkauksen aikana

Leikkauksessa on suositeltavaa pitää saatavilla vähintään yhtä kokoa suurempia ja pienempiä komponentteja ennen leikkausta määritettyjen komponenttien lisäksi, jotta sopivan koon valintaa voidaan mukauttaa leikkauksen aikana.

Suojakuoret tulee jättää komponentteihin, kunnes ne ovat valmiita implantoitaviksi. Älä käytä komponentteja, jos ne ovat pudonneet tai ne ovat osuneet kovaan pintaan. Komponentin vaurioituminen ei välttämättä näy, mutta se voi aiheuttaa proteesin ennenaikaisen toimintahäiriön. Kirurgisessa menetelmässä määritellyt kirurgiset instrumentit on suunniteltu tässä kuvattuun tekonivelleikkaukseen, ja niitä on käytettävä kirurgisen menetelmän esitteen mukaisesti. Ennen keraamisen reisiluun pään implantointia reisiluun varren uroskartio on pyyhittävä puhtaaksi verestä, luusiruiista ja muista vierasmateriaaleista. Pään ja reisiluun varren kartion välissä oleva vierasmateriaali voi haitata pään asianmukaista asentamista varten. Tämä voi vaikuttaa reisiluun pään tai reisiluun pään ja reisiluun varren välisen lukitusmekanismin toimintaan.

Korjausleikkauksen aikana on välttämätöntä, että viallista proteesia mahdollisesti ympäröivä sidekudoskalvo poistetaan kokonaan. Jäljelle jäävät sidekudoskalvot voivat haitata implantin kiinnittymistä. Tarkista mahdolliset aiemmat laitteet sellaisten liitospintojen vaurioiden varalta, jotka voisivat estää uuden laitteen riittävän kiinnittymisen tai lukittumisen. Implanttien virheellinen valinta, asetus tai sijoitus voi aiheuttaa epätavallista räsytystä ja implantin käyttöiän lyhenemisen. Huomaa, että varus-asentoon asetettu reisiluun pää lisää proksimaaliseen, mediaaliseen reisiluun kuoreen kohdistuvaa räsytystä ja voi johtaa implantin löystymiseen. Ennen kuin leikkauskohta suljetaan, se on puhdistettava perusteellisesti luunsiruiista, ylimääräisestä luusementistä, ektooppisesta luusta jne. Vierashiukkaset metallisessa/muovisessa, keraamisessa/muovisessa tai keraamisessa/keraamisessa liitoskohdassa voivat aiheuttaa liiallista kulumista. Liikelaaajuus on tarkistettava huolellisesti virheellisen liitoksen, epävakauden tai pinteän varalta ja korjattava asianmukaisesti.

Leikkauksen jälkeen

On erittäin tärkeää, että potilas noudattaa kirurgin ohjeita ja varoituksia tiukasti. Leikkauksen jälkeisessä hoidossa on noudatettava hyväksytyjä käytäntöjä.

Potilas on kotiutettava sairaalasta harjoitteita ja hoitoja sekä aktiviteettien rajoituksia koskevien kattavien kirjallisten ohjeiden ja varoitusten kanssa. Komponentin virheellinen asento tai rajoittuneen lonkan tai koko lonkan käyttö modulaarisella helmallisella päällä tai kartiomaisella holkillä voi vähentää nivelen liikerataa ja lisätä komponenttien kulumisen, pinteän,

ennenaikaisen sijoiltaanmenon tai korjaustarpeen mahdollisuutta. Näissä tapauksissa kirurgin on kerrottava potilaalle, että laajaa liikerataa edellyttävää toimintaa on vältettävä.

Potilaan jatkuva säännöllistä seurantaa suositellaan, sillä implantin toiminnallista käyttöikää kyseisellä potilaalla ei tunneta, etenkin implantin kiinnityksen ja kuormituspintojen kannalta. Jokaisen seurantakäynnin yhteydessä on suoritettava radiologisia tutkimuksia ja niitä on verrattava aiempiin radiologisiin tutkimuksiin ja korreloitava potilaan kliinisen arvioinnin kanssa. Jos havaitaan radiologisia muutoksia, kuten röntgennegatiivisuuksia, luun resorptiota tai muutoksia implantin asennossa, näitä muutoksia on seurattava tarkasti, jotta voidaan määrittää, ovatko ne staattisia vai eteneviä, ja jotta potilasta voidaan hoitaa asianmukaisesti.

HAITTATAPAHTUMAT JA KOMPLIKAATIOT

Seuraavat ovat yleisesti lonkan tekonivelleikkauksiin liittyviä yleisimmin ilmeneviä haittatapahtumia ja komplikaatioita:

Yleiset

Lonkan tekonivelleikkaukseen liittyvien komplikaatioiden esiintyvyy- ja vaikeustaso ovat yleensä korkeampia korjausleikkauksissa ensisijaisiin leikkauksiin verrattuna. Korjausleikkauksissa ilmeneviä yleisiä ongelmia voivat olla muun muassa leikkaushaavan paikan valitsemisen vaikeus, ektooppisen luun ja vanhan luusementin poisto, komponenttien sijoitus ja kiinnitys ja/tai riittävän luutuen saanti. Yleisesti ottaen pidempi leikkausaika, verenhukka ja infektioriski, keuhkoveritulppa ja haavan hematooma ovat odotettavissa olevia asioita korjaustoimenpiteissä.

1. proteesin komponenttien asennon muutos, joka liittyy usein VAROITUKSET JA VAROTOIMET -osiossa lueteltuihin tekijöihin
2. proteesin komponenttien varhainen tai myöhäinen löystyminen, joka liittyy usein VAROITUKSET JA VAROTOIMET -osiossa lueteltuihin tekijöihin
3. reisiluun varren rasitusmurtuma, joka liittyy usein VAROITUKSET JA VAROTOIMET -osiossa lueteltuihin tekijöihin
4. kantavien komponenttien liiallinen kuluminen tai murtuma, joka johtuu proteesin komponenttien leikkauksenaikaisesta vaurioitumisesta, irtonaisesta sementistä, luusiruista, metallihiukkasista, keraamisista hiukkasista tai muista VAROITUKSET JA VAROTOIMET -osiossa luetelluista tekijöistä
5. varhainen tai myöhäinen infektio
6. perifeeriset neuropatiat, myös subkliininen hermovaurio voi ilmetä kirurgisen vamman seurauksena

7. metallin korroosion, allergisten reaktioiden, kulumisen tai hiukkasjäämien (esim. irtonainen sementti, polyeteeni- tai keramiikkahiukkaset) aiheuttamat kudokset, osteolyysi ja/tai implantin löystyminen
8. jäännöskipu lonkassa.

Leikkauksen aikana

1. reisiluun varren perforaatio, fissuura tai murtuma, joka voi edellyttää sisäistä kiinnitystä
2. sarvennoisen murtuma
3. verisuonivaurio (esim. lonkka-, obturaattori ja reisivaltimo)
4. tilapäinen tai pysyvä hermovaurio (esim. reisi-, obturaattori- tai yksittäinen peroneaalinen hermo)
5. lonkkanivelen subluksaatio tai sijoiltaanmeno implantin koon tai kokoonpanon valinnan, komponenttien sijoituksen ja/tai lihas- ja sidekudoksen väljyyden vuoksi
6. kohteena olevan raajan pidennys tai lyhennys
7. leikkausviive

Varhain leikkauksen jälkeen

1. sydän- ja verisuonisairaudet, mukaan lukien laskimotromboosi, keuhkoembolia ja sydäninfarkti
2. hematooma ja/tai viivästynyt haavan paraneminen
3. subluksaatio tai sijoiltaanmeno
4. modulaaristen komponenttien irtoaminen.

Myöhään leikkauksen jälkeen

1. liiallisesta lihasjännityksestä, kuormituksesta tai sarvennoisen tahattomasta leikkauksen aikaisesta heikentymisestä johtuva sarvennoisen avulsio
2. samanpuoleisten tai vastapuolisten polvi- ja nilkkanivelten ongelmien paheneminen jalan pituuseron, reisiluun medialisaation ja/tai lihasvajavuuksien vuoksi
3. vammasta tai liiasta kuormituksesta johtuva reisiluun murtuma, etenkin vaikean osteoporoosin, aiemmasta leikkauksesta aiheutuneiden luuvikojen, leikkauksenaikaisten riimaustoimenpiteiden tai luun resorption aiheuttaman heikon luukannan yhteydessä
4. luun resorptio, joka voi osaltaan aiheuttaa implantin kiinnityksen heikentymistä ja lopulta implantin löystymistä
5. nivelen liikkuvuuden ja liikelaajuuden heikkeneminen (voi johtua esimerkiksi niveltä ympäröivästä kalkkiutumuksesta tai luutumuksesta)
6. samanpuoleisen polven traumaattinen nivelrikko, joka liittyy raajan leikkauksenaikaiseen sijoitukseen.
7. subluksaatio tai sijoiltaanmeno
8. modulaaristen komponenttien irtoaminen.

MAGNEETTIKUVAUKSEN TURVALLISUUTTA KOSKEVAT TIEDOT

Magneettikuvauksen turvallisuutta koskevat tiedot  Potilas, jolla on DePuy Corail Cemented -rakenne, voidaan kuvata seuraavilla ehdoilla. Näiden ehtojen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa potilaan loukkaantumisen.	
Laitteen nimi/tunniste	Corail Cemented -lonkkaproteesi
Staattisen magneettikentän nimellisarvo(t) [T]	1,5 T tai 3,0 T
Suurin spatiaalinen kenttägradientti [T/m ja gaussia/cm]	30 T/m (3 000 gaussia/cm)
RF-viritys	Kiertopolaroitu (CP)
RF-lähetyskelan tyyppi	Koko kehon lähetyskela, pään RF-lähetys-vastaanotokela
Käyttötila	Normaali käyttötila
Koko kehon suurin SAR	2,0 W/kg (normaali käyttötila)
Pään suurin SAR	Pääkela ei tarvitse käyttää lonkan kuvauksessa
Kuvauksen kestopärajotukset	2,0 W/kg koko kehon keskimääräinen SAR Kuvaa enintään 15 minuuttia, jonka jälkeen seuraa 15 minuutin jäähtytysjakso (voidaan toistaa enintään kolme kertaa yhdellä kuvantamiskerralla)
MR-kuva-artefakti	Tämän implantin ei odoteta tuottavan yli 108 mm:n kuva-artefaktia
Lisäohjeet tai tiedot, jotka ovat välttämättömiä turvalliselle käytölle magneettikuvauksympäristössä	*Tarkista kaikki lonkkarakenteen osat saadaksesi lisätietoa MR-merkinnöistä

HÄVITTÄMINEN

Kaikki käytetyt laitteet on hävitettävä turvallisesti paikallisten käytäntöjen ja ohjeistuksen mukaisesti.

SYMBOLIEN SELITYKSET

D/DP

DEPUY



Varoitus

REF

Luettelonumero



Lue käyttöohjeet

LOT

Eräkoodi



www.e-IFU.com
US / Canada 800-255-2500
EU: +800 8888 2020
EU: +32 2 4037222

Sähköisen käyttöohjeen
verkkosivusto



Valmistaja



Viimeinen käyttöpäivä

Sterile

Steriili

Sterile R

Steriloitu säteilytyksellä



Ei saa steriloida uudelleen



Ei saa käyttää, jos pakkaus
on vaurioitunut



Ei saa käyttää uudelleen



Ehdollisesti MR-turvallinen



Pakkausyksikkö

MATERIAL

Valmistusmateriaali(t)

MD

Lääkinnällinen laite



Kaksinkertainen steriili
estejärjestelmä



Kierrätettävä



RT / LT

Oikea/vasen

MADE IN

Valmistusmaa

S

Ruostumaton teräs

SIZE/SZ/DIA/IN/ft/DEG/GRP/lb/OD/ID

Koko/koko/halkaisija/tuumaa/jalkaa/astetta/ryhmä/
paunaa/ulkohalkaisija/sisähalkaisija

Prothèse de hanche CORAIL Cemented

INFORMATIONS IMPORTANTES – À lire avant l'utilisation

Certains produits peuvent ne pas être autorisés dans tous les pays.



STERILE

La méthode figure sur l'étiquette du produit.

Site Web du mode d'emploi

Pour accéder au mode d'emploi électronique et à d'autres langues, rendez-vous sur www.e-IFU.com

Carte de porteur d'implant, notice d'information du patient et site Web

La carte de porteur d'implant (et l'étiquette de la carte de porteur d'implant) est fournie dans l'emballage de l'implant. Les informations contenues dans la notice d'information du patient sont basées sur les informations contenues dans ce mode d'emploi. Pour accéder à la notice électronique, consulter le site Web ci-dessous.

Pour accéder à la notice électronique, rendez-vous sur www.ic.jnjmedicaldevices.com

ATTENTION : Conformément à la loi fédérale des États-Unis, ce dispositif ne peut être vendu que par un médecin ou sur ordonnance.

DESCRIPTION DU DISPOSITIF

Il s'agit d'une tige fémorale métallique. Une prothèse totale de hanche est composée d'une tige fémorale en métal emballée individuellement, d'une tête fémorale modulaire en métal ou en céramique et de composants acétabulaires en 2 parties en polyéthylène de poids moléculaire ultra élevé (UHMWPE) à metal-back, en céramique ou entièrement en UHMWPE. Elle est destinée à remplacer les surfaces articulaires naturelles de la hanche.

MATÉRIAUX

Les informations ci-dessous énumèrent les substances contenues dans l'implant. Des substances supplémentaires peuvent être présentes sous forme de traces en raison du processus de fabrication. Veuillez contacter l'adresse ci-dessous pour plus d'informations.

Exemple d'acronyme utilisé sur les étiquettes :	Description du matériau :	Le matériau contient essentiellement les substances suivantes :
S1	Alliage d'acier inoxydable	Fer (63 %) Chrome (21 %) Nickel (10 %) Manganèse (3 %) Molybdène (3 %) Moins de 1 % de niobium et d'azote

PRÉSENTATION

Ces dispositifs sont emballés individuellement et fournis STÉRILES. Retirer de l'emballage en utilisant une technique aseptique validée uniquement après que la taille correcte a été déterminée. Ne pas utiliser ces composants si l'emballage stérile semble endommagé ou accidentellement ouvert.

UTILISATION PRÉVUE

Utilisateur prévu

Ces dispositifs ne doivent pas être utilisés par du personnel non qualifié. Il est essentiel que le chirurgien ainsi que le personnel de bloc opératoire connaissent parfaitement la technique chirurgicale associée à l'implant et aux instruments correspondants.

Utilisation prévue – Prothèse totale de hanche

L'arthroplastie totale de la hanche est prévue pour remplacer l'articulation de la hanche endommagée chez des patients lorsque la qualité du capital osseux est suffisante pour implanter et soutenir les composants.

AVERTISSEMENT : Utiliser uniquement des têtes fémorales modulaires DePuy et des composants acétabulaires DePuy avec les tiges fémorales modulaires DePuy. La taille du cône de la tête fémorale DOIT correspondre à la taille du cône de la tige fémorale.

Composants cimentés

Cette tige fémorale étiquetée « Pour une utilisation cimentée uniquement » est destinée à être utilisée avec du ciment osseux.

Population de patients

Les patients concernés ont atteint la maturité squelettique et la qualité du capital osseux est suffisante pour implanter et soutenir les composants.

INDICATIONS

L'arthroplastie totale de la hanche est indiquée dans les conditions suivantes :

1. Douleurs articulaires et/ou arthrite sévère (généralement dues à une maladie articulaire dégénérative non inflammatoire)
2. Échec d'une précédente arthroplastie de hanche
3. Fracture aiguë de la tête ou du col fémoral

CONTRE-INDICATIONS

1. Infection locale ou systémique active
2. Fonte musculaire, lésion neuromusculaire ou insuffisance vasculaire dans le membre concerné rendant l'intervention injustifiée
3. Qualité osseuse insuffisante (p. ex. ostéoporose) pouvant, de l'avis du chirurgien, entraîner une migration importante de la prothèse ou un risque notable de fracture de la diaphyse fémorale et/ou de soutien osseux insuffisant pour le ou les implants
4. Maladie de Charcot ou de Paget

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

- Les implants et les composants d'essai de différents fabricants ou systèmes d'implants ne doivent jamais être utilisés ensemble.
- Les composants de prothèse de hanche ne doivent jamais être réimplantés. Même si l'implant semble intact, il peut présenter des imperfections microscopiques qui pourraient entraîner une défaillance.
- Toujours utiliser les prothèses d'essai à des fins d'essai. Les composants d'essai ne doivent pas être assemblés avec des composants destinés à une implantation permanente. Les composants d'essai doivent avoir la même taille, configuration, etc., que les composants définitifs correspondants.
- Les dispositifs à usage unique fabriqués par DePuy ne sont pas conçus pour subir ou résister à une quelconque forme d'altération (désassemblage, nettoyage, stérilisation, etc.) après utilisation sur un seul patient. Leur réutilisation est susceptible de compromettre les performances du dispositif et la sécurité du patient.
- Ne pas altérer ni modifier les implants de quelque façon que ce soit.
- Un capital osseux de bonne qualité est essentiel pour assurer la fixation du dispositif. Envisager une greffe osseuse et d'autres techniques de renforcement, en particulier dans les cas de chirurgie de révision, pour mettre en place et soutenir le dispositif.

ATTENTION : Les conditions suivantes, isolément ou conjointement, ont tendance à exercer des contraintes importantes sur le membre concerné, exposant le patient à un risque plus élevé d'échec de la prothèse de la hanche :

1. Obésité ou surpoids du patient

2. Travail manuel
3. Pratique sportive modérée à intensive
4. Activité intensive du patient
5. Probabilité de chutes
6. Abus d'alcool ou de médicaments/drogues actif
7. Autres invalidités, le cas échéant

ATTENTION : Les conditions suivantes, isolément ou conjointement, ont tendance à altérer la fixation des implants prothétiques de hanche :

1. Ostéoporose marquée ou faible capital osseux
2. Troubles métaboliques ou traitements pharmacologiques systémiques dégradant progressivement le soutien osseux solide de l'implant (p. ex. diabète sucré, corticothérapies, traitements immunosuppresseurs, etc.)
3. Antécédents d'infections générales ou locales
4. Déformations sévères altérant la fixation ou le positionnement de l'implant
5. Tumeurs des structures osseuses de soutien
6. Réactions allergiques aux matériaux d'implant (p. ex. ciment osseux, métal)
7. Réactions des tissus à la corrosion ou aux débris d'usure de l'implant
8. Handicap d'autres articulations (c.-à-d. genoux et chevilles)

REMARQUE : À ce jour, le diabète n'a pas été établi comme une contre-indication. Cependant, en raison du risque accru de complications telles qu'infection, cicatrisation lente, etc., le médecin doit soigneusement évaluer l'opportunité d'une arthroplastie de la hanche chez les patients gravement diabétiques.

La prise en charge chirurgicale et postopératoire du patient doit être effectuée en tenant compte de toutes les affections existantes. Les attitudes ou troubles mentaux entraînant le non-respect par un patient des instructions du chirurgien peuvent retarder le rétablissement postopératoire et/ou augmenter le risque d'effets indésirables, y compris d'échec de l'implant ou de sa fixation.

Une activité physique excessive ou un traumatisme de l'articulation remplacée peut contribuer à l'échec prématuré de l'arthroplastie de la hanche en provoquant un changement de position, une fracture et/ou l'usure des implants.

AVANTAGES CLINIQUES ATTENDUS PROTHÈSE TOTALE DE HANCHE

L'arthroplastie totale de la hanche vise à améliorer la mobilité et à soulager la douleur en remplaçant l'articulation de la hanche endommagée chez des patients ayant atteint la maturité squelettique lorsque la qualité du capital osseux est suffisante pour implanter et soutenir les composants.

RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ET DE PERFORMANCES CLINIQUES

Certains pays ou régions ont des registres des arthroplasties de hanche qui surveillent les performances des implants de hanche. L'analyse des données de ces registres montre que la première prothèse totale de hanche dure généralement plus de 10 ans pour 95 % des personnes (95 sur 100). Cela signifie qu'à 10 ans, environ 5 % des patients (5 sur 100) peuvent avoir subi des opérations supplémentaires pour retirer un ou plusieurs composants. En général, 80 % des arthroplasties de révision de hanche durent plus de dix ans. Ce dispositif est conforme à cette durée de vie. Le risque d'opérations supplémentaires pour un patient individuel dépendra de facteurs qui lui sont propres, tels que son anatomie, son état médical et son mode de vie (p. ex. poids et niveau d'activité), ainsi que de la procédure et du processus chirurgicaux.

Un RCSPC spécifique à un dispositif peut être consulté à l'adresse : <http://ec.europa.eu/tools/eudamed>

Remarque : Le lien Eudamed ne sera disponible qu'après la mise en ligne de la base de données Eudamed.

Déclaration d'incidents graves

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient résident.

Par incident grave, on entend tout incident qui, directement ou indirectement, a conduit, aurait pu conduire ou pourrait conduire à l'une des situations suivantes :

- a) le décès d'un patient, d'un utilisateur ou d'une autre personne,
- b) la détérioration grave, temporaire ou permanente, de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'une autre personne,
- c) une grave menace pour la santé publique.

INFORMATIONS D'UTILISATION

Avant l'opération

AVANT L'INTERVENTION, LE CHIRURGIEN DOIT S'ENTREtenir AVEC LE PATIENT ET ABORDER TOUTES SES LIMITES PHYSIQUES ET MENTALES ET TOUS LES ASPECTS DE LA CHIRURGIE ET DES PROTHÈSES. La discussion doit notamment couvrir les limites et les conséquences possibles de l'arthroplastie, la nécessité de suivre les instructions du chirurgien après l'opération et les informations fournies dans la notice patient.

La planification préopératoire et les techniques chirurgicales pour l'implantation de ces composants de prothèse de hanche ont évolué sur la base de l'expérience chirurgicale acquise au cours du développement

de nombreuses prothèses de hanche. Les chirurgiens ne doivent pas commencer l'utilisation clinique d'une prothèse de hanche avant de s'être parfaitement familiarisés avec sa technique d'implantation spécifique. Les brochures sur les techniques chirurgicales sont disponibles auprès de DePuy.

Pendant l'opération

Pendant l'intervention, il est recommandé d'avoir à disposition des composants au moins une taille plus grande et une taille plus petite que la taille déterminée au préalable pour pouvoir sélectionner la ou les tailles appropriées en peropératoire.

Les couvercles de protection doivent rester en place jusqu'au moment de l'implantation des composants. Ne pas utiliser les composants s'ils sont tombés ou s'ils ont heurté une surface dure. Les dommages peuvent ne pas être visibles, mais peuvent entraîner une défaillance prématurée de la prothèse. Les instruments chirurgicaux mentionnés dans la technique chirurgicale ont été conçus pour cette procédure d'arthroplastie et doivent être utilisés comme indiqué dans la brochure de la technique chirurgicale. Avant d'implanter une tête fémorale en céramique, le cône mâle de la tige fémorale doit être nettoyé pour éliminer parfaitement toute trace de sang, de débris osseux ou d'autres corps étrangers. La présence d'un corps étranger entre la tête et le cône de la tige fémorale peut empêcher la mise en place correcte de la tête sur la tige. Cela pourrait affecter les performances de la tête fémorale ou le mécanisme de verrouillage entre la tête et la tige fémorales.

Lors d'une chirurgie de reprise, il est impératif de retirer l'intégralité des membranes fibreuses encapsulant la prothèse défaillante. La présence de membranes fibreuses résiduelles peut entraver la fixation de l'implant. Examiner tous les dispositifs existants à la recherche d'altérations des surfaces de contact susceptibles d'empêcher la mise en place ou le verrouillage du nouveau dispositif. Une sélection, une mise en place ou un positionnement incorrect des implants peut être à l'origine de contraintes inhabituelles aboutissant à une diminution notable de la durée de vie fonctionnelle de l'implant. À noter qu'une tige fémorale placée en varus augmente les contraintes sur la corticale médiale du fémur proximal et peut conduire au descellement de l'implant. Avant la fermeture, le site chirurgical doit être soigneusement nettoyé pour éliminer les débris osseux, l'excès de ciment osseux, l'os ectopique, etc. La présence de particules étrangères à l'interface métal/plastique, céramique/plastique ou céramique/céramique peut provoquer une usure excessive. L'amplitude des mouvements doit être soigneusement vérifiée pour déceler et corriger un couplage inapproprié, une instabilité ou un conflit.

Après l'opération

Le strict respect par le patient des instructions et des mises en garde du chirurgien est extrêmement important. Les pratiques validées doivent être appliquées lors de la prise en charge postopératoire.

À sa sortie de l'hôpital, le patient doit disposer d'instructions écrites complètes et de mises en garde concernant les exercices et les traitements et les éventuelles limitations de ses activités. La mauvaise mise en place des composants ou l'utilisation d'une prothèse de hanche contrainte ou d'une prothèse totale de hanche avec une tête modulaire à jupe ou un manchon conique peut diminuer l'amplitude de mouvement de l'articulation et augmenter le risque d'usure, de frottement, de luxation prématurée ou de révision des composants. Dans ces cas, le chirurgien doit informer le patient qu'il faut éviter les activités impliquant une grande amplitude de mouvement.

Un suivi périodique continu du patient est recommandé en raison de la durée de vie fonctionnelle inconnue de l'implant chez un patient particulier, notamment en ce qui concerne le maintien de la fixation de l'implant et des surfaces de soutien. Des clichés radiographiques doivent être réalisés à chaque visite de suivi, comparés aux clichés radiographiques antérieurs et corrélés à l'évaluation clinique du patient. Si des changements radiologiques sont constatés, tels que l'apparition d'un liseré radiographique, une résorption osseuse ou tout changement de position d'un implant, ces changements doivent être étroitement surveillés pour déterminer s'ils sont stables ou évolutifs et le patient doit recevoir un traitement approprié.

ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES ET COMPLICATIONS

Les événements indésirables et complications les plus fréquemment rencontrés dans l'arthroplastie de la hanche sont généralement les suivants :

Généraux

L'incidence et la gravité des complications de l'arthroplastie de la hanche sont généralement plus importantes dans les révisions que dans les interventions de première intention. Les problèmes courants rencontrés lors de la chirurgie de révision peuvent inclure des difficultés pour positionner l'incision, retirer l'os ectopique et l'ancien ciment osseux, positionner et fixer les composants et/ou obtenir un soutien osseux adéquat. Il faut généralement s'attendre à une durée d'intervention plus longue, une perte sanguine et un risque d'infection, d'embolie pulmonaire et d'hématome de la plaie lors d'une procédure de révision.

1. Changement de position des composants prothétiques, souvent lié aux facteurs énumérés dans la rubrique AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

2. Descellement précoce ou tardif des composants prothétiques, souvent lié aux facteurs énumérés dans la rubrique AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE
3. Fracture par fatigue de la tige fémorale, souvent liée aux facteurs énumérés dans la rubrique AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE
4. Usure excessive ou fracture des composants due à : altération peropératoire des composants prothétiques, débris de ciment, fragments osseux, particules métalliques, particules de céramique ou autres facteurs énumérés dans la rubrique AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE
5. Infection précoce ou tardive
6. Neuropathies périphériques. Des lésions nerveuses infracliniques peuvent également survenir à la suite d'un traumatisme chirurgical
7. Réactions tissulaires, ostéolyse et/ou descellement de l'implant dus à la corrosion métallique, à des réactions allergiques, à l'usure ou à des débris de particules (notamment particules de ciment, de métal, de polyéthylène ou de céramique)
8. Douleur résiduelle dans la hanche

Pendant l'opération

1. Perforation, fissure ou fracture de la diaphyse fémorale pouvant nécessiter le recours à une fixation interne
2. Fracture trochantérienne
3. Lésion des vaisseaux sanguins (p. ex. artère iliaque, obturatrice et fémorale)
4. Lésions nerveuses temporaires ou permanentes (p. ex. nerf fémoral, obturateur ou fibulaire commun)
5. Subluxation ou luxation de l'articulation de la hanche en raison de la taille de l'implant ou de la configuration adoptée, du positionnement des composants et/ou d'une laxité musculaire et fibreuse
6. Allongement ou raccourcissement de la jambe opérée
7. Retard chirurgical.

Immédiatement après l'opération

1. Troubles cardiovasculaires, notamment thrombose veineuse, embolie pulmonaire et infarctus du myocarde
2. Hématome et/ou retard de cicatrisation de la plaie
3. Subluxation ou luxation
4. Dissociation des composants modulaires

Tardivement après l'opération

1. Avulsion du trochanter due à une tension musculaire excessive, à la mise en charge ou à un affaiblissement accidentel du trochanter en peropératoire

2. Aggravation de problèmes au niveau des articulations homolatérales ou controlatérales du genou et de la cheville en raison d'un écart de longueur de jambe, d'une médialisation fémorale et/ou de déficits musculaires
3. Fracture fémorale due à un traumatisme ou à des charges excessives, en particulier en présence d'un capital osseux médiocre dû à une ostéoporose sévère, de défauts osseux résultant d'une intervention chirurgicale antérieure, des procédures d'alésage peropératoire ou de résorption osseuse
4. Résorption osseuse pouvant contribuer à la détérioration de la fixation et aboutir au descellement de l'implant
5. Diminution de la mobilité articulaire et de l'amplitude des mouvements (peut être causée par une calcification ou ossification périarticulaire)
6. Arthrose traumatique du genou homolatéral consécutive au positionnement peropératoire du membre pendant l'opération
7. Subluxation ou luxation
8. Dissociation des composants modulaires

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ DE L'IRM

Informations relatives à la sécurité de l'IRM Un patient porteur de cette prothèse DePuy Corail Cemented peut passer un examen d'IRM dans les conditions suivantes. Le non-respect de ces conditions peut entraîner des blessures pour le patient. 	
Nom/identification du dispositif	Prothèse de hanche CORAIL Cemented
Valeur(s) nominale(s) du champ magnétique statique [T]	1,5 T ou 3,0 T
Gradient de champ spatial maximal [T/m et gauss/cm]	30 T/m (3 000 gauss/cm)
Excitation RF	Polarisation circulaire (PC)
Type d'antenne émettrice de signal RF	Antenne émettrice corps entier, antenne tête émettrice-réceptrice de signal RF
Mode de fonctionnement	Mode de fonctionnement normal

DAS maximum corps entier	2,0 W/kg (mode de fonctionnement normal)
DAS maximum tête	L'utilisation d'une bobine de tête n'est pas nécessaire pour l'examen d'IRM de la hanche.
Limites relatives à la durée de balayage	DAS moyen corps entier de 2,0 W/kg Balayage pendant 15 minutes maximum suivi d'une période de refroidissement de 15 minutes (peut être répété jusqu'à trois fois au cours d'une même séance d'imagerie).
Artéfact d'image RM	La présence de cet implant ne devrait pas produire d'artéfact d'image de plus de 108 mm.
Instructions ou informations supplémentaires essentielles à une utilisation sécurisée dans un environnement IRM	* Vérifier tous les composants de la prothèse de hanche pour obtenir des informations supplémentaires sur les conditions de compatibilité avec l'IRM

ÉLIMINATION

Tous les dispositifs utilisés doivent être éliminés en toute sécurité conformément aux procédures et directives locales.

INTERPRÉTATION DES SYMBOLES

D/DP

DEPUY



Attention



Fabricant

Sterile R

Stérilisé par irradiation



Ne pas réutiliser

MATERIAL

Matériau(x) de fabrication



Recyclable



REF

Numéro de catalogue



Consulter le mode
d'emploi



Date limite d'utilisation



Ne pas restériliser



Compatible avec l'IRM
sous certaines conditions

MD

Dispositif médical

RT / LT

Droite/gauche

LOT

Code de lot



www.e-IFU.com
US / Canada 800-255-2500
EU: +800 8888 2020
EU: +32 2 4037222

Site Web pour le mode
d'emploi électronique

Sterile

Stérile



Ne pas utiliser si
l'emballage est
endommagé



Unité de conditionnement



Système de double
barrière stérile

MADE IN

Fabriqué au/en

S

Acier inoxydable

SIZE/SZ/DIA/IN/ft/DEG/GRP/lb/OD/ID

Taille/taille/diamètre/pouces/pieds/degrés/groupe/livres/
diamètre externe/diamètre interne

Prostesis Pinggul CORAIL Cemented

INFORMASI PENTING – Harap dibaca sebelum penggunaan
Beberapa produk mungkin tidak dilisensikan di semua yurisdiksi.

**STERILE**

Lihat label produk untuk metode

Situs web petunjuk penggunaan (IFU)

Untuk mengakses e-IFU dan bahasa tambahan, kunjungi www.e-IFU.com

Kartu implan, selebaran informasi pasien (PIL), dan situs web

Kartu implan (dan label kartu implan) disertakan dalam paket bersama implan. Informasi dalam selebaran informasi pasien (PIL) didasarkan pada informasi dalam IFU ini. ePIL bisa ditemukan pada situs web di bawah ini. Untuk mengakses ke ePIL, kunjungi www.ic.jnjmedicaldevices.com

PERHATIAN: Undang-undang Federal (Amerika Serikat) membatasi penjualan alat ini oleh atau atas perintah dokter.

DESKRIPSI PERANGKAT

Perangkat ini merupakan batang pinggul femoralis dari bahan logam. Prostesis Pinggul Total terdiri dari batang pinggul femoralis logam yang dikemas secara terpisah, kepala femoralis logam atau keramik modular, dan 2 bagian Polietilen Berat Molekul Ultra Tinggi (UHMWPE) yang diperkuat logam, komponen keramik atau asetabular UHMWPE yang dirancang untuk menggantikan permukaan artikular alami dari sendi pinggul.

BAHAN

Informasi berikut ini mencantumkan zat dalam implan. Mungkin terdapat jejak zat tambahan karena proses produksi. Hubungi alamat yang tertera di bawah untuk mendapatkan informasi tambahan.

Contoh Akronim yang digunakan pada label:	Deskripsi Bahan:	Bahan mengandung zat berikut secara nominal:
S1	Paduan baja tahan karat	Besi (63%) Kromium (21%) Nikel (10%) Mangan (3%) Molibdenum (3%) Kurang dari 1% Niobium dan Nitrogen

CARA PEMASOKAN

Perangkat ini dikemas secara terpisah dan disediakan secara STERIL. Keluarkan alat dari kemasan dengan menggunakan teknik aseptik yang diterima hanya setelah ukuran yang tepat telah ditentukan. Jangan menggunakan komponen ini jika kemasan sterility terlihat rusak atau dibuka secara tidak disengaja.

PENGUNAAN YANG DITUJUKAN

Pengguna yang Ditujukan

Perangkat ini tidak boleh digunakan oleh personel yang tidak memenuhi syarat. Penting bahwa ahli bedah dan staf ruang bedah telah mengetahui sepenuhnya tentang teknik bedah yang tepat untuk implan dan instrumen terkait.

Tujuan penggunaan – Prostesis pinggul total

Artroplasti pinggul total ditujukan untuk menggantikan artikulasi sendi pinggul yang rusak pada pasien ketika terdapat bukti tulang yang sehat dan memadai untuk menempatkan dan menopang komponen tersebut.

PERINGATAN: Gunakan kepala femoralis modular DePuy dan komponen asetabular DePuy saja dengan batang femoralis modular DePuy. Ukuran lancip kepala femoralis HARUS disesuaikan dengan ukuran lancip dari batang femoralis.

Komponen semen

Batang femoralis dengan label “Hanya untuk penggunaan dengan semen” ditujukan untuk digunakan dengan semen tulang.

Populasi Pasien

Populasi pasien yang menjadi target tujuan adalah pasien yang memiliki tulang dewasa, di mana terdapat bukti tulang yang sehat dan memadai untuk menempatkan dan menopang komponen tersebut.

INDIKASI

Penggantian pinggul total diindikasikan dalam kondisi berikut:

1. Sendi yang mengalami rematik dan/atau sangat menyakitkan (biasanya diakibatkan oleh penyakit sendi degeneratif noninflamasi)
2. Kegagalan tindakan operasi pinggul sebelumnya
3. Fraktur akut pada kepala atau leher femoralis.

KONTRAINDIKASI

1. Infeksi sistemis atau infeksi lokal yang aktif.
2. Kehilangan struktur otot, kerusakan neuromuskular, atau defisiensi vaskular pada anggota badan yang terkena, menjadikan prosedur tersebut tidak tepat untuk dilakukan.
3. Kualitas tulang yang kurang baik, seperti osteoporosis, yang dalam opini dokter bedah, mungkin terjadi migrasi prostesis yang parah atau peluang fraktur batang femoral yang signifikan dan/atau kurangnya tulang yang layak untuk menyokong implan.
4. Penyakit Charcot atau Paget.

PERINGATAN DAN TINDAKAN PENCEGAHAN

- Komponen implan dan uji coba dari produsen atau sistem implan yang berbeda tidak boleh digunakan bersama-sama.
- Komponen prostesis pinggul tidak boleh diimplan kembali. Meskipun implan tampak tidak rusak, namun mungkin telah memiliki cacat mikroskopis yang dapat menyebabkan kegagalan.
- Selalu gunakan prostesis uji coba untuk tujuan uji coba. Prostesis uji coba tidak boleh dipasangkan dengan komponen apa pun yang dimaksudkan untuk implantasi permanen. Komponen uji coba harus memiliki ukuran konfigurasi dan lain-lain yang sama dengan komponen-komponen terkait yang akan diimplan secara permanen.
- Perangkat sekali pakai yang diproduksi oleh DePuy Synthes belum didesain untuk menjalani atau tahan terhadap segala bentuk perubahan apa pun, seperti pembongkaran, pembersihan maupun sterilisasi ulang, setelah digunakan oleh seorang pasien. Pemakaian ulang bisa berpotensi mengganggu kinerja alat dan keselamatan pasien.
- Jangan mengubah atau memodifikasi implan dengan cara apa pun.
- Persediaan tulang yang bermutu sangat penting untuk memastikan fiksasi perangkat. Pertimbangkan penggunaan teknik cangkok tulang dan penguatan lainnya, terutama saat melakukan tindakan operasi revisi, untuk memasang dan menopang perangkat.

PERHATIAN: Kondisi-kondisi berikut, baik sendiri-sendiri atau bersamaan, cenderung menimbulkan beban berlebihan pada bagian tubuh yang terkena, sehingga menimbulkan peningkatan risiko penggantian pinggul pada pasien:

1. Obesitas atau berat badan pasien yang berlebihan.
2. Pekerja kasar.
3. Partisipasi olahraga dengan tingkat permintaan sedang hingga tinggi.
4. Tingkat aktivitas pasien yang tinggi.
5. Kemungkinan jatuh.
6. Penyalahgunaan alkohol atau narkoba secara aktif.
7. Disabilitas lainnya, sebagaimana berlaku

PERHATIAN: Kondisi-kondisi berikut secara sendiri-sendiri maupun bersamaan, cenderung akan menimbulkan pengaruh merugikan terhadap fiksasi implan penggantian pinggul:

1. Osteoporosis yang terdeteksi atau buruknya persediaan tulang.
2. Gangguan metabolisme atau pengobatan farmakologi sistemik yang mengakibatkan deteriorasi progresif pada penunjang tulang padat untuk implan (misalnya diabetes melitus, terapi steroid, terapi immunosupresif, dan sebagainya).
3. Riwayat infeksi umum atau lokal.
4. Deformitas parah yang mengakibatkan terganggunya fiksasi atau penempatan implan yang tidak sesuai.
5. Tumor pada struktur tulang penyangga.
6. Reaksi alergi pada bahan implan (misalnya semen tulang, logam).
7. Reaksi jaringan terhadap korosi implan atau serpihan aus implan.
8. Cacat pada persendian lainnya (yaitu lutut dan pergelangan kaki).

CATATAN: Saat ini diabetes belum ditetapkan sebagai kontraindikasi. Namun, karena meningkatnya risiko komplikasi seperti infeksi, luka yang lambat sembuh, dan sebagainya, dokter harus secara cermat mempertimbangkan kelayakan penggantian panggul pada pasien yang menderita diabetes parah.

Penanganan bedah dan pasca bedah pada pasien harus dilakukan dengan pertimbangan sebagaimana mestinya untuk semua kondisi yang ada. Sikap mental atau gangguan mental yang menyebabkan pasien tidak mematuhi perintah ahli bedah bisa memperlambat pemulihan pasca operasi dan/atau meningkatkan risiko efek samping yang tidak diinginkan, termasuk kegagalan implan atau fiksasi implan.

Aktivitas fisik atau trauma berlebihan pada sendi yang diganti dapat berperan pada kegagalan penggantian pinggul lebih dini dengan menyebabkan perubahan posisi, fraktur, dan/atau aus pada implan.

MANFAAT KLINIS YANG DIHARAPKAN PROSTESIS PINGGUL TOTAL

Artroplasti pinggul total diharapkan untuk memberikan peningkatan kemampuan gerak pasien dan mengurangi rasa sakit dengan menggantikan artikulasi sendi pinggul yang rusak pada tulang pasien dewasa, ketika terdapat bukti tulang yang sehat dan memadai untuk menempatkan dan menopang komponen tersebut.

RINGKASAN KINERJA KESELAMATAN DAN KLINIS

Beberapa negara atau kawasan memiliki daftar penggantian pinggul untuk memantau kinerja implan pinggul. Data dalam daftar ini dianalisis dan menunjukkan bahwa tindakan operasi pinggul total pertama seseorang umumnya bisa mencapai angka 95% (95 dari 100) dan bertahan selama lebih dari 10 tahun. Artinya, dalam jangka waktu 10 tahun, 5% (5 dari 100) dari pasien tersebut mungkin harus menjalani tindakan operasi tambahan untuk mengangkat bagian(-bagian) tertentu. 80% dari penggantian panggul revisi umumnya bisa bertahan selama lebih dari 10 tahun. Perangkat ini memenuhi usia pakai implan umum ini. Risiko operasi tambahan tergantung pada faktor yang terkait pada diri pasien tersebut, seperti anatomi, kondisi medis, dan gaya hidup (misalnya berat badan dan tingkat kegiatan), prosedur dan proses pembedahan.

SSCP khusus perangkat bisa ditemukan pada tautan berikut ini:
<http://ec.europa.eu/tools/eudamed>

Catatan: Tautan Eudamed hanya akan tersedia setelah basis data Eudamed dipublikasikan.

Pelaporan Insiden Serius

Segala insiden parah yang terjadi terkait perangkat harus dilaporkan kepada produsen dan pihak berwenang Negara Anggota tempat pengguna dan/atau pasien berada.

Insiden parah berarti segala insiden yang secara langsung atau tidak langsung mengarah, mungkin telah mengarah, atau dapat mengarah ke hal berikut:

- a) kematian pasien, pengguna, atau orang lain,
- b) penurunan kondisi kesehatan pasien, pengguna, atau orang lain yang bersifat sementara atau permanen,
- c) ancaman kesehatan publik yang parah.

INFORMASI PENGGUNAAN

Praoperasi

DOKTER BEDAH HARUS MENDISKUSIKAN SEMUA KETERBATASAN FISIK DAN MENTAL, TERUTAMA DENGAN PASIEN, SERTA SEMUA ASPEK BEDAH DAN PROSTESIS DENGAN PASIEN SEBELUM PEMBEDAHAN.

Diskusi tersebut harus mencakup keterbatasan dan akibat yang mungkin terjadi pada penggantian sendi, keharusan untuk mematuhi petunjuk ahli bedah pascaoperasi, dan informasi tersebut disediakan dalam selebaran pasien.

Perencanaan praoperasi dan teknik bedah untuk implantasi komponen pengganti pinggul ini didasarkan pada pengalaman bedah yang diperoleh selama pengembangan berbagai macam prostesis pinggul. Para ahli bedah tidak boleh memulai penggunaan klinis dari prostesis pinggul apa pun sebelum mereka benar-benar telah terbiasa dengan teknik implantasi spesifik dari prostesis ini. Tersedia brosur teknik bedah dari DePuy.

Intraoperasi

Sebaiknya komponen berukuran paling tidak satu ukuran lebih besar dan satu ukuran lebih kecil dibanding ukuran komponen yang ditetapkan sebelum operasi tersedia saat pembedahan untuk mengakomodasi pemilihan ukuran yang tepat selama operasi.

Penutup pelindung harus tetap terpasang sampai komponen siap diimplan. Jangan gunakan komponen jika terjatuh atau terbentur pada permukaan yang keras. Kerusakan pada komponen mungkin tidak terlihat, tetapi dapat menyebabkan kegagalan dini prostesis. Instrumen bedah yang diidentifikasi dalam teknik bedah telah dirancang untuk prosedur artroplasti ini dan harus digunakan seperti yang ditampilkan dalam brosur teknik bedah. Sebelum melakukan implantasi kepala femoralis keramik, ujung lancip jantan pada batang femoralis harus dibersihkan dari darah, serpihan tulang, maupun benda asing lainnya. Benda asing antara taper kepala dan batang femoral bisa menghalangi pemasangan kepala dengan benar pada batang tersebut. Sehingga dapat memengaruhi kinerja kepala femur atau mekanisme penguncian antara kepala femur dengan batang femur.

Saat melakukan operasi perbaikan, semua membran berserat yang membungkus prostesis rusak harus dikeluarkan seluruhnya. Sisa membran berserat dapat mengganggu fiksasi implan. Tinjau kerusakan pada setiap perangkat yang sudah ada sebelumnya, pada permukaan yang bisa menghalangi dudukan secara memadai atau penguncian perangkat baru. Pemilihan implan, penempatan, atau penentuan posisi implan yang tidak tepat bisa menyebabkan kondisi tekanan yang tidak biasa dan kemudian berkurangnya usia pakai implan. Perhatikan bahwa batang femur yang ditempatkan pada varus akan meningkatkan tekanan pada korteks femur medial proksimal dan dapat menyebabkan melonggarnya implan. Sebelum menutup bagian yang dibedah, pastikan untuk membersihkan daerah yang dibedah secara menyeluruh dari serpihan tulang, semen tulang asing, tulang ektopik, dan sebagainya. Partikel asing pada sambungan antara logam/plastik, atau keramik/plastik, atau keramik/keramik bisa

mengakibatkan keausan berlebih. Jangkauan gerak harus diperiksa secara menyeluruh untuk mengetahui adanya pemadanan yang tidak sesuai, ketidakstabilan, atau jepitan, dan dikoreksi dengan cara yang sesuai.

Pascaoperasi

Amat sangat penting bagi pasien untuk benar-benar mematuhi petunjuk dan peringatan dokter. Praktik yang diterima harus diikuti selama perawatan setelah operasi.

Pasien yang keluar dari rumah sakit harus dengan instruksi dan peringatan tertulis yang lengkap berkenaan dengan olahraga dan terapi serta batasan apa pun yang terkait dengan kegiatannya. Malposisi komponen atau penggunaan pinggul yang terbatas atau pinggul total dengan kepala berputar modular atau selubung lancip bisa mengurangi rentang gerakan sendi dan bisa meningkatkan potensi keausan komponen, penjepitan, dislokasi atau revisi secara dini. Dalam kasus ini, dokter bedah harus memberi tahu pasien untuk menghindari aktivitas dengan rentang gerakan yang tinggi.

Tindak lanjut pasien secara berkala direkomendasikan karena usia pakai fungsional implan yang tidak diketahui pada pasien tertentu, terutama yang terkait dengan pemeliharaan fiksasi implan dan permukaan bantalan. Pemeriksaan radiologi harus dilakukan pada setiap tindak lanjut dan dibandingkan dengan pemeriksaan radiologi sebelumnya dan dikaitkan dengan penilaian klinis pasien. Jika terjadi perubahan secara radiologi, misalnya terjadinya radiolusensi, resorpsi tulang, atau perubahan pada posisi implan, semua perubahan ini harus dipantau secara teliti untuk menentukan apakah bersifat statis atau progresif, kemudian pasien ditangani dengan tepat.

EFEK SAMPING DAN KOMPLIKASI

Berikut ini yang biasanya merupakan adverse event dan komplikasi yang paling sering dijumpai pada artroplasti pinggul:

Umum

Tingkat insiden dan keparahan komplikasi pada penggantian pinggul biasanya lebih besar pada bedah revisi dibanding dalam bedah utama. Masalah umum yang dihadapi dalam pembedahan revisi dapat meliputi kesulitan penempatan sayatan, pemindahan tulang ektopik dan semen tulang tua, pemosisian dan fiksasi komponen, dan/atau memperoleh penopang tulang yang memadai. Biasanya waktu operasi yang lebih lama, kehilangan darah, risiko infeksi, emboli pulmonal dan hematoma luka dapat terjadi dalam prosedur bedah revisi.

1. Mengubah posisi komponen prostetik, sering kali dikaitkan dengan faktor-faktor yang tercantum dalam bagian PERINGATAN DAN TINDAKAN PENCEGAHAN.
2. Pelonggaran yang lebih awal atau lebih akhir dari komponen prostetik, sering kali dikaitkan dengan faktor-faktor yang tercantum dalam bagian PERINGATAN DAN TINDAKAN PENCEGAHAN.
3. Fraktur akibat pergerakan pada batang femoralis, seringkali dikaitkan dengan faktor-faktor yang tercantum dalam bagian PERINGATAN DAN TINDAKAN PENCEGAHAN.
4. Keausan yang berlebih atau fraktur pada komponen bantalan diakibatkan oleh: kerusakan intraoperatif pada komponen prostetik, semen yang longgar, fragmen tulang, partikel logam, partikel keramik atau faktor lainnya yang tercantum dalam bagian PERINGATAN DAN TINDAKAN PENCEGAHAN.
5. Infeksi dini atau lambat.
6. Neuropati perifer. Kerusakan saraf sub klinis juga dapat terjadi akibat trauma operasi.
7. Reaksi jaringan, osteolisis, dan/atau pelonggaran implan yang disebabkan oleh korosi logam, reaksi alergi, bagian atau partikel yang aus (seperti semen yang longgar, partikel logam, polietilena, atau keramik).
8. Sisa rasa nyeri di pinggul.

Intraoperasi

1. Perforasi batang femoral, retak, atau fraktur, yang mungkin memerlukan penggunaan fiksasi internal.
2. Fraktur trokanterik.
3. Kerusakan pada pembuluh darah (misalnya arteri iliak, arteri obturator, dan arteri femur).
4. Kerusakan saraf sementara atau permanen (misalnya saraf femur, saraf obturator atau saraf peroneal terisolasi).
5. Subluksasi atau dislokasi sendi pinggul karena ukuran atau pemilihan konfigurasi implan, penentuan posisi komponen dan/atau laksitas jaringan serat dan jaringan otot.
6. Pemanjangan atau pemendekan anggota tubuh yang terdampak.
7. Jeda pada tindakan bedah.

Pascaoperasi Awal

1. Gangguan jantung dan pembuluh darah termasuk trombosis vena, emboli pulmonal, dan infarksi miokardial.
2. Hematoma dan/atau luka yang lama sembuh.
3. Subluksasi atau dislokasi.
4. Disasosiasi komponen modular.

Pascaoperasi Akhir

1. Avulsi trokanterik karena ketegangan otot yang berlebihan, penahanan beban, atau melemahnya trokanter tanpa sengaja selama operasi.
2. Memburuknya gangguan sendi lutut dan pergelangan ipsilateral atau kontralateral akibat perbedaan panjang kaki, medialisasi femur, dan/atau defisiensi otot.
3. Fraktur femur akibat trauma atau beban berlebih, terutama adanya persediaan tulang yang buruk karena osteoporosis parah, cacat tulang dari operasi sebelumnya, prosedur pelebaran selama operasi, atau resorpsi tulang.
4. Resorpsi tulang yang bisa memberi kontribusi pada kerusakan fiksasi dan akhirnya melonggarkan implan.
5. Berkurangnya kemampuan gerak dan rentang gerak sendi (misalnya mungkin disebabkan oleh kalsifikasi atau osifikasi periartikular).
6. Artrosis traumatik pada lutut ipsilateral sekunder terhadap penentuan posisi selama operasi, pada bagian tubuh selama operasi.
7. Subluksasi atau dislokasi.
8. Disasosiasi komponen modular.

INFORMASI KESELAMATAN MRI

 Informasi Keselamatan MRI Pasien yang menggunakan konstruksi DePuy Corail Cemented bisa dipindai dalam kondisi berikut. Kelalaian dalam mematuhi kondisi berikut ini bisa mengakibatkan cedera pada diri pasien.	
Nama/Identifikasi perangkat	Prostesis Pinggul CORAIL Cemented
Nilai Nominal Medan Magnet Statis [T]	1,5 T atau 3,0 T.
Gradien Bidang Spasial Maksimum [T/m dan gauss/cm]	30 T/m (3.000 gauss/cm)
Eksitasi FR	Terpolarisasi Secara Melingkar (CP)
Jenis Gelung Transmisi FR	Gelung transmisi seluruh bagian tubuh, Gelung transmisi-terima FR Kepala
Mode Pengoperasian	Mode Pengoperasian Normal

SAR Seluruh Tubuh Maksimum	2,0 W/kg (Mode Pengoperasian Normal)
SAR Kepala Maksimum	Penggunaan gelang kepala tidak diperlukan untuk pemindaian pinggul
Batasan pada Durasi Pemindaian	2,0 W/kg SAR rata-rata seluruh tubuh Pemindaian hingga 15 menit diikuti dengan periode pendinginan selama 15 menit (bisa diulang hingga tiga kali dalam satu sesi pencitraan tunggal)
Artefak Citra MR	Kehadiran implan ini diperkirakan tidak akan menghasilkan artefak citra yang memanjang lebih dari 108 mm
Petunjuk tambahan atau informasi penting untuk penggunaan yang aman di lingkungan MR	*Periksa semua komponen konstruksi pinggul untuk mendapatkan informasi pelabelan MR tambahan

PEMBUANGAN

Buanglah semua perangkat bekas pakai secara aman menurut prosedur dan pedoman setempat.

INTERPRETASI SIMBOL

D/DP

DEPUY

REF

Nomor Katalog

LOT

Kode Batch



Perhatian



Baca Petunjuk
Penggunaan



www.e-IFU.com
US / Canada 800-255-2500
EU: +800 8888 2020
EU: +32 2 4037222

Situs web e-IFU



Produsen



Gunakan Sebelum Tanggal

Sterile

Steril



Disterilkan dengan menggunakan iradiasi



Jangan disterilisasi ulang



Jangan digunakan jika kemasan rusak



Jangan digunakan kembali



Penggunaan di Lingkungan MR Tergantung pada Kondisi Tertentu



Unit kemasan



Bahan konstruksi



Perangkat Medis



Sistem penghalang steril ganda



Bisa didaur ulang

RT / LT

Kanan/kiri



Buatan

S

Baja tahan karat

SIZE/SZ/DIA/IN/ft/DEG/GRP/lb/OD/ID

Ukuran/ukuran/diameter/inci/kaki/derajat/kelompok/pon/
diameter luar/diameter dalam

Protesi d'anca CORAIL Cemented

INFORMAZIONI IMPORTANTI – Leggere prima dell'uso

Alcuni prodotti potrebbero non essere autorizzati in tutte le giurisdizioni.

**STERILE**

Vedere l'etichetta del prodotto per la metodologia.

Sito web delle istruzioni per l'uso (IFU)

Per accedere alle istruzioni per l'uso in formato elettronico (e-IFU) e alle eventuali lingue aggiuntive, visitare la pagina www.e-IFU.com

Tessera del portatore dell'impianto, opuscolo informativo per il paziente (PIL) e sito web

La tessera del portatore dell'impianto (e l'etichetta della tessera del portatore dell'impianto) è fornita nella confezione insieme all'impianto. Le informazioni contenute nell'opuscolo informativo per il paziente (PIL) si basano sulle informazioni contenute nelle presenti IFU. L'opuscolo informativo per il paziente in formato elettronico (ePIL) è disponibile sul sito web indicato di seguito.

Per accedere all'ePIL visitare la pagina www.ic.jnjmedicaldevices.com

ATTENZIONE: la legge federale statunitense limita la vendita del dispositivo da parte o su ordine di un medico.

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

Lo stelo femorale è di metallo. Una protesi d'anca totale comprende uno stelo femorale in metallo, una testa femorale modulare in metallo o ceramica e componenti acetabolari in 2 pezzi composti da polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMWPE) con supporto in metallo, ceramica o 100% UHMWPE, tutti confezionati individualmente e progettati per sostituire la superficie articolare naturale dell'articolazione dell'anca.

MATERIALI

Le seguenti informazioni indicano le sostanze presenti nell'impianto. Altre sostanze traccia possono essere presenti a causa del processo di produzione. Per ulteriori informazioni, contattare l'indirizzo indicato di seguito.

Esempio di acronimo utilizzato sulle etichette:	Descrizione del materiale:	Il materiale contiene nominalmente le seguenti sostanze:
S1	Lega di acciaio inossidabile	Ferro (63%) Cromo (21%) Nichel (10%) Manganese (3%) Molibdeno (3%) Meno dell'1% di niobio e azoto

CONFEZIONE

Questi dispositivi sono confezionati singolarmente e forniti STERILI. Estrarre dalla confezione utilizzando una tecnica asettica accettata solo dopo aver determinato la dimensione corretta. Non usare questi componenti se la confezione sterile risulta danneggiata o involontariamente aperta.

USO PREVISTO

Utente previsto

Questi dispositivi devono essere utilizzati solo da personale qualificato. È essenziale che il chirurgo e il personale della sala operatoria abbiano acquisito piena conoscenza della tecnica chirurgica appropriata riguardante l'impianto e gli strumenti associati.

Uso previsto – Protesi d'anca totale

La protesi d'anca totale è indicata per la sostituzione dell'articolazione dell'anca danneggiata in pazienti in cui vi è evidenza di osso sano sufficiente per posizionare e supportare i componenti.

AVVERTENZA: con gli steli femorali modulari DePuy utilizzare solo teste femorali modulari DePuy e componenti acetabolari DePuy. La dimensione del cono della testa femorale DEVE corrispondere alla dimensione del cono dello stelo femorale.

Componenti cementati

Questo stelo femorale etichettato “Solo per uso cementato” è destinato all'uso con cemento osseo.

Popolazione di pazienti

La popolazione di pazienti target include soggetti scheletricamente maturi in cui vi è evidenza di osso sano sufficiente per posizionare e supportare i componenti.

INDICAZIONI

La sostituzione totale dell'anca è indicata nei casi seguenti:

1. Articolazione particolarmente dolorosa e/o artritica (tipicamente dovuta a malattia degenerativa articolare non infiammatoria)
2. Precedente intervento chirurgico all'anca non riuscito
3. Frattura acuta della testa o del collo del femore

CONTROINDICAZIONI

1. Infezioni locali o sistemiche in atto.
2. Perdita della muscolatura, compromissione neuromuscolare o deficit vascolare nell'arto interessato tali da rendere la procedura non giustificata.
3. Scarsa qualità dell'osso, ad esempio osteoporosi, laddove, secondo l'opinione del chirurgo, potrebbe esserci migrazione considerevole della protesi o una significativa possibilità di frattura dello stelo femorale e/o mancanza di una quantità ossea adeguata per il sostegno dell'impianto o degli impianti.
4. Malattia di Charcot o Paget.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Non utilizzare mai congiuntamente gli impianti e i componenti di prova di produttori o sistemi d'impianto diversi.
- Non reimpiantare mai i componenti di una protesi d'anca. Anche se l'impianto non sembra danneggiato, potrebbe avere imperfezioni microscopiche suscettibili di causare il fallimento dell'intervento.
- Utilizzare sempre una protesi di prova per scopi di prova. Non assemblare mai i componenti di prova con componenti destinati all'impianto permanente. I componenti di prova devono avere le stesse dimensioni di configurazione, ecc. dei componenti corrispondenti da impiantare in modo permanente.
- I dispositivi monouso prodotti da DePuy non sono stati previsti per tollerare o sopportare alcuna forma di alterazione, come ad esempio smontaggio, pulizia o sterilizzazione, dopo l'uso in un singolo paziente. Il riutilizzo può potenzialmente compromettere le prestazioni del prodotto e la sicurezza del paziente.
- Non alterare né modificare gli impianti in alcun modo.
- Un patrimonio osseo di qualità idonea è fondamentale per garantire la fissazione del dispositivo. Valutare l'uso di innesto osseo e altre tecniche di rinforzo, soprattutto quando si esegue un intervento di revisione, al fine di posizionare e supportare il dispositivo.

ATTENZIONE: le seguenti condizioni, presenti singolarmente o in concomitanza, tendono a imporre un carico importante sull'estremità interessata, esponendo in tal modo il paziente a un rischio maggiore di fallimento dell'impianto di protesi d'anca:

1. Obesità o peso eccessivo del paziente
2. Lavoro manuale
3. Attività sportiva di livello moderato o alto
4. Alti livelli di attività del paziente
5. Probabilità di cadute
6. Consumo di alcolici o sostanze stupefacenti
7. Altre disabilità, a seconda dei casi

ATTENZIONE: le seguenti condizioni, presenti singolarmente o in concomitanza, tendono a influenzare negativamente la fissazione degli impianti di sostituzione dell'anca:

1. Marcata osteoporosi o scarso patrimonio osseo
2. Disturbi metabolici o trattamenti farmacologici sistemici che comportano il progressivo deterioramento di un supporto osseo solido per l'impianto (per esempio, diabete mellito, terapie steroidee, terapie immunosoppressive e così via)
3. Anamnesi di infezioni generalizzate o locali
4. Gravi deformità tali da causare una fissazione compromessa o un posizionamento improprio dell'impianto
5. Tumori nelle strutture ossee portanti
6. Reazioni allergiche ai materiali dell'impianto (ad es. cemento osseo, metallo)
7. Reazioni dei tessuti alla corrosione dell'impianto o ai detriti derivanti dall'usura dell'impianto
8. Disabilità di altre articolazioni (cioè ginocchia e caviglie)

NOTA: il diabete, al momento, non è ritenuto una controindicazione. Tuttavia, a causa dell'aumentato rischio di complicanze come infezioni, guarigione lenta della ferita e così via, il medico deve considerare attentamente l'opportunità di impianto di una protesi d'anca nel paziente gravemente diabetico.

La gestione chirurgica e postoperatoria del paziente deve essere eseguita tenendo in debita considerazione tutte le condizioni esistenti. Eventuali atteggiamenti o disturbi mentali che comportino la mancata adesione del paziente agli ordini del chirurgo possono ritardare il recupero postoperatorio e/o aumentare il rischio di effetti avversi, incluso il fallimento dell'impianto o la mancata fissazione dello stesso.

Un'eccessiva attività fisica o un trauma all'articolazione sostituita, poiché suscettibile di spostare, fratturare o usurare gli impianti, può contribuire al fallimento prematuro della protesi d'anca.

BENEFICI CLINICI ATTESI PROTESI D'ANCA TOTALE

Si prevede che l'artroplastica totale dell'anca aumenti la mobilità del paziente e riduca il dolore, tramite sostituzione dell'articolazione dell'anca danneggiata in pazienti scheletricamente maturi in cui vi è evidenza di osso sano sufficiente per posizionare e supportare i componenti.

RIEPILOGO DI SICUREZZA E PRESTAZIONI CLINICHE

Taluni Paesi o aree geografiche dispongono di registri di protesi d'anca che monitorano le prestazioni degli impianti d'anca. Analizzando i dati di questi registri, si nota che nel caso di primo intervento di sostituzione totale dell'anca in genere nel 95% (95 su 100) dei casi l'impianto dura più di 10 anni. Questo significa che a 10 anni circa il 5% (5 su 100) dei pazienti può aver necessitato di un intervento addizionale per rimuovere uno o più componenti. Nel caso di una protesi d'anca di revisione, generalmente l'80% dura più di 10 anni. Questo dispositivo soddisfa questa durata dell'impianto generale. Il rischio di interventi chirurgici aggiuntivi per un singolo paziente dipenderà da fattori specifici del paziente come l'anatomia, le condizioni mediche e lo stile di vita (ad es. peso e livello di attività fisica), la procedura e il processo chirurgico.

Le informazioni SSCP specifiche per i vari dispositivi sono disponibili seguendo il link: <http://ec.europa.eu/tools/eudamed>

Nota: il link a Eudamed sarà disponibile solo dopo l'attivazione del database Eudamed.

Segnalazione di incidenti gravi

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente del Paese membro nel quale risiedono l'utente e/o il paziente.

Per incidente grave si intende qualsiasi incidente che abbia causato, possa aver causato o possa causare, direttamente o indirettamente, una delle seguenti situazioni:

- a) decesso del paziente, dell'operatore o di un altro soggetto;
- b) deterioramento grave temporaneo o permanente dello stato di salute del paziente, dell'operatore o di un altro soggetto;
- c) una grave minaccia per la salute pubblica.

INFORMAZIONI PER L'USO

Informazioni preoperatorie

PRIMA DELL'INTERVENTO, IL CHIRURGO DEVE DISCUTERE CON IL PAZIENTE TUTTE LE LIMITAZIONI FISICHE E MENTALI RELATIVE AL PAZIENTE STESSO, COME ANCHE TUTTI GLI ASPETTI DELLA CHIRURGIA E DELLA PROTESI. La discussione deve includere i limiti e le possibili conseguenze della sostituzione dell'articolazione, la necessità di seguire le istruzioni del chirurgo dopo l'intervento e le informazioni fornite nel foglio illustrativo per il paziente.

La pianificazione preoperatoria e le tecniche chirurgiche per l'impianto di questi componenti di sostituzione dell'anca sono state sviluppate in base all'esperienza chirurgica acquisita durante lo sviluppo di molte protesi d'anca. I chirurghi non devono iniziare a usare clinicamente una protesi d'anca prima di conoscerne a fondo la specifica tecnica di impianto. Presso DePuy sono disponibili opuscoli sulle tecniche chirurgiche.

Informazioni intraoperatorie

Si raccomanda di tenere a disposizione durante l'intervento chirurgico dei componenti di almeno una misura più grande e una più piccola rispetto a quella determinata in fase preoperatoria, per consentire la selezione intraoperatoria delle dimensioni appropriate.

Le coperture protettive non vanno rimosse fino a quando i componenti non sono pronti per essere impiantati. Non utilizzare i componenti se sono caduti o hanno urtato una superficie dura. Il danneggiamento di un componente può non essere visibile, ma comunque causare un guasto precoce della protesi. Gli strumenti chirurgici identificati nella tecnica chirurgica sono stati progettati per questa procedura di artroplastica e devono essere usati come mostrato nella brochure della tecnica chirurgica. Prima di impiantare una testa femorale in ceramica, pulire il cono maschio sullo stelo femorale rimuovendo eventuali tracce di sangue, frammenti ossei o altri materiali estranei. La presenza di materiale estraneo tra la testa e il cono dello stelo femorale può impedire il corretto posizionamento della testa sullo stelo stesso. Questo potrebbe influire sulle prestazioni della testa del femore o sul meccanismo di bloccaggio tra la testa del femore e lo stelo femorale.

Quando si esegue un intervento di revisione, è imprescindibile che qualsiasi membrana fibrosa che incapsuli la protesi da espantare venga rimossa nella sua interezza. Le membrane fibrose residue possono interferire con la fissazione dell'impianto. Rivedere eventuali dispositivi preesistenti per verificare se presentano danni alle superfici di accoppiamento che impedirebbero un adeguato posizionamento o bloccaggio del nuovo

dispositivo. La selezione, la collocazione o il posizionamento non corretti degli impianti possono provocare sollecitazioni insolite e una conseguente riduzione della vita funzionale dell'impianto. Si noti che uno stelo femorale posizionato in varo aumenta la sollecitazione sulla corteccia femorale mediale prossimale e può portare all'allentamento dell'impianto. Prima della chiusura, il sito chirurgico deve essere pulito accuratamente rimuovendo schegge ossee, cemento osseo estraneo, osso ectopico, ecc. La presenza di particelle estranee in corrispondenza dell'interfaccia metallo/plastica, ceramica/plastica o ceramica/ceramica può causare un'usura eccessiva. Controllare accuratamente l'ampiezza di movimento, per rilevare eventuali accoppiamenti non corretti, instabilità o impingement, e correggerla come opportuno.

Informazioni postoperatorie

Un rispetto rigoroso da parte del paziente delle istruzioni e delle avvertenze del chirurgo è estremamente importante. Durante la cura postoperatoria è opportuno seguire le pratiche accettate.

Il paziente deve essere dimesso dall'ospedale con istruzioni scritte complete e avvertenze riguardanti esercizi e terapie ed eventuali limitazioni alle attività che possono essere svolte. Il malposizionamento dei componenti o l'uso della protesi d'anca constrained o totale con testa modulare skirted o con manicotto affusolato può ridurre il range di movimento articolare e può aumentare il rischio di usura dei componenti, impingement, lussazione prematura o revisione. In questi casi il chirurgo deve raccomandare al paziente di evitare range di movimenti ampi.

Si raccomanda un follow-up periodico continuo del paziente a causa della durata funzionale sconosciuta dell'impianto nel paziente specifico, in particolare per quanto riguarda il mantenimento della fissazione dell'impianto e delle superfici portanti. Effettuare esami radiologici ad ogni visita di follow-up; confrontare gli esiti con quelli precedenti e correlarli alla valutazione clinica del paziente. Se si osservano variazioni nei referti radiologici, come il verificarsi di radiotrasparenze, riassorbimento osseo o qualsiasi cambiamento nella posizione di un impianto, tali cambiamenti devono essere attentamente monitorati per determinare se siano statici o progressivi e il paziente va trattato in modo appropriato.

EVENTI AVVERSI E COMPLICANZE

Quelli che seguono sono tipicamente gli eventi avversi e le complicanze più frequenti nell'artroprotesi d'anca.

Generali

L'incidenza e la gravità delle complicanze nella protesi d'anca sono tipicamente maggiori negli interventi di revisione rispetto alle operazioni

primarie. I problemi comuni riscontrati nella chirurgia di revisione possono includere difficoltà associate a posizionamento dell'incisione, rimozione dell'osso ectopico e del vecchio cemento osseo, posizionamento e fissaggio dei componenti e/o ottenimento di un adeguato supporto osseo. In generale, con le procedure di revisione ci si può aspettare un aumento del tempo operatorio, della perdita di sangue e del rischio di infezione, embolia polmonare ed ematoma della ferita.

1. Migrazione delle componenti protesiche, spesso correlata ai fattori elencati nella sezione AVVERTENZE E PRECAUZIONI.
2. Allentamento anticipato o tardivo delle componenti protesiche, spesso correlato ai fattori elencati nella sezione AVVERTENZE E PRECAUZIONI.
3. Frattura da fatica dello stelo femorale, spesso correlata ai fattori elencati nella sezione AVVERTENZE E PRECAUZIONI.
4. Usura eccessiva o frattura dei componenti portanti dovuta a danni intraoperatori alle componenti protesiche, cemento allentato, frammenti ossei, particelle metalliche, particelle ceramiche o altri fattori elencati nella sezione AVVERTENZE E PRECAUZIONI.
5. Infezione precoce o tardiva.
6. Neuropatie periferiche. Il danno subclinico ai nervi può verificarsi anche a seguito di un trauma chirurgico.
7. Reazioni tissutali, osteolisi e/o allentamento della protesi causati da corrosione metallica, reazioni allergiche, usura o detriti particellari (quali cemento allentato, particelle di metallo, polietilene o ceramica).
8. Dolore residuo all'anca.

Intraoperatori

1. Perforazione, incrinatura o frattura della diafisi femorale, che può richiedere l'uso della fissazione interna.
2. Frattura trocanterica.
3. Danni ai vasi sanguigni (ad es. arteria iliaca, dell'otturatore e femorale).
4. Danno nervoso temporaneo o permanente (ad es. nervo femorale, dell'otturatore o peroneo isolato).
5. Sublussazione o lussazione dell'articolazione dell'anca a causa della dimensione o della configurazione dell'impianto selezionato, del posizionamento dei componenti e/o della lassità del tessuto muscolare e fibroso.
6. Allungamento o accorciamento dell'estremità colpita.
7. Ritardo nella chirurgia.

Postoperatori precoci

1. Disturbi cardiovascolari, come trombosi venosa, embolia polmonare e infarto miocardico.

2. Ematoma e/o guarigione ritardata delle ferite.
3. Sublussazione o lussazione.
4. Separazione di componenti modulari.

Postoperatori tardivi

1. Avulsione trocanterica dovuta a tensione muscolare eccessiva, carico eccessivo o indebolimento intraoperatorio accidentale del trocantere.
2. Aggravamento dei problemi alle articolazioni ipsilaterali o controlaterali del ginocchio e della caviglia a causa di discrepanza nella lunghezza delle gambe, medializzazione femorale e/o carenze muscolari.
3. Frattura femorale dovuta a trauma o carico eccessivo, in particolare in presenza di scarso patrimonio osseo causato da grave osteoporosi, difetti ossei da precedenti interventi chirurgici, procedure di alesatura intraoperatoria o riassorbimento osseo.
4. Riassorbimento osseo che può contribuire al deterioramento della fissazione e all'eventuale allentamento dell'impianto.
5. Diminuzione della mobilità articolare e della gamma di movimenti (ad es. magari causata da calcificazione o ossificazione periarticolare).
6. Artrosi traumatica del ginocchio ipsilaterale secondaria al posizionamento intraoperatorio dell'arto durante l'intervento chirurgico.
7. Sublussazione o lussazione.
8. Separazione di componenti modulari.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA RM

Informazioni sulla sicurezza RM  Un paziente con dispositivo DePuy Corail Cemented può essere sottoposto a scansione nelle condizioni indicate di seguito. L'inosservanza di queste condizioni può provocare lesioni al paziente.	
Nome/Identificazione del dispositivo	Protesi d'anca Corail Cemented
Valori nominali del campo magnetico statico [T]	1,5 T o 3,0 T
Gradiente di campo spaziale massimo [T/m e gauss/cm]	30 T/m (3.000 gauss/cm)
Eccitazione RF	Polarizzazione circolare (PC)

Tipo di bobina di trasmissione RF	Bobina di trasmissione corpo intero, bobina di trasmissione-ricezione RF testa
Modalità operativa	Modalità operativa normale
SAR massimo per corpo intero	2,0 W/kg (modalità operativa normale)
SAR massimo per testa	Per la scansione dell'anca non occorre utilizzare una bobina di testa
Limiti alla durata della scansione	Tasso di assorbimento specifico (SAR) mediato sul corpo intero di 2,0 W/kg Scansione per un massimo di 15 minuti seguiti da un periodo di raffreddamento di 15 minuti (può essere ripetuto fino a tre volte in una singola sessione di imaging)
Artefatto immagine RM	Non si prevede che la presenza di questo impianto produca un artefatto dell'immagine che si estenda per oltre 108 mm
Ulteriori istruzioni o informazioni essenziali per un utilizzo sicuro in ambiente RM	*Per ulteriori informazioni sull'etichettatura RM verificare tutti i componenti di montaggio dell'anca

SMALTIMENTO

Smaltire in sicurezza tutti i dispositivi usati in conformità con le procedure e le linee guida locali.

LEGENDA DEI SIMBOLI

D/DP

DEPUY



Attenzione



Numero di catalogo



Consultare le istruzioni per l'uso



Codice del lotto



www.e-IFU.com
US / Canada 800-255-2500
EU: +800 8888 2020
EU: +32 2 4037222

Sito web delle istruzioni per l'uso in formato elettronico



Produttore



Data di scadenza



Sterile



Sterilizzato mediante
irradiazione



Non risterilizzare



Non utilizzare se la
confezione è danneggiata



Non riutilizzare



A compatibilità RM
condizionata



Unità di confezionamento



Materiale di costruzione



Dispositivo medico



Sistema a barriera sterile
doppia



Riciclabile



RT / LT

Destra/Sinistra



Prodotto in

S

Acciaio inossidabile

SIZE/SZ/DIA/IN/ft/DEG/GRP/lb/OD/ID

Misura/misura/diametro/pollici/piedi/gradi/gruppo/libbre/
diametro esterno/diametro interno

CORAIL Cemented-heupprothese

BELANGRIJKE INFORMATIE – Vóór gebruik doorlezen

Voor sommige producten is mogelijk niet in alle rechtsgebieden een vergunning verleend.

**STERILE**

Zie productetiket voor methode

Website waar de gebruiksaanwijzing (IFU) te vinden is

Ga voor toegang tot de e-IFU en extra talen naar www.e-IFU.com

Implantaatkaart, patiëntenbijsluiter (PIL) en website

De implantaatkaart zit (samen met het etiket van de implantaatkaart) in de verpakking bij het implantaat. De informatie in de patiëntenbijsluiter (PIL) is gebaseerd op de informatie in deze gebruiksaanwijzing. De ePIL (elektronische patiëntenbijsluiter) is te vinden op onderstaande website. Ga voor toegang tot de ePIL naar www.ic.injmedicaldevices.com

LET OP: Volgens de Amerikaanse federale wetgeving mag dit hulpmiddel uitsluitend door of op voorschrift van een arts worden verkocht.

BESCHRIJVING VAN HET HULPMIDDEL

Dit is een metalen femorale heupsteel. Een totale heupprothese is samengesteld uit afzonderlijk verpakte metalen femorale heupstelen, modulaire metalen of keramische femurkoppen en 2-delig met metaal bedekte acetabulaire componenten van polyethyleen met ultrahoog moleculair gewicht (UHMWPE), keramische of volledig UHMWPE acetabulaire componenten die zijn ontworpen om het natuurlijke articulaire oppervlak van het heupgewricht te vervangen.

MATERIALEN

Onderstaande informatie geeft een overzicht van de stoffen in het implantaat. Als gevolg van het fabricageproces kunnen nog sporen van andere stoffen aanwezig zijn. Neem contact op met het onderstaande adres voor aanvullende informatie.

Voorbeeld van een acroniem dat op het/de label(s) wordt gebruikt:	Materiaal-beschrijving:	Het materiaal bevat nominaal de volgende stoffen:
S1	Roestvrijstalen legering	IJzer (63%) Chroom (21%) Nikkel (10%) Mangaan (3%) Molybdeen (3%) Minder dan 1% niobium en stikstof

LEVERING

Deze apparaten worden afzonderlijk verpakt en STERIEL geleverd. Verwijder pas nadat de juiste maat is bepaald uit de verpakking met behulp van een geaccepteerde aseptische techniek. Gebruik deze componenten niet als de steriele verpakking beschadigd of onbedoeld geopend blijkt te zijn.

BEOOGD GEBRUIK

Beoogde gebruiker

Deze hulpmiddelen mogen niet worden gebruikt door niet-gekwalificeerd personeel. Het is essentieel dat de chirurg en het OK-personeel volledig vertrouwd zijn met de juiste chirurgische techniek voor het implantaat en de instrumenten die daarmee verband houden.

Beoogd gebruik – Totale heupprothese

Totale heupartroplastiek is bedoeld ter vervanging van de articulatie van het beschadigde heupgewricht bij patiënten waar er bewijs is van voldoende gezond bot om de componenten in vast te zetten en om deze te ondersteunen.

WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend DePuy modulaire femurkoppen en DePuy-acetabulumcomponenten met DePuy modulaire femurstelen. De conische grootte van de femurkop MOET worden afgestemd op de conische grootte van de femursteel.

Gecementeerde componenten

Deze femursteel met het label “Uitsluitend voor gecementeed gebruik” is bedoeld voor gebruik met botcement.

Patiëntenpopulatie

De beoogde patiëntenpopulatie bestaat uit patiënten met een volgroeid skelet waar er bewijs is van voldoende gezond bot om de componenten in vast te zetten en om deze te ondersteunen.

INDICATIES

Totale heupvervanging wordt geïndiceerd in de volgende omstandigheden:

1. Een zeer pijnlijk en/of artritisch gewricht (meestal als gevolg van een niet-inflammatoire degeneratieve gewrichtsaandoening)
2. Mislukte vorige heupoperatie
3. Acute breuk van de femurkop of -nek

CONTRA-INDICATIES

1. Actieve lokale of systemische infectie.
2. Verlies van musculatuur, neuromusculaire aantasting of vasculaire deficiëntie in het aangedane lidmaat waardoor de procedure onverantwoord is.
3. Slechte botkwaliteit, zoals osteoporose, wat naar de mening van de chirurg zou kunnen resulteren in een aanzienlijke migratie van de prothese, een substantiële verandering van de fractuur van de femurschacht en/of een gebrek aan adequaat bot om het implantaat/de implantaten te ondersteunen.
4. Ziekte van Charcot of Paget.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMATREGELEN

- Implantaten en proefcomponenten van verschillende fabrikanten of implantaatsystemen mogen nooit samen worden gebruikt.
- Heupprothese-componenten mogen nooit opnieuw worden geïmplanterd. Hoewel het implantaat onbeschadigd lijkt, kan het implantaat microscopische onvolkomenheden hebben ontwikkeld die tot falen kunnen leiden.
- Gebruik een testprothese altijd voor testdoeleinden. Testcomponenten mogen niet worden geassembleerd met componenten die zijn bedoeld voor permanente implantatie. Testcomponenten moeten dezelfde configuratie, maat, enz. hebben als de overeenkomstige, permanent te implanteren componenten.
- Door DePuy vervaardigde hulpmiddelen voor eenmalig gebruik zijn niet ontworpen om na gebruik bij een enkele patiënt enigerlei vorm van verandering, zoals demontage, reiniging of hersterilisatie, te ondergaan en zijn hier ook niet tegen bestand. Hergebruik kan de werking van het hulpmiddel en de veiligheid van de patiënt in gevaar brengen.
- De implantaten mogen op geen enkele wijze worden veranderd of aangepast.

- Kwaliteit van de botmassa is van cruciaal belang om de fixatie van het hulpmiddel te garanderen. Overweeg bottransplantatie en andere versterkingstechnieken, vooral bij het uitvoeren van een revisieoperatie, om het hulpmiddel vast te zetten en te ondersteunen.

LET OP: de volgende condities, afzonderlijk of gelijktijdig, kunnen de aangedane extremiteit zwaar belasten, waardoor er een groter risico is dat de heupvervanging van de patiënt mislukt:

1. Obesitas of overgewicht van de patiënt.
2. Zwaar werk.
3. Sportbeoefening met matige tot hoge intensiteit.
4. Hoge niveaus van patiëntactiviteit.
5. Waarschijnlijkheid van valpartijen.
6. Actief alcohol- of drugsmisbruik.
7. Andere beperkingen, voor zover van toepassing.

LET OP: de volgende condities, afzonderlijk of gelijktijdig, kunnen de fixatie van heupprothese-implantaten nadelig beïnvloeden:

1. Duidelijke osteoporose of slechte botmassa.
2. Metabole aandoeningen of systemische farmacologische behandelingen die leiden tot een progressieve verslechtering van de ondersteuning van het implantaat met vast bot (bijv. diabetes mellitus, steroïdenbehandelingen, immunosuppressieve behandelingen, enz.).
3. Geschiedenis van algemene of lokale infecties.
4. Ernstige misvormingen die leiden tot verminderde fixatie of onjuiste plaatsing van het implantaat.
5. Tumoren van de ondersteunende botstructuren.
6. Allergische reacties op implantaatmaterialen (bijv. botcement, metaal).
7. Weefselreacties op corrosie of slijtagedeeltjes van het implantaat.
8. Invaliditeit van andere gewrichten (d.w.z. knieën en enkels).

OPMERKING: diabetes is op dit moment niet als contra-indicatie vastgesteld. Vanwege het verhoogde risico op complicaties zoals infectie, langzame wondgenezing, enz. dient de arts echter zorgvuldig te overwegen of een heupprothese bij de ernstig diabetische patiënt wenselijk is.

De chirurgische en postoperatieve behandeling van de patiënt moet worden uitgevoerd met inachtneming van alle bestaande aandoeningen. Mentale houdingen of stoornissen die ertoe leiden dat een patiënt zich niet aan de bevelen van de chirurg houdt, kunnen het postoperatieve herstel vertragen en/of het risico op nadelige gevolgen, waaronder falen van het implantaat of de fixatie van het implantaat, vergroten.

Overmatige fysieke activiteit of trauma aan het vervangen gewricht kan bijdragen aan het voortijdig falen van de heupvervangings door het

veroorzaken van een verandering in positie, breuk en/of slijtage van de implantaten.

VERWACHTE KLINISCHE VOORDELEN TOTALE HEUPPROTHESE

Bij totale heupartroplastiek wordt verwacht dat de mobiliteit van de patiënt wordt vergroot en pijn wordt verminderd door vervanging van de articulatie van het beschadigde heupgewricht bij patiënten met een volgroeid skelet waar er bewijs is van voldoende gezond bot om de componenten in vast te zetten en om deze te ondersteunen.

SAMENVATTING VAN DE VEILIGHEID EN KLINISCHE PRESTATIES (SSCP; SUMMARY OF SAFETY AND CLINICAL PERFORMANCE)

Sommige landen of regio's hebben registers voor heupvervanging die de prestaties van heupimplantaten volgen. Deze registergegevens zijn geanalyseerd en tonen aan dat de eerste totale heupprothese van een persoon over het algemeen 95% (95 van de 100) van de keren meer dan 10 jaar meegaat. Dit betekent dat in 10 jaar tijd ongeveer 5% (5 van de 100) van de patiënten extra operaties kan hebben gehad om onderdelen te verwijderen. Bij een revisie-heupvervanging gaat in het algemeen 80% langer dan 10 jaar mee. Dit hulpmiddel voldoet aan deze algemene levensduur voor implantaten. Het risico van extra operaties voor een individuele patiënt zal afhangen van patiënt-specifieke factoren, zoals anatomie, medische toestand en levensstijl (bijv. gewicht en niveau van activiteit), de chirurgische ingreep en het proces.

Een SSCP die specifiek is voor het hulpmiddel is te vinden met de volgende link: <http://ec.europa.eu/tools/eudamed>

Opmerking: de Eudamed-link zal pas beschikbaar zijn nadat de Eudamed-database online is gezet.

Melding van ernstige incidenten

Elk ernstig incident dat zich in verband met het hulpmiddel heeft voorgedaan, moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd. Onder een ernstig incident wordt verstaan: elk incident dat direct of indirect heeft geleid, mogelijk heeft geleid of zou kunnen leiden tot een van de volgende voorvallen:

- a) het overlijden van een patiënt, gebruiker of andere persoon;
- b) de tijdelijke of permanente ernstige verslechtering van de gezondheidstoestand van een patiënt, gebruiker of andere persoon;
- c) een ernstige bedreiging van de volksgezondheid.

INFORMATIE VOOR HET GEBRUIK

Preoperatief

DE CHIRURG MOET VÓÓR DE OPERATIE ALLE FYSIEKE EN MENTALE BEPERKINGEN DIE SPECIFIEK VOOR DE PATIËNT GELDEN, EN ALLE ASPECTEN VAN DE OPERATIE EN DE PROTHESE(N), MET DE PATIËNT BESPREKEN. Het gesprek moet gaan over de beperkingen en mogelijke gevolgen van gewrichtsvervanging, de noodzaak om de instructies van de chirurg na de operatie op te volgen en de informatie die in de bijsluiter wordt gegeven.

De preoperatieve planning en de chirurgische technieken voor de implantatie van deze heupprothese-componenten zijn voortgekomen uit de chirurgische ervaring die is opgedaan tijdens de ontwikkeling van vele heupprothesen. Chirurgen mogen niet beginnen met het klinisch gebruik van een heupprothese voordat zij zich grondig vertrouwd hebben gemaakt met de specifieke implantatietechniek. Brochures over chirurgische techniek zijn verkrijgbaar bij DePuy.

Intraoperatief

Het wordt aanbevolen om bij de operatie componenten van ten minste één maat groter en één maat kleiner dan preoperatief bepaald beschikbaar te stellen voor de intraoperatieve selectie van de juiste maat/maten.

De beschermhoezen moeten blijven zitten totdat de componenten klaar zijn om te worden geïmplant. Gebruik geen componenten die zijn gevallen of die een hard oppervlak hebben geraakt. Schade aan het component is mogelijk niet zichtbaar, maar kan wel leiden tot vroegtijdig falen van de prothese. De chirurgische instrumenten die in de chirurgische techniek staan, zijn ontworpen voor deze artroplastiekprocedure en moeten worden gebruikt zoals getoond in de brochure over chirurgische techniek. Voordat een keramische femurkop wordt geïmplant, moet de conus op de femursteel worden schoongeveegd van bloed, botsplinters of andere vreemde materialen. Vreemd materiaal tussen de kop en de conus van de femursteel kan de juiste plaatsing van de kop op de steel belemmeren. Dit kan van invloed zijn op de prestaties van de femurkop of het vergrendelmechanisme tussen de femurkop en de femursteel.

Bij het uitvoeren van een revisieoperatie is het absoluut noodzakelijk dat alle bindweefselmembranen die de falende prothese inkapselen in hun geheel worden verwijderd. Resterende bindweefselmembranen kunnen de fixatie van het implantaat verstoren. Controleer alle reeds bestaande hulpmiddelen op schade aan de passende oppervlakken die een adequate plaatsing of vergrendeling van het nieuwe hulpmiddel zouden verhinderen. Onjuiste selectie, plaatsing of positionering van implantaten kan leiden

tot ongewone stresscondities en een daaropvolgende vermindering van de functionele levensduur van het implantaat. Een femursteel in varus verhoogt de spanning op de proximale mediale femorale cortex en kan leiden tot het loskomen van het implantaat. Voorafgaand aan de sluiting moet de operatieplek grondig worden gereinigd van botsplinters, vreemd botcement, ectopisch bot, enz. Vreemde deeltjes aan het oppervlak van de metaal/kunststof-, keramiek/kunststof- of keramiek/keramiek-interface kunnen overmatige slijtage veroorzaken. Het bewegingsbereik moet grondig worden gecontroleerd op onjuiste aansluiting, instabiliteit of knelling en indien nodig worden gecorrigeerd.

Postoperatief

Het is uiterst belangrijk dat de patiënt zich strikt aan de instructies en waarschuwingen van de chirurg houdt. In de postoperatieve zorg moeten geaccepteerde werkwijzen worden gevolgd.

De patiënt dient bij ontslag uit het ziekenhuis volledige schriftelijke instructies en waarschuwingen te ontvangen met betrekking tot oefeningen en behandelingen en eventuele beperkingen van zijn/haar activiteiten. Een verkeerde positie van de componenten of het gebruik van een beperkte heup of een totale heup met een modulaire gerande kop of conisch gevormde manchet kan het bewegingsbereik van het gewricht verminderen en kan de kans op slijtage van de componenten, aantasting, voortijdige dislocatie of revisie vergroten. In deze gevallen moet de chirurg de patiënt erop wijzen dat activiteiten met een groot bewegingsbereik moeten worden vermeden.

Voortdurende periodieke vervolgspraken met de patiënt worden aanbevolen vanwege de onbekende functionele levensduur van het implantaat bij de specifieke patiënt, met name wat betreft het behoud van de fixatie van het implantaat en de dragende oppervlakken. Er moet bij elke vervolgspraak radiologisch onderzoek worden uitgevoerd, en dit onderzoek moet worden vergeleken met eerdere radiologische onderzoeken en gecorreleerd met de klinische beoordeling van de patiënt. Als er radiologische veranderingen worden waargenomen, zoals het optreden van radioluentie, botresorptie of veranderingen in de positie van een implantaat, moeten deze veranderingen nauwlettend worden gevolgd om te bepalen of ze statisch of progressief zijn en of de patiënt op de juiste manier wordt behandeld.

BIJWERKINGEN EN COMPLICATIES

De volgende zaken zijn over het algemeen de meest voorkomende bijwerkingen en complicaties bij heupartoplastiek:

Algemeen

De frequentie en de ernst van de complicaties bij heupvervanging zijn meestal groter bij revisies dan bij primaire operaties. Veel voorkomende problemen bij revisiechirurgie zijn onder meer moeilijkheden bij het plaatsen van de incisie, het verwijderen van ectopisch bot en oud botcement, het plaatsen en fixeren van componenten en/of het verkrijgen van voldoende botondersteuning. Over het algemeen kunnen met revisieprocedures een verhoogde operatietijd, bloedverlies en risico op infectie, longembolie en wondhematomen worden verwacht.

1. Verandering in de positie van de prothesecomponenten, vaak gerelateerd aan de factoren die zijn vermeld in WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMATREGELEN.
2. Vroeg of laat loskomen van de prothesecomponenten, wat vaak gerelateerd is aan factoren die zijn vermeld in WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMATREGELEN.
3. Vermoeidheidsfractuur van de femursteel, wat vaak gerelateerd is aan factoren die zijn vermeld in WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMATREGELEN.
4. Overmatige slijtage of breuk van de dragende componenten als gevolg van: intraoperatieve schade aan de prothesecomponenten, los cement, botfragmenten, metalen deeltjes, keramische deeltjes of andere factoren die zijn vermeld in WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMATREGELEN.
5. Vroege of late infectie.
6. Perifere neuropathieën. Subklinische zenuwbeschadiging kan ook optreden als gevolg van chirurgisch trauma.
7. Weefselreacties, osteolyse en/of losraken van het implantaat door metaalcorrosie, allergische reacties, slijtage of partikelresten (zoals los cement, metalen, polyethyleen of keramische deeltjes).
8. Nog aanwezige pijn in de heup.

Intraoperatief

1. De perforatie van de femurschacht, een scheur of een breuk wat ervoor kan zorgen dat het gebruik van interne fixatie nodig is.
2. Trochanterbreuk.
3. Beschadiging van bloedvaten (bijv. arteria iliaca, obturatoria en femoralis).
4. Tijdelijke of permanente zenuwbeschadiging (bijv. nervus femoralis, obturatorius of geïsoleerde nervus peroneus).
5. Subluxatie of dislocatie van het heupgewricht als gevolg van de selectie van de implantaatgrootte of -configuratie, positionering van componenten en/of slapheid van spieren en bindweefsel.

6. Verlenging of verkorting van de aangedane extremiteit.
7. Vertraging van de ingreep.

Vroeg postoperatief

1. Cardiovasculaire aandoeningen, waaronder veneuze trombose, longembolie en hartinfarct.
2. Hematoom en/of vertraagde wondgenezing.
3. Subluxatie of dislocatie.
4. Dissociatie van modulaire componenten.

Laat postoperatief

1. Trochanteravulsie door excessieve spierspanning, gewichtsbelasting of onbedoelde intraoperatieve verzwakking van de trochanter.
2. Verzwaring van problemen in de ipsilaterale of contralaterale knie- en enkelgewrichten als gevolg van beenlengteverschillen, femorale medialisatie en/of spiartekorten.
3. Femorale breuk als gevolg van trauma of overmatige belasting, met name in de aanwezigheid van een slechte botmassa als gevolg van ernstige osteoporose, botdefecten van eerdere operaties, intraoperatieve ruimingsprocedures of botresorptie.
4. Botresorptie die kan bijdragen aan de verslechtering van de fixatie en het uiteindelijk losraken van het implantaat.
5. Afname in mobiliteit en bewegingsbereik van het gewricht (bijv. door periarticulaire verkalking of ossificatie).
6. Traumatische artrose van de ipsilaterale knie die secundair is aan intraoperatieve positionering van de extremiteit tijdens de operatie.
7. Subluxatie of dislocatie.
8. Dissociatie van modulaire componenten.

INFORMATIE OVER MRI-VEILIGHEID

Informatie over MRI-veiligheid Een patiënt met de DePuy Corail Cemented-constructie kan onder de volgende voorwaarden worden gescand. Als u zich niet aan deze voorwaarden houdt, kan dit leiden tot letsel bij de patiënt. 	
Naam/identificatie van het apparaat	CORAIL Cemented-heupprothese
Nominale waarde(n) van het statische magneetveld [T]	1,5 T of 3,0 T

Maximale ruimtelijke veldgradiënt [T/m en gauss/cm]	30 T/m (3.000 gauss/cm)
RF-bekrachtiging	Cirkelvormig gepolariseerd (CP)
Type RF-zendspoel	Zendspoel voor het hele lichaam, RF-zend-ontvangstspoel voor het hoofd
Bedrijfsmodus	Normale bedrijfsmodus
Maximaal SAR voor het hele lichaam	2,0 W/kg (normale bedrijfsmodus)
Maximaal SAR voor het hoofd	Het is niet nodig om een hoofdspoel te gebruiken voor het scannen van de heup
Beperkingen van de duur van het scannen	SAR van 2,0 W/kg gemiddeld over het hele lichaam Scan maximaal 15 minuten, gevolgd door een afkoelingsperiode van 15 minuten (kan maximaal drie keer worden herhaald in één beeldvormingssessie)
MR-beeldartefact	De aanwezigheid van dit implantaat zal naar verwachting geen beeldartefact produceren dat langer is dan 108 mm
Aanvullende instructies of essentiële informatie voor een veilig gebruik in de MRI-omgeving	*Controleer alle onderdelen van de heupprothese op etiketten met aanvullende MRI-informatie

AFVOER

Voer alle gebruikte hulpmiddelen veilig af in overeenstemming met de lokale procedures en richtlijnen.

BETEKENIS VAN SYMBOLEN

D/DP

DEPUY



Let op



Fabrikant

REF

Catalogusnummer



Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing



Uiterste gebruiksdatum

LOT

Batchcode



www.e-IFU.com
US / Canada 800-255-2500
EU: +800 8888 2020
EU: +32 2 4037222

Website e-IFU (digitale
gebruiksaanwijzing)

Sterile

Steriel

Sterile R

Gesteriliseerd met straling



Niet opnieuw steriliseren



Niet gebruiken als de
verpakking beschadigd is



Niet opnieuw gebruiken



MR Voorwaardelijk



Verpakkingseenheid

MATERIAL

Constructiemateria(a)l(en)

MD

Medisch hulpmiddel



Dubbel steriel
barrièresysteem



Recyclebaar



RT / LT

Rechts/links

MADE IN

Gefabriceerd in

S

Roestvrij staal

SIZE/SZ/DIA/IN/ft/DEG/GRP/lb/OD/ID

Maat/grootte/diameter/inch/voet/graden/groep/pounds/
buitendiameter/binnendiameter

CORAIL Cemented-hofteprotese

VIKTIG INFORMASJON – Les før bruk

Noen produkter er kanskje ikke lisensiert i alle jurisdiksjoner.



STERILE

Se produktetikett for metode

Nettsted for bruksanvisning (IFU).

For tilgang til elektronisk bruksanvisning og eventuelle andre språk, gå til www.e-IFU.com

Implantatkort, pakningsvedlegg (PIL) og nettside

Implantatkortet (og implantatkortetiketten) følger med i pakken med implantatet. Informasjonen i pakningsvedlegget (PIL) er basert på informasjonen i denne bruksanvisningen. ePIL (elektronisk pakningsvedlegg) finner du på nettsiden nedenfor. For tilgang til det elektroniske pakningsvedlegget, gå til www.ic.jnjmedicaldevices.com

FORSIKTIG: Ifølge føderal lovgivning i USA kan denne enheten kun selges av eller på forordning av en lege.

BESKRIVELSE AV ENHETEN

Dette er en femur-hoftestamme av metall. En total hofteprotese består av individuelt emballert femur-hoftestamme av metall, modulært metall- eller keramisk femurhode og to deler metallstøttet polyetylen med ultrahøy molekylvekt (UHMWPE), keramiske eller alle UHMWPE acetabulære komponenter som er utformet for å erstatte den naturlige leddoverflaten på hofteleddet.

MATERIALER

Informasjonen nedenfor viser stoffene i implantatet. Ytterligere sporstoffer kan være til stede på grunn av produksjonsprosessen. Ta kontakt via adressen nedenfor for mer informasjon.

Eksempel på akronym brukt på etikett(er):	Material-beskrivelse:	Materiale inneholder nominelt følgende stoffer:
S1	Rustfri stållegering	Jern (63 %) Krom (21 %) Nikkel (10 %) Mangan (3 %) Molybden (3 %) Mindre enn 1 % av niobium og nitrogen

LEVERINGSMÅTE

Disse enhetene er pakket individuelt og leveres STERILE. De skal kun fjernes fra pakningen med godkjent aseptisk teknikk etter at riktig størrelse er bestemt. Ikke bruk disse komponentene hvis den sterile emballasjen ser ut til å være skadet eller åpnet ved et uhell.

TILTENKT BRUK

Tiltenkt bruker

Disse enhetene skal ikke brukes av ukvalifisert personell. Det er avgjørende at kirurgen og operasjonsteamet er helt kjent med riktig kirurgisk teknikk for implantatet og tilhørende instrumenter.

Tiltenkt bruk – total hofteprotese

Total hofteartroplastikk er tiltenkt å erstatte det ødelagte hofteleddet hos pasienter der det er påvist tilstrekkelig sunt bein til å feste og støtte komponentene.

ADVARSEL: Bruk kun DePuy modulære femurhoder og DePuy acetabulære komponenter med DePuy modulære femurstammer. Konusstørrelsen av femurhodet MÅ tilpasses til konusstørrelsen av femurstammen.

Sementerte komponenter

Denne femurstammen merket «Kun for sementert bruk» er beregnet for bruk med beinsement.

Pasientpopulasjon

Den tiltenkte pasientpopulasjonen er pasienter med modent skjelett der det er påvist tilstrekkelig sunt bein til å feste og støtte komponentene.

INDIKASJONER

Total hofteartroplastikk er indisert under følgende forhold:

1. Et svært smertefullt og/eller artritttrammet ledd (vanligvis på grunn av ikke-inflammatorisk degenerativ leddsykdom)
2. Tidligere mislykket hoftekirurgi
3. Akutt fraktur i femurhode eller -hals

KONTRAINDIKASJONER

1. Aktiv lokal eller systemisk infeksjon.
2. Tap av muskulatur, skade på nevmuskulatur eller vaskulær defisiens i berørt ekstremitet som gjør prosedyren uforsvarlig.
3. Dårlig beinkvalitet, for eksempel osteoporose, hvor det etter kirurgens vurdering kan oppstå vesentlig migrering av protesen eller stor risiko for femurfraktur og/eller mangel på tilstrekkelig beinvev til å støtte implantatet/implantatene.
4. Charcots eller Pagets sykdom.

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

- Implantater og testkomponenter fra forskjellige produsenter eller implantatsystemer skal aldri brukes sammen.
- Hofteprotesekomponenter skal aldri implanteres på nytt. Selv om implantatet virker uskadd, kan implantatet ha utviklet mikroskopiske ufullkommenheter som kan føre til svikt.
- Bruk alltid en prøveprotese til testformål. Testenheter skal ikke settes sammen med komponenter som er beregnet for permanent implantasjon. Prøvekomponenter må ha samme konfigurasjonsstørrelse osv. som tilsvarende komponenter som skal implanteres permanent.
- Engangsprodukter fra DePuy er ikke utformet til å gjennomgå eller tåle noen form for endringer, slik som demontering, rengjøring eller resterilisering etter engangsbruk på én pasient. Gjenbruk kan potensielt redusere enhetens ytelse og pasientens sikkerhet.
- Implantater skal verken endres eller modifiseres på noen måte.
- Beinmasse av god kvalitet er avgjørende for å sikre fiksering av enheten. Vurder beintransplantasjon og andre forsterkningsteknikker, spesielt når du utfører revisjonskirurgi, for å plassere og støtte enheten.

FORSIKTIG: Følgende forhold, enkeltvis eller samtidig, har en tendens til å gi høy belastning på den berørte ekstremiteten, og derved utsette pasienten for større risiko for svikt i hofteprotesen:

1. Fedme eller stor pasientvekt
2. Manuelt arbeid
3. Sportsutøvelse med moderat til høy belastning
4. Høye nivåer av pasientaktivitet
5. Fallrisiko

6. Aktivt alkohol- og stoffmisbruk
7. Andre eventuelle funksjonshemninger

FORSIKTIG: Følgende forhold, enkeltvis eller samtidig, har en tendens til å påvirke fiksering av hofteproteseimplantater negativt:

1. Markert osteoporose eller dårlig beinmasse.
2. Metabolske forstyrrelser eller systemiske farmakologiske behandlinger som fører til progressiv forverring av støtte for fast bein for implantatet (f.eks. diabetes mellitus, steroidterapi, immunsuppressiv behandling osv.).
3. Historikk med generelle eller lokale infeksjoner.
4. Alvorlige misdannelser som fører til nedsatt fiksering eller feilplassering av implantatet.
5. Svulster i støttebeinstrukturer.
6. Allergiske reaksjoner på implantatmaterialer (f.eks. beinsement, metall).
7. Vevsreaksjoner på implantatkorrosjon eller slitasje på implantater.
8. Funksjonshemming i andre ledd (dvs. knær og ankler).

MERK: Diabetes har for øyeblikket ikke blitt etablert som en kontraindikasjon. På grunn av økt risiko for komplikasjoner som infeksjon, langsom sårtilheling osv., bør legen imidlertid vurdere om hofteartroplastikk er tilrådelig hos pasienter med alvorlig diabetes.

Kirurgisk og postoperativ behandling av pasienten må utføres med behørig hensyn til alle eksisterende forhold. Mentale holdninger eller lidelser som fører til at pasienten ikke overholder kirurgens anvisninger, kan forsinke postoperativ restitusjon og/eller øke risikoen for bivirkninger, inkludert implantat- eller implantatfikseringssvikt.

Overdreven fysisk aktivitet eller traumer i det utskiftede leddet kan bidra til prematur svikt i hofteprotesen ved å forårsake endring i posisjon, brudd og/eller slitasje på implantatene.

**FORVENTEDE KLINISKE FORDELER
TOTAL HOFTEPROTESE**

Total hofteartroplastikk erstatter det ødelagte hofteleddet hos pasienter med modent skjelett som har holdepunkter for tilstrekkelig friskt bein til å plassere og støtte komponentene.

SAMMENDRAG AV SIKKERHET OG KLINISK YTTELSE

Enkelte land eller regioner har hoftestatningsregistre som overvåker hofteimplantatenes ytelse. Disse registerdataene ble analysert og viser at første gang en person får en total hofteprotese, varer den i mer enn ti år hos omtrent 95 % (95 av 100). Dette betyr at om ti år kan omtrent 5 % (5 av 100) pasienter kan ha hatt ytterligere kirurgi for å fjerne en

eller flere deler. Ved hofteproteserevisjon: generelt varer 80 % i mer enn 10 år. Denne enheten oppfyller denne generelle implantatlevetiden. Risikoen ved tilleggsoperasjoner hos en individuell pasient avhenger av pasientspesifikke faktorer som anatomi, medisinsk tilstand og livsstil (f.eks. vekt og aktivitetsnivå), den kirurgiske prosedyren og prosessen.

Enhetsspesifikk SSCP finner du på følgende lenke:

<http://ec.europa.eu/tools/eudamed>

Merk: Eudamed-lenken er kun tilgjengelig etter at Eudamed-databasen er aktiv.

Rapportering av alvorlige hendelser

Alle alvorlige hendelser som har oppstått i forbindelse med enheten, skal rapporteres til produsenten og kompetent myndighet i medlemslandet hvor brukeren og/eller pasienten er etablert.

Alvorlig hendelse betyr enhver hendelse som direkte eller indirekte førte til, kan ha ført til eller kan føre til ett av følgende:

- a) dødsfall hos en pasient, bruker eller annen person
- b) midlertidig eller permanent alvorlig forverring av en pasients, brukers eller annen persons helsetilstand
- c) en alvorlig trussel mot folkehelsen

BRUKSINFORMASJON

Preoperativt

KIRURGEN SKAL DISKUTERE ALLE FYSISKE OG MENTALE BEGRENSNINGER SOM ER SPESIFIKKE FOR PASIENTEN OG ALLE ASPEKTER AV KIRURGI OG PROTESENE FOR PASIENTEN FØR DET KIRURGISKE INNGREPET. Diskusjonen bør omfatte begrensningene og de mulige konsekvensene av leddprotesekirurgi, nødvendigheten av å følge kirurgens instruksjoner postoperativt og informasjonen i pasientbrosjyren.

Preoperativ planlegging og kirurgiske teknikker for implantasjon av hofteprotesekomponentene har utviklet seg fra den kirurgiske erfaringen som ble oppnådd under utviklingen av mange hofteproteser. Kirurger bør ikke begynne med klinisk bruk av en hofteprotese før de har gjort seg grundig kjent med den spesifikke implantasjonsteknikken. Kirurgiske teknikkbrosjyrer er tilgjengelige fra DePuy.

Intraoperativt

Det anbefales at komponenter som er minst en størrelse større og en størrelse mindre enn det som ble bestemt før operasjonen, er tilgjengelige ved kirurgi for å imøtekomme intraoperativt valg av riktig(e) størrelse(r).

Beskyttelsesdeksler skal være på til komponentene er klare til å implanteres. Ikke bruk komponenter dersom de har falt ned eller har truffet en hard overflate. Skade på komponenten er kanskje ikke synlig, men kan føre

til tidlig protesevikt. De kirurgiske instrumentene som omtales under kirurgiske teknikker, har blitt utformet for denne artroplastiske prosedyren og må brukes som vist i brosjyren om kirurgisk teknikk. Før det implanteres et keramisk femurhode, bør hannkonusen på femurstammen tørkes ren for blod, beinfliser eller andre fremmedlegemer. Fremmedlegemer mellom hodet og femurstammekonusen kan hindre riktig plassering av hodet på stammen. Dette kan påvirke femurhodets eller låsemekanismens ytelse mellom femurhodet og femurstammen.

Når du utfører revisjonskirurgi, er det viktig at enhver fibrøs membran som innkapsler den mislykkede protesen, fjernes i sin helhet. Resterende fibrøse membraner kan forstyrre implantatfikseringen. Gjennomgå eventuelle eksisterende enheter for skade på motstående overflater som kan forhindre tilstrekkelig plassering eller låsing av den nye enheten. Feil valg, plassering eller posisjonering av implantater kan føre til uvanlige belastningsforhold og påfølgende reduksjon i implantatets funksjonelle levetid. Merk at en femurstamme plassert i varus øker belastningen på proksimal medial femoral cortex og kan føre til at implantatet løsner. Før lukking bør operasjonsstedet rengjøres grundig for beinfliser, fremmed beinsement, ektopisk bein osv. Fremmedpartikler ved kontaktflaten mellom metall/plast eller keramikk/plast eller keramikk/keramikk kan forårsake stor slitasje. Bevegelsesområdet bør kontrolleres grundig for feil tilpasning, ustabilitet eller hindring og korrigeres etter behov.

Postoperativt

Pasientens strenge overholdelse av kirurgens instruksjoner og advarsler er ekstremt viktig. Akseptert praksis bør følges opp under postoperativ behandling.

Pasienten skal utskrives fra sykehuset med komplette skriftlige instruksjoner og advarsler angående øvelser og terapier og eventuelle begrensninger på deres aktiviteter. Feilstilling av komponenter eller bruk av begrenset hofte eller total hofte med modulært skjørthode eller avsmalnende erme kan redusere leddets bevegelsesområde og kan øke potensialet for komponentslitasje, prematur dislokasjon eller revisjon. I disse tilfellene bør kirurgen informere pasienten om at store bevegelsesaktiviteter bør unngås.

En kontinuerlig periodisk pasientoppfølging anbefales på grunn av implantatets ukjente funksjonelle levetid hos den spesifikke pasienten, spesielt med hensyn til vedlikehold av implantatfiksering og bærende flater. Radiologiske undersøkelser bør utføres ved hver oppfølging og sammenlignes med tidligere radiologiske undersøkelser og korreleres med pasientens kliniske vurdering. Dersom det observeres radiologiske endringer, for eksempel forekomst av radiolucens, beinresorpsjon eller endringer i implantatposisjonen, bør disse endringene overvåkes nøye for å avgjøre om de er statiske eller progressive og pasienten behandles riktig.

BIVIRKNINGER OG KOMPLIKASJONER

Følgende er vanligvis de hyppigst forekommende bivirkningene og komplikasjonene ved hofteartroplastikk:

Generelt

Forekomsten og alvorlighetsgraden av komplikasjoner ved hofteprotese er vanligvis større ved revisjoner enn ved de opprinnelige operasjonene. Vanlige problemer som oppstår ved revisjonskirurgi, kan inkludere vanskeligheter med å plassere innsnittet, fjerning av ektopisk bein og gammel beinsement, plassering og fiksering av komponenter og/eller å få tilstrekkelig beinstøtte. Generelt kan det forventes økt operasjonstid, blodtap og risiko for infeksjon, lungeemboli og sårhematom ved revisjonsprosedyrer.

1. Endre protese komponentenes posisjon, ofte relatert til faktorene som er oppført i ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER.
2. Tidlig eller sen løsning av protese komponentene, ofte relatert til faktorer oppført i ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER.
3. Utmattelsesbrudd i femurstammen, ofte relatert til faktorer som er oppført i ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER.
4. Overdreven slitasje eller brudd på de bærende komponentene på grunn av: Intraoperativ skade på protese komponentene, løs sement, beinfragmenter, metallpartikler, keramiske partikler eller andre faktorer som er oppført i ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER.
5. Tidlig eller sen infeksjon.
6. Perifere nevropatier. Subkliniske nerveskader kan også oppstå som et resultat av kirurgisk traume.
7. Vevsreaksjoner, osteolyse og/eller implantatløsning forårsaket av metallisk korrosjon, allergiske reaksjoner, slitasje eller partikkelrester (som løs sement, metallisk, polyetylen eller keramiske partikler).
8. Restsmerter i hoften.

Intraoperativt

1. Perforering, sprekk eller brudd på femurstammen, som kan kreve bruk av intern fiksering.
2. Trokanterisk brudd.
3. Skader på blodkar (f.eks. arteria iliaca, obturatoria og femoralis).
4. Midlertidig eller permanent nerveskade (f.eks. nervus femoralis, obturatoria eller isolert nervus peroneus).
5. Subluksasjon eller dislokasjon av hofteleddet på grunn av implantatstørrelse eller konfigurasjonsvalg, posisjonering av komponenter og/eller slapphet i muskelvev og fibrøst vev.
6. Forlengelse eller forkortelse av berørt ekstremitet.
7. Kirurgisk forsinkelse.

Tidlig postoperativt

1. Kardiovaskulære lidelser, inkludert venetrombose, lungeemboli og myokardinfarkt.
2. Hematom og/eller forsinket sårheling.
3. Subluksasjon eller dislokasjon.
4. Løsning av modulære komponenter.

Sent postoperativt

1. Trokanterisk avulsjon fra overdreven muskelspenning, vektbelastning eller utilsiktet intraoperativ svekkelse av trokanter.
2. Forverring av problemer i de ipsilaterale eller kontralaterale kne- og ankelleddene på grunn av avvik mellom beinlengde, medialisering av femur og/eller muskelmangel.
3. Femurfraktur på grunn av traumer eller overdreven belastning, spesielt i nærvær av dårlig beinmasse forårsaket av alvorlig osteoporose, beindefekter fra tidligere kirurgi, intraoperative reamingprosedyrer eller beinresorpsjon.
4. Beinresorpsjon som kan bidra til forverring av fiksering og påfølgende løsning av implantatet.
5. Redusert leddmobilitet og bevegelsesområde (f.eks. forårsaket av periartikulær forkalkning eller ossifikasjon).
6. Traumatisk artrose i det ipsilaterale kneet sekundært til intraoperativ posisjonering, i ekstremiteten under operasjonen.
7. Subluksasjon eller dislokasjon.
8. Løsning av modulære komponenter.

MR-SIKKERHETSINFORMASJON



MR-sikkerhetsinformasjon

En pasient med en DePuy Corail sementert enhet kan skannes under følgende forhold. Unnlattelse av å følge disse forholdene kan føre til pasientskade.

Navn på / identifikasjon av enheten	CORAIL Cemented-hofteprotese
Nominell(e) verdi(er) for statiske magnetfelt [T]	1,5 T eller 3,0 T
Maksimal romlig feltgradient [T/m og gauss/cm]	30 T/m (3000 gauss/cm)

RF-eksitasjon	Sirkularpolarisert (CP)
RF-senderspoletype	Senderspole for hele kroppen, RF-sender-/mottaksspole for hode
Driftsmodus	Normal driftsmodus
Spesifikk absorpsjonsrate for hele kroppen	2,0 W/kg (normal driftsmodus)
Maksimal spesifikk absorpsjonsrate for hode	Det er ikke nødvendig å bruke hodespole under skanning av hoften
Begrensninger av skannevarighet	2,0 W/kg gjennomsnittlig SAR for hele kroppen Skann i opptil 15 minutter etterfulgt av en 15 minutters avkjølingsperiode (kan gjentas opptil tre ganger i en enkelt avbildningsøkt)
MR-bildeartefakt	Implantatets tilstedeværelse ventes ikke å produsere et bildeartefakt som strekker seg lenger enn 108 mm
Ytterligere instruksjoner eller informasjon som er avgjørende for sikker bruk i MR-miljøet	*Sjekk alle komponenter i hoftekonstruksjonen for ytterligere MR-merkingsinformasjon

AVHENDING

Avhend alle enheter på trygg måte i samsvar med lokale rutiner og retningslinjer.

SYMBOLFORKLARING

D/DP

DEPUY



Obs!



Katalognummer



Se bruksanvisningen



Seriekode



www.e-IFU.com
US / Canada 800-255-2500
EU: +800 888 2020
EU: +32 2 4037222

Nettsted med elektronisk
bruksanvisning



Tilvirker



Siste bruksdato



Steril



Sterilisert ved bruk av
bestråling



Må ikke resteriliseres



Må ikke brukes dersom
pakningen er skadet



Må ikke brukes om igjen



MR-betinget



Emballasjeenhet



Materiale(r) for
konstruksjon



Medisinsk enhet



Dobbelt sterilt
barriersystem



Kan resirkuleres



RT / LT

Høyre/venstre



Produsert i

S

Rustfritt stål

SIZE/SZ/DIA/IN/ft/DEG/GRP/lb/OD/ID

Størrelse/størrelse/diameter/tommer/fot/grader/gruppe/
pund/ytre diameter/indre diameter

Prótese da Anca CORAIL Cemented

INFORMAÇÕES IMPORTANTES – Ler antes de utilizar

Alguns produtos podem não estar licenciados em todas as jurisdições.

**STERILE**

Consultar a etiqueta do produto relativamente ao método

Website de instruções de utilização

Para aceder às Instruções de Utilização em formato eletrónico e a outros idiomas adicionais visite www.e-IFU.com

Cartão de implante, folheto informativo do doente (PIL) e website

O cartão de implante (e a etiqueta do cartão de implante) é fornecido na embalagem com o implante. As informações contidas no folheto informativo do doente (PIL) baseiam-se nas informações contidas nestas instruções de utilização. O PIL eletrónico encontra-se disponível no website abaixo.

Para aceder ao Folheto informativo do paciente em formato eletrónico visite www.ic.jnjmedicaldevices.com

ATENÇÃO: A lei federal (EUA) limita a venda deste dispositivo a médicos ou por receita médica.

DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO

O dispositivo é uma haste femoral para anca metálica. Uma Prótese Total da Anca é constituída por uma haste femoral para anca metálica embalada individualmente, uma cabeça femoral modular metálica ou cerâmica e componentes acetabulares de 2 peças de polietileno de peso molecular muito elevado (UHMWPE) com suporte de metal, de cerâmica ou totalmente em UHMWPE concebidos para substituir a superfície articular natural da articulação da anca.

MATERIAIS

A informação abaixo lista as substâncias no implante. Podem estar presentes vestígios de substâncias adicionais devido ao processo de fabrico. Contacte o endereço abaixo para obter informações adicionais.

Exemplo de acrônimo utilizado na(s) etiqueta(s):	Descrição do material:	O material contém nominalmente as seguintes substâncias:
S1	Liga de aço inoxidável	Ferro (63%) Crômio (21%) Níquel (10%) Manganês (3%) Molibdênio (3%) Menos de 1% de nióbio e nitrogênio

APRESENTAÇÃO

Estes dispositivos são embalados individualmente e fornecidos ESTÉREIS. Remova da embalagem utilizando a técnica asséptica aceite somente depois de ter determinado o tamanho correto. Não utilize estes componentes se a embalagem estéril estiver danificada ou tiver sido aberta acidentalmente.

UTILIZAÇÃO PRETENDIDA

Utilizador pretendido

Estes dispositivos não devem ser utilizados por pessoal não qualificado. É essencial que o cirurgião e o pessoal do bloco operatório tenham um conhecimento profundo da técnica cirúrgica apropriada para o implante e instrumentos associados.

Utilização pretendida – Prótese total da anca

A artroplastia total da anca destina-se a substituir a articulação danificada da anca em pacientes nos quais existem evidências da existência de osso saudável suficiente para assentar e suportar os componentes.

ADVERTÊNCIA: Utilize apenas cabeças femorais modulares DePuy e componentes acetabulares DePuy com hastes femorais modulares DePuy. O tamanho do cone da cabeça femoral DEVE corresponder ao tamanho do cone da haste femoral.

Componentes cimentados

Esta haste femoral rotulada “Apenas para uso cimentado” destina-se a utilização com cimento ósseo.

População de pacientes

A população de pacientes alvo são pacientes esqueleticamente maduros, quando existem evidências da existência de osso saudável suficiente para assentar e suportar os componentes.

INDICAÇÕES

A implantação de prótese total da anca é indicada nas seguintes condições:

1. Uma articulação gravemente dolorosa e/ou artrítica (normalmente devido a doença articular degenerativa não-inflamatória)
2. Falha da cirurgia da anca prévia
3. Fratura aguda da cabeça ou colo do fêmur

CONTRAINDICAÇÕES

1. Infecção local ou sistêmica ativa.
2. Perda de musculatura, comprometimento neuromuscular ou déficit vascular no membro afetado, que tornem o procedimento injustificado.
3. Fraca qualidade óssea, como no caso de osteoporose, em que, na opinião do cirurgião, possa existir uma migração considerável da prótese ou uma probabilidade considerável de fratura da haste femoral e/ou ausência de osso adequado para suporte do(s) implante(s).
4. Doença de Charcot ou de Paget.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Implantes e componentes de prova de diferentes fabricantes ou sistemas de implantes diferentes nunca devem ser utilizados em conjunto.
- Os componentes da prótese da anca nunca devem ser reimplantados. Mesmo que o implante não pareça estar danificado, pode ter desenvolvido imperfeições microscópicas que podem originar a sua falha.
- Utilize sempre uma prótese de prova para fins de prova. Os componentes de prova não devem ser montados com quaisquer componentes destinados à implantação permanente. Os componentes de prova devem ter o mesmo tamanho de configuração, etc., que os componentes correspondentes a implantar permanentemente.
- Os dispositivos de utilização única fabricados pela DePuy não foram concebidos para serem submetidos nem para suportar qualquer forma de alteração, tal como desmontagem, limpeza ou reesterilização, após uma única utilização pelo paciente. A reutilização pode comprometer potencialmente o desempenho do dispositivo e a segurança do paciente.
- Não altere nem modifique os implantes de nenhuma forma.

- Um stock ósseo de qualidade é fundamental para garantir a fixação do dispositivo. Considere o enxerto ósseo e outras técnicas de reforço, especialmente ao realizar a cirurgia de revisão, para assento e suporte do dispositivo.

ATENÇÃO: As seguintes condições, singular ou concomitantemente, tendem a impor uma carga grave na extremidade afetada, colocando assim o paciente em maior risco de falha da prótese da anca:

1. Obesidade ou peso excessivo do paciente.
2. Trabalho manual.
3. Participação em desportos de exigência moderada a elevada.
4. Níveis elevados de atividade do paciente.
5. Probabilidade de quedas.
6. Abuso ativo de álcool ou drogas.
7. Outras incapacidades, conforme aplicável.

ATENÇÃO: As seguintes condições, singular ou concomitantemente, tendem a afetar negativamente a fixação dos implantes de prótese da anca:

1. Osteoporose acentuada ou stock ósseo fraco.
2. Perturbações do metabolismo ou tratamentos farmacológicos sistêmicos que originam a deterioração progressiva do suporte ósseo sólido para o implante (por ex., diabetes mellitus, terapêuticas com esteroides, terapêuticas imunossupressoras, etc.).
3. História de infeções gerais ou locais.
4. Deformidades graves que originam uma fixação deficiente ou o posicionamento incorreto do implante.
5. Tumores das estruturas ósseas de suporte.
6. Reações alérgicas aos materiais do implante (por ex., cimento ósseo, metal).
7. Reações teciduais à corrosão do implante ou resíduos de desgaste do implante.
8. Deficiências de outras articulações (ou seja, joelhos e tornozelos).

NOTA: Atualmente, a diabetes não é considerada uma contraindicação. No entanto, devido ao risco acrescido de complicações como infeção, cicatrização lenta das feridas, etc., o médico deve considerar cuidadosamente a conveniência de uma implantação de prótese da anca em pacientes com diabetes grave.

O tratamento cirúrgico e pós-operatório do paciente deve ser realizado com a devida consideração por todas as condições existentes. Atitudes ou perturbações mentais que resultem no não cumprimento por parte do paciente das ordens do cirurgião podem atrasar a recuperação pós-

operatória e/ou aumentar o risco de efeitos adversos, incluindo falha do implante ou da fixação do implante.

Atividade física excessiva ou trauma na articulação substituída pode contribuir para a falha prematura da prótese da anca, ao causar uma alteração na posição, fratura e/ou desgaste dos implantes.

BENEFÍCIOS CLÍNICOS ESPERADOS

PRÓTESE TOTAL DA ANCA

Espera-se que a artroplastia total da anca (ATA) permita um aumento da mobilidade do paciente e redução das dores ao substituir a articulação danificada da anca em pacientes esqueleticamente maduros, nos quais existem evidências da existência de osso são em quantidade suficiente para assento e suporte dos componentes.

RESUMO DO DESEMPENHO DE SEGURANÇA E CLÍNICO

Alguns países ou regiões têm registos de implantação da prótese da anca que monitorizam o desempenho dos implantes da anca. Estes dados de registo foram analisados e revelam que, no caso da primeira operação de implantação de prótese total da anca de um paciente, geralmente 95% (95 em cada 100) das próteses duram mais de 10 anos. Isto significa que, aos 10 anos, cerca de 5% (5 em cada 100) dos pacientes podem ter realizado cirurgias adicionais para remover componente(s). Para a implantação de revisão da anca, geralmente 80% duram mais de 10 anos. Este dispositivo cumpre a vida útil deste implante geral. O risco de operações adicionais de um paciente individual dependerá de fatores específicos do paciente, como a sua anatomia, condição médica e estilo de vida (por ex., peso e nível de atividade), do procedimento cirúrgico e do processo.

Um SSCP específico do dispositivo encontra-se disponível para consulta na seguinte hiperligação: <http://ec.europa.eu/tools/eudamed>

Nota: A hiperligação para a plataforma Eudamed só estará disponível após a entrada em funcionamento da base de dados Eudamed.

Comunicação de incidentes graves

Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou o paciente está estabelecido.

Incidente grave significa qualquer incidente que direta ou indiretamente levou, pode ter levado ou pode levar a qualquer um dos seguintes:

- a) a morte de um paciente, utilizador ou outra pessoa,
- b) a deterioração grave temporária ou permanente do estado de saúde de um paciente, utilizador ou outra pessoa,
- c) uma séria ameaça à saúde pública.

INFORMAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Pré-operatório

O CIRURGIÃO DEVE DISCUTIR TODAS AS LIMITAÇÕES FÍSICAS E MENTAIS ESPECÍFICAS DO PACIENTE E TODOS OS ASPETOS DA CIRURGIA E DAS PRÓTESES COM O PACIENTE ANTES DA CIRURGIA. A discussão deve incluir as limitações e possíveis consequências da substituição articular, a necessidade de cumprir as instruções do cirurgião no pós-operatório e as informações fornecidas no folheto do paciente.

O planejamento pré-operatório e as técnicas cirúrgicas de implantação destes componentes de implantação de prótese da anca evoluíram com base na experiência cirúrgica adquirida durante o desenvolvimento de muitas próteses da anca. Os cirurgiões não devem iniciar a utilização clínica de qualquer prótese da anca antes de se familiarizarem completamente com a sua técnica específica de implantação. Os folhetos sobre técnicas cirúrgicas estão disponíveis através da DePuy.

Intraoperatório

Recomenda-se que se garanta a disponibilidade na cirurgia de componentes, pelo menos, um tamanho acima e um tamanho abaixo do tamanho determinado no pré-operatório para acomodar a seleção intraoperatória do(s) tamanho(s) apropriado(s).

As coberturas protetoras devem permanecer instaladas até os componentes estarem prontos a implantar. Não utilize componentes que tenham caído ou que tenham batido numa superfície dura. Os danos no componente podem não ser visíveis, mas podem causar a falha precoce da prótese. Os instrumentos cirúrgicos identificados na técnica cirúrgica foram concebidos para este procedimento de artroplastia e devem ser utilizados conforme apresentado no folheto sobre a técnica cirúrgica. Antes de implantar uma cabeça femoral cerâmica, o cone macho na haste femoral deve ser limpo de quaisquer resíduos de sangue, lascas de osso ou outros materiais estranhos. Quaisquer materiais estranhos entre a cabeça e o cone da haste femoral podem impedir o assentamento adequado da cabeça na haste. Isto pode afetar o desempenho da cabeça femoral ou o mecanismo de bloqueio entre a cabeça femoral e a haste femoral.

Ao realizar a cirurgia de revisão, é imperativo que qualquer membrana fibrosa que encapsule a prótese falhada seja removida na totalidade. As membranas fibrosas residuais podem interferir com a fixação do implante. Reveja quaisquer dispositivos pré-existentes para detectar quaisquer danos nas superfícies de acoplamento que possam impedir o assentamento adequado ou o bloqueio do novo dispositivo. A seleção, colocação ou posicionamento incorreto dos implantes pode resultar

em condições de tensão invulgar e uma subsequente redução da vida funcional do implante. De salientar que uma haste femoral colocada em varo aumenta a tensão sobre o córtex femoral proximal medial e pode originar o afrouxamento do implante. Antes do encerramento, o campo cirúrgico deve ser cuidadosamente limpo de lascas de osso, cimento ósseo externo, osso ectópico, etc. Partículas estranhas na interface metal/plástico, cerâmica/plástico ou cerâmica/cerâmica podem causar desgaste excessivo. A amplitude de movimentos deve ser verificada minuciosamente para detetar acoplamento incorreto, instabilidade ou impacto e qualquer situação detetada deve ser corrigida conforme apropriado.

Pós-operatório

O cumprimento rigoroso por parte do paciente das instruções e advertências do cirurgião é extremamente importante. As práticas aceites devem ser cumpridas nos cuidados pós-operatórios.

O paciente deve ter alta do hospital com instruções completas por escrito e advertências acerca de exercícios físicos e terapêuticas e quaisquer limitações às suas atividades. O posicionamento incorreto dos componentes ou a utilização de uma prótese de anca ou anca total com constricção com uma cabeça com um rebordo modular ou manga cônica pode diminuir a amplitude de movimentos da articulação e aumentar o potencial de desgaste, impacto, deslocação prematura ou revisão dos componentes. Nestes casos, o cirurgião deve informar o paciente de que devem ser evitadas as atividades com uma elevada amplitude de movimentos.

Um acompanhamento periódico contínuo do paciente é recomendado devido à vida funcional desconhecida do implante no paciente específico, em particular no que diz respeito à manutenção da fixação do implante e das superfícies de suporte de carga. Devem ser realizadas investigações radiológicas em cada consulta de acompanhamento e comparadas com as investigações radiológicas anteriores e correlacionadas com a avaliação clínica do paciente. Se forem observadas quaisquer alterações radiológicas, como a ocorrência de radioluscências, reabsorção óssea ou quaisquer alterações na posição de um implante, estas alterações devem ser monitorizadas atentamente para determinar se são estáticas ou progressivas e o paciente deve ser tratado adequadamente.

EVENTOS ADVERSOS E COMPLICAÇÕES

Os eventos adversos e complicações listados abaixo geralmente são os mais frequentes na artroplastia da anca:

Geral

A incidência e a gravidade das complicações na implantação de prótese da anca são geralmente maiores nas revisões do que nas operações primárias. Os problemas comuns encontrados na cirurgia de revisão podem incluir dificuldade na colocação da incisão, remoção de osso ectópico e cimento ósseo velho, posicionamento e fixação de componentes e/ou obtenção de suporte ósseo adequado. De uma maneira geral, o aumento do tempo operatório, perda de sangue e risco de infecção, embolia pulmonar e hematoma da ferida podem ser esperados em procedimentos de revisão.

1. Alteração da posição dos componentes da prótese, frequentemente relacionada com os fatores listados em ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES.
2. Afrouxamento precoce ou tardio dos componentes da prótese, frequentemente relacionado com os fatores listados em ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES.
3. Fratura de fadiga da haste femoral, frequentemente relacionada com os fatores listados em ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES.
4. Desgaste excessivo ou fratura dos componentes de suporte de carga devido a: danos intraoperatórios dos componentes protéticos, cimento solto, fragmentos ósseos, partículas metálicas, partículas cerâmicas ou outros fatores listados em ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES.
5. Infecção precoce ou tardia.
6. Neuropatias periféricas. As lesões nervosas subclínicas também podem ocorrer como resultado de um trauma cirúrgico.
7. Reações teciduais, osteólise e/ou afrouxamento do implante causados por corrosão metálica, reações alérgicas, desgaste ou detritos particulados (como cimento solto, partículas metálicas, de polietileno ou cerâmicas).
8. Dor residual na anca.

Intraoperatório

1. Perfuração da haste femoral, fissura ou fratura, que pode exigir a utilização de fixação interna.
2. Fratura trocantérica.
3. Lesões nos vasos sanguíneos (por ex., artéria ilíaca, obturadora e femoral).
4. Lesões nervosas temporárias ou permanentes (por ex., nervo femoral, obturador ou peroneal isolado).
5. Subluxação ou luxação da articulação da anca devido à seleção do tamanho ou configuração do implante, posicionamento dos componentes e/ou flacidez dos músculos e tecidos fibrosos.
6. Alongamento ou encurtamento da extremidade afetada.
7. Atraso cirúrgico.

Pós-operatório inicial

1. Distúrbios cardiovasculares, como trombose venosa, embolia pulmonar e enfarte do miocárdio.
2. Hematoma e/ou cicatrização retardada de feridas.
3. Subluxação ou luxação.
4. Desassociação dos componentes modulares.

Pós-operatório tardio

1. Avulsão trocântérica devido a tensão muscular excessiva, suporte de peso ou enfraquecimento intraoperatório acidental do trocânter.
2. Agravamento de problemas nas articulações ipsilateral ou contralateral do joelho e tornozelo devido a discrepância no comprimento das pernas, medialização femoral e/ou deficiências musculares.
3. Fratura femoral devido a trauma ou carga excessiva, particularmente na presença de stock ósseo fraco causado por osteoporose grave, defeitos ósseos de cirurgias prévias, procedimentos intraoperatórios de mandrilagem ou reabsorção óssea.
4. Reabsorção óssea que pode contribuir para a deterioração da fixação e eventual afrouxamento do implante.
5. Diminuição da mobilidade articular e da amplitude de movimentos (por exemplo, talvez causada por ossificação ou calcificação periarticular).
6. Artrose traumática do joelho ipsilateral secundária ao posicionamento intraoperatório da extremidade durante a cirurgia.
7. Subluxação ou luxação.
8. Desassociação dos componentes modulares.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE RM

 Informações de segurança para RM Um doente com a prótese Cimentada DePuy Corail pode ser submetido a exames de RM nas seguintes condições. O não cumprimento destas condições pode resultar em lesões do paciente.	
Nome/Identificação do dispositivo	Prótese da Anca CORAIL Cemented
Valor(es) nominal(is) do campo magnético estático [T]	1,5 T ou 3,0 T
Gradiente máximo do campo espacial [T/m e gauss/cm]	30 T/m (3000 gauss/cm)

Excitação RF	Polarizado circularmente (PC)
Tipo de bobina de transmissão de RF	Bobina transmissora para corpo inteiro, bobina transmissora de RF para cabeça
Modo de funcionamento	Modo de funcionamento normal
SAR máxima de corpo inteiro	2,0 W/kg (modo de funcionamento normal)
SAR máxima de cabeça	Não é necessária uma bobina de cabeça para exames de RM à anca
Limites da duração do exame	SAR média de corpo inteiro de 2,0 W/kg Exame durante até 15 minutos, seguido de um período de arrefecimento de 15 minutos (pode ser repetido até três vezes numa única sessão de imagiologia)
Artefacto de imagem da RM	Não se espera que a presença deste implante produza um artefacto de imagem com uma extensão superior a 108 mm.
Instruções adicionais ou informações essenciais para utilização segura no ambiente de RM	*Verifique todos os componentes da prótese da anca para obter informações adicionais de etiquetagem para RM

ELIMINAÇÃO

Elimine de forma segura todos os dispositivos utilizados em conformidade com os procedimentos e diretrizes locais.

INTERPRETAÇÃO DOS SÍMBOLOS

D/DP

DEPUY

REF

Número de catálogo

LOT

Código de lote



Atenção



Consultar as Instruções de Utilização



www.e-IFU.com
US / Canada 800-255-2500
EU: +800 8888 2020
EU: +32 2 4037222

Website das Instruções de Utilização eletrônicas



Fabricante



Prazo de validade

Sterile

Estéril



Esterilizado por irradiação



Não reesterilizar



Não utilizar se a embalagem estiver danificada



Não reutilizar



Condicional a ressonância magnética (RM)



Unidade de embalagem



Material(ais) de construção



Dispositivo médico



Sistema de barreira estéril dupla



Reciclável



RT / LT

Direita/Esquerda

MADE IN

Fabricado em

S

Aço inoxidável

SIZE/SZ/DIA/IN/ft/DEG/GRP/lb/OD/ID

Tamanho/tamanho/diâmetro/polegadas/pés/graus/
grupo/libras/diâmetro exterior/diâmetro interior

Протез тазобедренного сустава CORAIL Cemented

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — прочитайте перед применением

Некоторые изделия могут быть лицензированы не во всех странах.



STERILE

Сведения о методе стерилизации см. на этикетке изделия

Веб-сайт с инструкциями по применению

Для доступа к электронной инструкции по применению (e-IFU) и дополнительным языкам посетите www.e-IFU.com

Карта имплантата, информационный листок пациента (PIL) и веб-сайт

Карта имплантата (и этикетка карты имплантата) поставляется в упаковке с имплантатом. Информация, содержащаяся в информационном листке пациента (PIL), основана на информации, содержащейся в данной инструкции по применению. С электронным информационным листком пациента (ePIL) можно ознакомиться на указанном ниже веб-сайте.

Для доступа к электронной версии информационного листка пациента (ePIL) посетите www.ic.jnjmedicaldevices.com

ВНИМАНИЕ! Федеральный закон (США) разрешает продажу этого устройства только врачам или по предписанию врачей.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Это металлическая бедренная ножка протеза тазобедренного сустава. Тотальный протез тазобедренного сустава состоит из индивидуально упакованных металлической ножки тазобедренного сустава, модульной металлической или керамической головки бедренной кости и двухэлементных вертлужных компонентов, выполненных из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) с металлической основой, керамики или полностью из СВМПЭ и предназначенных для замены естественной поверхности тазобедренного сустава.

МАТЕРИАЛЫ

Ниже перечислены вещества, содержащиеся в имплантате. Вследствие производственного процесса в имплантате также могут присутствовать дополнительные вещества в следовых количествах. Для получения дополнительной информации обратитесь по указанному ниже адресу.

Пример аббревиатуры, используемой на этикетке (-ах):	Описание материала:	Материал номинально содержит следующие вещества:
S1	Нержавеющая сталь	Железо (63%) Хром (21%) Никель (10%) Марганец (3%) Молибден (3%) Менее 1% ниобия и азота

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Это (-и) устройство (-а) СТЕРИЛЬНО (-Ы) и поставляется (-ются) в индивидуальной упаковке. Извлекать из упаковки с соблюдением принятого асептического метода только после определения правильного размера. Не использовать эти компоненты при наличии повреждений или при случайном вскрытии упаковки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Предполагаемый пользователь

Данные устройства предназначены для использования квалифицированным персоналом. Важно, чтобы хирург и операционный персонал полностью ознакомились с соответствующей хирургической методикой, относящейся к имплантату и сопутствующим инструментам.

Использование по назначению. Тотальный протез тазобедренного сустава

Тотальная артропластика тазобедренного сустава проводится с целью замены поврежденного тазобедренного сустава у пациентов, у которых подтверждено наличие достаточного количества здоровой костной ткани для фиксации и поддержки компонентов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Используйте только модульные бедренные головки производства DePuy и вертлужные компоненты производства DePuy с модульными бедренными ножками производства DePuy. Размер конуса головки бедренной кости ДОЛЖЕН соответствовать размеру конуса бедренной ножки.

Цементируемые компоненты

Эта бедренная ножка с маркировкой «Только для цементной фиксации» предназначена для использования с костным цементом.

Категория пациентов

Целевую категорию составляют достигшие скелетной зрелости пациенты, у которых подтверждено наличие достаточного количества здоровой костной ткани для фиксации и поддержки компонентов.

ПОКАЗАНИЯ

Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава показано в нижеперечисленных случаях.

1. Крайне болезненный и (или) пораженный артритом сустав (как правило, вследствие невоспалительного дегенеративного заболевания суставов).
2. Неудачная предыдущая операция на бедре.
3. Травматический перелом головки или шейки бедра.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

1. Активная местная или системная инфекция.
2. Атрофия мышц, нейромышечная патология или сосудистая недостаточность в пораженной конечности, делающая процедуру неоправданной.
3. Неудовлетворительное состояние кости, например при остеопорозе, когда, по мнению хирурга, возможно значительное смещение протеза или высока вероятность перелома тела бедренной кости и (или) отсутствует достаточное количество костной ткани, необходимое для поддержки имплантата (-ов).
4. Артропатия Шарко или деформирующая остеоидистрофия Педжета.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Запрещено совместно использовать имплантаты и пробные компоненты разных производителей или систем имплантатов.
- Запрещено повторно имплантировать компоненты протеза тазобедренного сустава. Даже если имплантат не имеет видимых повреждений, на нем могли образоваться микроскопические дефекты, способные привести к неблагоприятному исходу.
- В целях проверки всегда следует использовать пробный протез. Проверки не следует проводить с использованием компонентов, предназначенных для постоянной имплантации. Пробные компоненты должны иметь такую же конфигурацию, размер и т. д., что и соответствующие компоненты, предназначенные для постоянной имплантации.
- Одноразовые устройства производства компании DePuy не подлежат каким-либо модификациям, например разборке, очистке или повторной стерилизации, после применения у одного пациента. Повторное применение может неблагоприятным образом сказаться на функциональности устройства и безопасности пациента.

- Не допускается изменение или модификация имплантатов.
- Качество костной ткани имеет решающее значение для фиксации устройства. Рассмотрите возможность костной трансплантации и использования других методов укрепления, в особенности при проведении ревизионных операций, чтобы обеспечить возможность установки и поддержки устройства.

ВНИМАНИЕ! Нижеуказанные состояния, по отдельности или в комбинации, как правило, создают серьезную нагрузку на пораженную конечность, повышая риск неудачного эндопротезирования тазобедренного сустава у пациента.

1. Ожирение или избыточный вес пациента.
2. Физический труд.
3. Занятия спортом с умеренной и высокой нагрузкой.
4. Высокая активность пациента.
5. Вероятность падений.
6. Злоупотребление алкоголем или наркотиками.
7. Другие физические нарушения, в зависимости от обстоятельств.

ВНИМАНИЕ! Нижеуказанные состояния, по отдельности или в комбинации, могут отрицательно влиять на фиксацию имплантатов при эндопротезировании тазобедренного сустава.

1. Выраженный остеопороз или низкое качество костной ткани.
2. Метаболические нарушения или системные фармакологические виды лечения, ведущие к прогрессирующему ухудшению твердой костной опоры для имплантата (например, сахарный диабет, стероидная терапия, иммуносупрессивная терапия и т. д.).
3. Системные или местные инфекции в анамнезе.
4. Глубокие деформации, приводящие к нарушению фиксации или неправильному позиционированию имплантата.
5. Опухоли опорных костных структур.
6. Аллергические реакции на материалы имплантата (например, костный цемент, металл).
7. Реакции тканей на коррозию имплантата или продукты износа имплантата.
8. Дисфункция других суставов (например, коленных или голеностопных).

ПРИМЕЧАНИЕ. В настоящее время диабет не установлен в качестве противопоказания, однако из-за повышенного риска таких осложнений, как развитие инфекций, медленное заживление ран и т. д., врач должен тщательно рассмотреть целесообразность проведения эндопротезирования тазобедренного сустава у пациента с тяжелым течением диабета.

Хирургическое и послеоперационное ведение пациента следует осуществлять с учетом всех имеющихся заболеваний. Психологические установки или расстройства, в результате которых пациент не выполняет указания хирурга, могут задерживать послеоперационное восстановление и (или) повышать риск развития нежелательных эффектов, включая отторжение или нарушение фиксации имплантата.

Повышенная физическая активность или травма замененного сустава, провоцируя изменение положения, перелом и (или) износ имплантатов, может стать причиной неблагоприятного исхода при эндопротезировании тазобедренного сустава.

ОЖИДАЕМАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛЬЗА ТОТАЛЬНЫЙ ПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Ожидается, что тотальная артропластика тазобедренного сустава позволит повысить подвижность пациента и облегчить боль за счет замены поврежденного тазобедренного сустава у достигших скелетной зрелости пациентов, у которых подтверждено наличие достаточного количества здоровой костной ткани для фиксации и поддержки компонентов.

КРАТКИЙ ОБЗОР ХАРАКТЕРИСТИК БЕЗОПАСНОСТИ И КЛИНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

В некоторых странах или регионах существуют регистры по эндопротезированию тазобедренных суставов для контроля характеристик имплантатов тазобедренных суставов. В результате анализа этих данных было установлено, что в целом у 95% (95 из 100) пациентов с момента первой операции по тотальному эндопротезированию тазобедренного сустава прошло более 10 лет. Это означает, что в течение 10 лет около 5% (5 из 100) пациентов могли перенести дополнительные операции, связанные с удалением части (-ей) протеза. Ревизионные операции по протезированию тазобедренного сустава, как правило, имеют ресурс более 10 лет в 80% случаев. Это устройство рассчитано на общий срок службы имплантата. Риск проведения дополнительных операций для каждого отдельно взятого пациента будет зависеть от конкретных факторов, таких как анатомия, состояние здоровья и образ жизни пациента (например, вес и уровень активности), операции и способа оперативного вмешательства.

Краткий обзор характеристик безопасности и клинических характеристик (SSCP) для конкретного устройства можно найти по следующей ссылке: <http://ec.europa.eu/tools/eudamed>

Примечание. Ссылка на Eudamed будет доступна только после запуска базы данных Eudamed.

Сообщение о серьезных происшествиях

О любом серьезном происшествии с устройством следует сообщать производителю и в компетентный орган государства-члена, в котором находится пользователь и (или) пациент.

Серьезное происшествие означает любой случай, который прямо или косвенно привел, мог бы привести или может привести к любому из следующих событий:

- a) смерть пациента, пользователя или другого лица;
- b) временное или постоянное серьезное ухудшение состояния здоровья пациента, пользователя или другого лица;
- c) серьезная угроза общественному здоровью.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед операцией

ДО ОПЕРАЦИИ ХИРУРГ ДОЛЖЕН ОБСУДИТЬ С ПАЦИЕНТОМ ВСЕ ФИЗИЧЕСКИЕ И ПСИХИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ПАЦИЕНТА, А ТАКЖЕ ВСЕ АСПЕКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИЕЙ И ПРОТЕЗАМИ. Обсуждение должно затрагивать ограничения и возможные последствия эндопротезирования сустава, необходимость соблюдения инструкций хирурга после операции и информацию, содержащуюся в информационном листке пациента.

Предоперационное планирование и выбор хирургических техник имплантации этих компонентов протеза тазобедренного сустава основаны на хирургическом опыте, накопленном при установке множества протезов тазобедренных суставов. Клиническое использование любого протеза тазобедренного сустава должно начинаться только после освоения хирургами техники его имплантации. Брошюры по хирургической технике можно получить в DePuy.

Во время операции

Во время операции рекомендуется иметь в распоряжении компоненты по меньшей мере на один размер больше и на один размер меньше компонентов, выбранных перед операцией, чтобы иметь возможность выбора компонента (-ов) подходящего (-их) размера (-ов).

Защитную упаковку не следует снимать до момента готовности к имплантации компонентов. Не используйте компоненты, если они упали или ударились о твердую поверхность. Повреждение компонента бывает незаметным, но может привести к преждевременному выходу протеза из строя. Хирургические инструменты, указанные в хирургической методике, были разработаны для данной процедуры артропластики и должны использоваться так, как показано в брошюре

по хирургической методике. Перед имплантацией керамической головки бедренной кости охватываемый конус на бедренной ножке необходимо очистить от крови, костной стружки или других посторонних материалов. Посторонний материал между головкой и конусом бедренной ножки может помешать правильной установке головки на ножке.

При проведении ревизионной операции необходимо полностью удалить фиброзную мембрану, инкапсулирующую вышедший из строя протез. Остатки фиброзных мембран могут мешать фиксации имплантата. Проверьте уже имеющиеся устройства на наличие таких повреждений сопрягаемых поверхностей, которые могут помешать правильной установке или фиксации нового устройства. Неправильный выбор, установка или расположение имплантатов может привести к нетипичным условиям нагрузки и последующему сокращению срока службы имплантата. Обратите внимание на то, что при размещении бедренной ножки под углом кнаружи увеличивается нагрузка на надкостницу в проксимальном отделе бедренной кости в медиальном направлении, что может привести к расшатыванию имплантата. Перед закрытием операционное поле необходимо тщательно очистить от костной стружки, лишнего костного цемента, эктопической костной ткани и т. д. Наличие инородных частиц в месте сопряжения «металл/пластик», или «керамика/пластик», или «керамика/керамика» может вызывать чрезмерный износ. Следует тщательно проверить объем движения, чтобы исключить неправильное сочленение, нестабильность или ущемление и при необходимости выполнить коррекцию.

После операции

Чрезвычайно важно, чтобы пациент неукоснительно соблюдал инструкции и рекомендации хирурга. В послеоперационном периоде необходимо придерживаться общепринятых практик.

При выписке из больницы пациенту следует предоставить подробные письменные инструкции и рекомендации по поводу упражнений и методов лечения, а также всех ограничений деятельности. Неправильное расположение компонентов либо использование ограниченного или тотального протеза тазобедренного сустава с модульной головкой с юбкой или конической втулкой может привести к уменьшению диапазона движения сустава и повышению вероятности износа компонентов, ущемления, преждевременного вывиха или проведения ревизионной операции. В этих случаях хирург должен проинформировать пациента о необходимости избегать видов деятельности с большим диапазоном движений.

Поскольку срок службы имплантата у каждого конкретного пациента неизвестен, рекомендуется обеспечить продолжительное

периодическое наблюдение за пациентом, уделяя особое внимание сохранению фиксации имплантата и состоянию опорных поверхностей. Во время каждого контрольного посещения рекомендуется проводить рентгенологическое исследование и сравнивать его результаты с результатами предыдущих рентгенологических исследований, соотнося с клинической оценкой состояния пациента. При выявлении каких-либо рентгенологических изменений, таких как появление участков просветления, резорбция кости или любые изменения в положении имплантата, необходимо тщательно контролировать эти изменения, чтобы определить, являются ли они статическими или прогрессирующими, и обеспечить надлежащее лечение пациента.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И ОСЛОЖНЕНИЯ

Ниже перечислены наиболее часто встречающиеся нежелательные явления и осложнения при артропластике тазобедренного сустава.

Общие

Частота и тяжесть осложнений при эндопротезировании тазобедренного сустава обычно выше при повторных вмешательствах, чем при первичных операциях. К типичным проблемам, возникающим при ревизионной хирургической операции, относятся сложности с выполнением разреза, удалением эктопической костной ткани и старого костного цемента, размещением и фиксацией компонентов и (или) обеспечением надлежащей костной опоры. В целом при повторных процедурах можно ожидать увеличения времени операции, кровопотери и риска развития инфекции, тромбоза, эмболии легочной артерии и гематомы раны.

1. Изменение положения компонентов протеза, что часто обусловлено факторами, перечисленными в разделе «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ».
2. Раннее или позднее ослабление фиксации компонентов протеза, что, как правило, обусловлено факторами, перечисленными в разделе «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ».
3. Усталостный перелом бедренной ножки, что часто обусловлено факторами, перечисленными в разделе «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ».
4. Чрезмерный износ или поломка опорных компонентов, возникающие вследствие: повреждения компонентов протеза во время операции, использования рыхлого цемента, присутствия костных фрагментов, металлических и керамических частиц или других факторов, перечисленных в разделе «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ».

5. Ранняя или поздняя инфекция.
6. Периферические нейропатии. В результате хирургической травмы также может возникать субклиническое поражение нервов.
7. Тканевые реакции, остеолит и (или) подвижность имплантата, вызванные коррозией металла, аллергическими реакциями, износом или остатками частиц (таких как частицы цемента, металлические, полиэтиленовые или керамические частицы).
8. Остаточная боль в бедре.

Во время операции

1. Перфорация, трещина или перелом тела бедренной кости, при которых может потребоваться внутренняя фиксация.
2. Вертельный перелом.
3. Повреждение кровеносных сосудов (например, подвздошной, запирательной и бедренной артерий).
4. Временное или постоянное поражение нерва (например, бедренного, запирательного или изолированного малоберцового нерва).
5. Подвывих или вывих тазобедренного сустава, связанные с выбором размера или конфигурации имплантата, расположением компонентов и (или) дряблостью мышц и фиброзных тканей.
6. Удлинение или укорочение пораженной конечности.
7. Отсрочка хирургического вмешательства.

Ранний послеоперационный период

1. Сердечно-сосудистые заболевания, включая тромбоз вен, тромбоз легочной артерии и инфаркт миокарда.
2. Гематома и (или) замедленное заживление ран.
3. Подвывих или вывих.
4. Диссоциация модульных компонентов.

Поздний послеоперационный период

1. Отрыв вертела вследствие чрезмерного мышечного напряжения, нагрузки или непреднамеренного ослабления вертела во время операции.
2. Обострение проблем в ипсилатеральных или контралатеральных коленном и голеностопном суставах вследствие разницы длины ног, медиализации бедренной кости и (или) дефицита мышечной массы.
3. Перелом бедренной кости вследствие травмы или чрезмерной нагрузки, в особенности при низком качестве костной ткани, обусловленном тяжелым остеопорозом, дефектами костной ткани в результате предыдущей операции, процедур расширения или резорбции кости во время операции.
4. Резорбция кости, которая может способствовать ухудшению фиксации и возможному расшатыванию имплантата.

5. Уменьшение подвижности сустава и диапазона движения (например, может быть вызвано периартикулярной кальцификацией или окостенением).
6. Травматический артроз колена оперируемой конечности вследствие ее позиционирования во время операции.
7. Подвывих или вывих.
8. Диссоциация модульных компонентов.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР МРТ

Информация о безопасности проведения процедур МРТ Пациент, у которого установлена конструкция DePuy Corail Cemented, может проходить сканирование при указанных ниже условиях. Несоблюдение этих условий может привести к травме пациента. 	
Наименование/идентификатор устройства	Протез тазобедренного сустава Corail Cemented
Номинальное (-ые) значение (-я) статического магнитного поля [Тл]	1,5 Тл или 3,0 Тл
Максимальный пространственный градиент поля [Тл/м и гаусс/см]	30 Тл/м (3000 гаусс/см)
РЧ-возбуждение	Круговая поляризация (CP)
Тип передающей РЧ-катушки	Передающая катушка для всего тела, приемно-передающая РЧ-катушка для головы
Режим работы	Нормальный режим работы
Максимальное значение удельного коэффициента поглощения (SAR) для всего тела	2,0 Вт/кг (нормальный режим работы)

Максимальное значение SAR для головы	Использование головной катушки при сканировании бедра не требуется
Ограничения по продолжительности сканирования	Среднее значение удельного коэффициента поглощения (SAR) для всего тела 2,0 Вт/кг Сканирование до 15 минут с последующим 15-минутным периодом охлаждения (можно повторять до трех раз за один сеанс визуализации)
Артефакт на снимке MPT	Предполагается, что наличие этого имплантата не приведет к появлению на снимке артефакта более 108 мм
Дополнительные инструкции или сведения, необходимые для безопасного использования в условиях МРТ	* Проверьте все компоненты конструкции протеза тазобедренного сустава на предмет дополнительной информации в маркировке по MPT

УТИЛИЗАЦИЯ

Выполните безопасную утилизацию всех использованных устройств в соответствии с местными правилами и процедурами.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

D/DP

DEPUY



Внимание!



Производитель



Номер по каталогу



См. инструкцию по применению



Срок годности



Код партии



www.e-IFU.com
US / Canada 800-255-2500
EU: +800 888 2020
EU: +32 2 4037222

Веб-сайт с электронной инструкцией по применению



Стерильно



Стерилизовано методом
облучения



Не стерилизовать
повторно



Не использовать, если
упаковка повреждена



Не использовать
повторно



Условно безопасно для
проведения МРТ



Упаковочная единица



Материал (-ы)
конструкции



Медицинское устройство



Система с двойным
стерильным барьером



Пригодно для
переработки



RT / LT

Право/лево



Произведено в

S

Нержавеющая сталь

SIZE/SZ/DIA/IN/ft/DEG/GRP/lb/OD/ID

Размер / размер / диаметр / дюймы / футы /
градусы / группа / фунты / наружный диаметр /
внутренний диаметр

CORAIL Cemented höftprotes

VIKTIG INFORMATION – Läs före användning

Vissa produkter är kanske inte licensierade i alla jurisdiktioner.



STERILE

Se produktetiketten för metod

Webbplats med elektronisk bruksanvisning

För åtkomst till den elektroniska bruksanvisningen och flera språk, gå till www.e-IFU.com

Implantatkort, patientinformationsblad (PIL) och hemsida

Implantatkortet (och implantatkortets etikett) medföljer i förpackningen med implantatet. Informationen i bipacksedeln (PIL) är baserad på informationen i denna bruksanvisning. ePIL finns på webbplatsen nedan.

För åtkomst till ePIL, gå till www.ic.njmedicaldevices.com

FÖRSIKTIGHET: Federal lag (USA) begränsar denna produkt till försäljning av eller på ordination av läkare.

PRODUKTBESKRIVNING

Detta är ett femurskaft i metall. En total höftprotes består av individuellt förpackade femurskaft i metall, modulärt femurhuvud i metall eller keramik och tvådelade acetabulära komponenter i metallbackad polyetylen med ultrahög molekylärvikt (UHMWPE), keramik eller enbart UHMWPE, som är utformade för att ersätta den naturliga artikulära ytan på höftleden.

MATERIAL

Informationen nedan listar ämnena i implantatet. Ytterligare spårämnen kan förekomma på grund av tillverkningsprocessen. Kontakta adressen nedan för ytterligare information.

Exempel på akronym som används på etikett(er):	Material-beskrivning:	Materialet innehåller nominellt följande ämnen:
S1	Rostfri stållegering	Järn (63 %) Krom (21 %) Nickel (10 %) Mangan (3 %) Molybden (3 %) Mindre än 1 % av niob och kväve

LEVERANS

Denna/dessa produkt(er) är individuellt förpackad(e) och levereras STERIL(A). Ta ut ur förpackningen med godkänd aseptisk teknik först efter att rätt storlek har fastställts. Använd inte dessa komponenter om den sterila förpackningen har skadats eller oavsiktligt öppnats.

AVSEDD ANVÄNDNING

Avsedd användare

Dessa produkter får inte användas av okvalificerad personal. Det är absolut nödvändigt att kirurgen och operationspersonalen är helt förtrogna med lämplig kirurgisk teknik vid användning av implantatet och relaterade instrument.

Avsedd användning – Total höftprotes

Total höftartroplastik är avsedd att byta ut den skadade höftledsartikulationen hos patienter där det finns bevis på tillräckligt bra benvävnad för att placera och stödja komponenterna.

VARNING: Använd endast modulära femurhuvuden och acetabulära komponenter från DePuy med modulära femurskaft från DePuy. Femurhuvudets koniska storlek MÅSTE överensstämma med femurskaftets koniska storlek.

Cementerade komponenter

Detta femurskaft märkt "Endast för cementerad användning" är avsett att användas med bencement.

Patientpopulation

Den avsedda patientpopulationen är personer med moget skelett och bevis på tillräckligt bra benvävnad för att placera och stödja komponenterna.

INDIKATIONER

Totalt höftbyte indikeras under följande förhållanden:

1. En allvarligt smärtsam och/eller artrit (vanligtvis på grund av icke-inflammatorisk degenerativ ledsjukdom)
2. Misslyckad tidigare höftoperation
3. Akut fraktur i femurhuvudet eller -halsen

KONTRAINDIKATIONER

1. Aktiv lokal eller systemisk infektion.
2. Förlust av muskulatur, neuromuskulär kompromiss eller vaskulära brister i den påverkade extremiteten som gör ingreppet omotiverat.
3. Dålig benkvalitet, till exempel osteoporos, där det enligt kirurgens åsikt kan förekomma avsevärd migrering av protesens eller en signifikant förändring i frakturen i femurskäftet och/eller brist på tillräcklig benvävnad för att ge stöd till implantat.
4. Charcots eller Pagets sjukdom.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Implantat och testkomponenter från olika tillverkare eller implantatsystem ska aldrig användas tillsammans.
- Höftproteskomponenter bör aldrig återimplanteras. Även om implantatet verkar oskadat kan implantatet ha utvecklat mikroskopiska brister som kan leda till felfunktion.
- Använd alltid en provprotes för teständamål. Provpoteser bör inte monteras med några komponenter avsedda för permanent implantation. Provpoteser måste ha samma konfigurationsstorlek osv. som motsvarande komponenter för permanent implantering.
- Produkter för engångsbruk som tillverkats av DePuy, är inte utformade för att undergå eller tåla någon form av ändring, till exempel demontering, rengöring eller omsterilisering efter användning till en enskild patient. Återanvändning kan potentiellt äventyra produktens funktion och patientens säkerhet.
- Implantaten får inte ändras eller modifieras på något sätt.
- Benstomme av kvalitet är avgörande för att säkerställa fixering av produkten. Överväg bentransplantation och andra förstärkningstekniker, särskilt när du utför revisionskirurgi, för att placera och stödja produkten.

FÖRSIKTIGHET: Följande tillstånd, för sig eller samtidigt, tenderar att utgöra allvarlig belastning på den drabbade extremiteten och därigenom utsätta patienten för en högre risk att höftbytet misslyckas:

1. Fetma eller övervikt hos patienten.
2. Fysiskt arbete.
3. Deltagande i sport med måttlig till hög påfrestning.
4. Hög aktivitetsnivå hos patienten.

5. Fallrisk.
6. Aktivt alkohol- eller drogmissbruk.
7. Andra funktionshinder, som tillämpligt.

FÖRSIKTIGHET: Följande tillstånd för sig eller samtidigt tenderar att påverka fixeringen av höftbytesimplantat negativt:

1. Påfallande osteoporos eller dålig benstomme.
2. Metaboliska sjukdomar eller systemiska farmakologiska behandlingar som leder till progressiv försämring av fast benstöd för implantatet (t.ex. diabetes mellitus, steroidterapi, immunsuppressiva terapier osv.).
3. Historik av allmänna eller lokala infektioner.
4. Allvarliga missbildningar som leder till försämrade fixering eller felaktig placering av implantatet.
5. Tumörer i de stödjande benstrukturerna.
6. Allergiska reaktioner mot implantatmaterial (t.ex. bencement, metall).
7. Vävnadsreaktioner på korrosion av implantat eller slitageavfall från implantat.
8. Funktionshinder i andra leder (dvs. knän och anklar).

OBS: Diabetes har för närvarande inte fastställts som en kontraindikation. På grund av den ökade risken för komplikationer som infektion, långsam sårhäkning osv. bör dock läkaren noga överväga om det är lämpligt att byta höft hos en patient med svår diabetes.

Den kirurgiska och postoperativa hanteringen av patienten måste utföras med vederbörlig hänsyn till alla befintliga tillstånd. Psykiska attityder eller störningar som leder till att en patient inte följer kirurgens direktiv kan försena postoperativ återhämtning och/eller öka risken för negativa effekter inklusive implantat- eller implantatfixeringsfel.

Överdriven fysisk aktivitet eller trauma i den utbytta leden kan bidra till för tidig svikt i höftbytet genom att orsaka en förändring i läge, fraktur och/eller implantatens slitage.

**FÖRVÄNTAD KLINISK NYTTA
TOTAL HÖFTPROTES**

Total höftartroplastik förväntas ge ökad patientträlsighet och minska smärtan genom att byta ut den skadade höftledsartikulationen hos skelettmogna patienter där det finns bevis på tillräckligt bra benvävnad för att placera och stöjda komponenterna.

SAMMANFATTNING AV SÄKERHET OCH KLINISK PRESTANDA

Vissa länder eller regioner har höftbytesregister som övervakar prestanda hos höftimplantat. Dessa registerdata analyserades och visar att en persons första totala höftoperation håller i allmänhet 95 % (95 av 100) i längre än 10 år. Det betyder att vid 10 år kan omkring 5 % (5 av 100) av patienterna

ha genomgått ytterligare operationer för att ta bort en eller flera delar. För ett revisionshöftledsbyte håller 80 % i allmänhet längre än 10 år. Denna produkt uppfyller denna allmänna implantativslängd. Risken för ytterligare operationer hos en enskild patient beror på patientspecifika faktorer såsom anatomi, medicinskt tillstånd och livsstil (t.ex. vikt och aktivitetsnivå), det kirurgiska ingreppet och förloppet.

En produktspecifik SSCP finns på följande länk:

<http://ec.europa.eu/tools/eudamed>

Obs: Eudamed-länken kommer endast att finnas tillgänglig efter att Eudamed-databasen är igång.

Rapportering av allvarliga tillbud

Alla allvarliga tillbud som har inträffat i relation till produkten ska rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i det medlemsland där användaren och/eller patienten är etablerad.

Allvarligt tillbud avser varje tillbud som direkt eller indirekt ledde, kan ha lett eller kanske kan leda till något av följande:

- a) patienten, användaren eller annan person avlider,
- b) en tillfällig eller permanent allvarlig försämring av en patients, användares eller annan persons hälsotillstånd,
- c) ett allvarligt hot mot folkhälsan.

ANVÄNDNINGSPERMANENS INFORMATION

Preoperativt

KIRURGEN BÖR DISKUTERA ALLA FYSISKA OCH MENTALA BEGRÄNSNINGAR SOM GÄLLER FÖR PATIENTEN OCH ALLA ASPEKTER AV OPERATIONEN OCH PROTESEN MED PATIENTEN INNAN OPERATIONEN. Diskussionen bör innehålla de begränsningar och de möjliga konsekvenserna av ledbyte, det nödvändiga i att följa kirurgens instruktioner postoperativt och informationen i patientbroschyren.

Den preoperativa planerings- och kirurgiska tekniken för implantering av dessa höftbyteskomponenter utvecklades från den kirurgiska erfarenhet som uppnåtts under utvecklingen av många höftproteser. Kirurger bör inte börja den kliniska användningen av någon höftprotes innan de noggrant har bekantat sig med dess specifika implantationsteknik. Broschyren om kirurgisk teknik finns tillgängliga hos DePuy.

Intraoperativt

Det rekommenderas att komponenter som är minst en storlek större och en storlek mindre än vad som fastställdes preoperativt ska finnas tillgängliga vid operationen för att tillgodose intraoperativt val av lämplig(a) storlek(ar).

Skyddshöljen ska vara kvar tills komponenterna är redo att implanteras. Använd inte komponenter om de har tappats eller har stött i en hård

yta. Skador på komponenten kanske inte är synliga men kan orsaka tidig felfunktion av protesen. Kirurgiinstrumenten i kirurgimetoden har utformats för denna artroplastik och måste användas enligt broschyren om kirurgimetoden. Innan man implanterar ett keramiskt femurhuvud, bör hankonen på femurskaftet torkas ren från blod, benflis eller annat främmande material. Främmande material mellan huvudet och femurskaftet kan försvåra korrekt placering av huvudet på skaftet. Detta kan påverka prestationen hos femurhuvudet eller låsmekanismen mellan femurhuvudet och femurskaftet.

Vid revisionskirurgi är det absolut nödvändigt att alla fibrösa membran som inkapslar den felaktiga protesen tas bort i sin helhet. Återstående fibrösa membran kan störa implantatfixering. Granska alla befintliga produkter avseende skador på inpassande ytor som skulle förhindra adekvat placering eller låsning av den nya produkten. Felaktigt val, placering eller positionering av implantat kan resultera i ovanliga belastningsförhållanden och en efterföljande minskning av implantatets funktionella livslängd. Observera att ett femurskaft placerat i varus ökar påfrestningen på den proximala mediala femoral kortexen och kan leda till att implantatet lossnar. Före stängning bör operationsområdet rengöras noggrant från benflis, överblivet bencement, ektopiskt ben osv. Främmande partiklar vid kontaktytorna mellan metall/plast, keramik/plast eller keramik/keramik kan orsaka överdrivet slitage. Rörelseomfång bör kontrolleras noggrant avseende felaktig inpassning, instabilitet eller inverkan och korrigeras efter behov.

Postoperativt

Det är extremt viktigt att patienten följer kirurgens instruktioner och varningar. Godkända metoder bör följas i postoperativ vård.

Patienten ska skrivas ut från sjukhuset med fullständiga skriftliga instruktioner och varningar angående övningar och behandlingar och eventuella begränsningar av aktiviteter. Felaktig placering av komponenter eller användning av begränsad höft eller total höft med modulärt skörthuvud eller avsmalnande hylsa kan minska ledens rörelseomfång och öka risken för komponentslitage, inverkan som leder till prematur dislokation eller revision. I dessa fall bör kirurgen informera patienten om att stora rörelser bör undvikas.

En fortsatt regelbunden patientuppföljning rekommenderas på grund av den okända funktionella livslängden av implantatet hos den specifika patienten, särskilt med avseende på underhåll av implantatfixering och bärande ytor. Röntgenundersökningar bör utföras vid varje uppföljning och jämföras med tidigare röntgenundersökningar och korreleras med den kliniska bedömningen av patienten. Om några förändringar kan ses på

röntgen, såsom förekomsten av radiolucenser, benresorption eller några förändringar i implantatets läge, bör dessa förändringar följas noggrant för att avgöra om de är statiska eller progressiva och patienten behandlas på lämpligt sätt.

NEGATIVA HÄNDELSER OCH KOMPLIKATIONER

Följande är i allmänhet de vanligaste negativa händelserna och komplikationerna vid höftartroplastik:

Allmänt

Förekomsten och svårighetsgraden av komplikationer vid höftbyte är vanligtvis större vid revisioner än vid primära operationer. Vanliga problem vid revisionskirurgi kan innefatta svårigheter att placera snittet, avlägsnande av ektopiskt ben och gammalt bencement, placering och fixering av komponenter, och/eller få tillräckligt benstöd. I allmänhet kan ökad drifttid, blodförlust och risk för infektion, lungemboli och sårhematom förväntas med revisionsförfaranden.

1. Förändring i läge av de protetiska komponenterna, ofta relaterade till de faktorer som anges i VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER.
2. Tidigt eller sent lossande av proteskomponenterna, ofta relaterade till faktorer som anges i VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER.
3. Utmattningsfraktur i femurskaftet, ofta relaterad till faktorer som anges i VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER.
4. Överdrivet slitage eller fraktur på lagerkomponenterna på grund av: intraoperativt skada på proteskomponenterna, lös cement, benfragment, metallpartiklar, keramiska partiklar eller andra faktorer som anges i VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER.
5. Tidig eller sen infektion.
6. Perifera neuropatier. Subklinisk nervskada kan också uppstå som ett resultat av kirurgiskt trauma.
7. Vävnadsreaktioner, osteolys och/eller implantatlossning orsakad av metallisk korrosion, allergiska reaktioner, slitage eller partikelformat skräp (som lös cement, metall, polyetylen eller keramiska partiklar).
8. Kvarvarande smärta i höften.

Intraoperativt

1. Perforering, spricka eller fraktur i femurskaftet, vilket kan kräva användning av intern fixering.
2. Trokanterfraktur.
3. Skador på blodkärlen (t.ex. iliaca, obturator och femoral artär).
4. Tillfällig eller permanent nervskada (t.ex. femoral-, obturator- eller isolerad peronealnerv).

5. Subluxation eller dislokation av höftleden på grund av implantatstorlek eller konfigurationsval, placering av komponenter och/eller instabilitet i muskler och fibrös vävnad.
6. Förlängning eller förkortning av den berörda extremiteten.
7. Fördröjd kirurgi.

Tidigt postoperativt

1. Kardiovaskulära sjukdomar inklusive ventrombos, lungemboli och hjärtinfarkt.
2. Hematom och/eller fördröjd sårläggning.
3. Subluxation eller dislokation.
4. Disassociation av modulära komponenter.

Postoperativt i senare skede

1. Trokanteravulsion orsakad av för hög muskelspänning, viktbelastning eller oavsiktlig intraoperativ försvagning av trokantern.
2. Förvärring av problem i de ipsilaterala eller kontralaterala knä- och fotlederna på grund av skillnader i benens längd, medialisering av lårbenet och/eller muskelbrister.
3. Lårbensfraktur på grund av trauma eller överdriven belastning, särskilt vid dålig benstomme orsakad av svår osteoporos, bendefekter från tidigare operation, intraoperativa brotschningsprocedurer eller benresorption.
4. Benresorption som kan bidra till försämring av fixering och eventuell lossning av implantatet.
5. Minskad led rörlighet och rörelseomfång (kan t.ex. orsakas av periartikulär förkalkning eller förbening).
6. Traumatisk artros i det ipsilaterala knäet sekundärt till intraoperativ positionering i extremiteten under operationen.
7. Subluxation eller dislokation.
8. Disassociation av modulära komponenter.

SÄKERHETSINFORMATION GÄLLANDE MRT

 Säkerhetsinformation gällande MRT En patient med Depuy Corail cementerad konstruktion kan skannas under följande villkor. Underlåtenhet att följa dessa villkor kan leda till skada på patienten.	
Namn/identifikation på produkt	Corail Cemented höftprotes
Nominellt värde för statiskt magnetfält [T]	1,5 T eller 3,0 T

Maximal spatial fältgradient [T/m och gauss/cm]	30 T/m (3 000 gauss/cm)
RF-excitation	Cirkulärt polariserad (CP)
RF-sändarspoltyp	Helkroppssändarspole, sändande/ mottagande RF-huvudspole
Driftläge	Normalt driftläge
Maximal SAR för hela kroppen	2,0 W/kg (normalt driftläge)
Maximal SAR för huvud	En huvudspole krävs inte vid skanning av höften
Begränsningar för skanningslängd	2,0 W/kg genomsnittlig SAR för hela kroppen Skanna i upp till 15 minuter följt av 15 minuters nedkylningsperiod (kan upprepas upp till tre gånger i en enda bildbehandlingssession)
MR-bildartefakt	Förekomsten av detta implantat förväntas inte ge en bildartefakt som sträcker sig längre än 108 mm
Ytterligare instruktioner eller information som är nödvändig för säker användning i MR-miljön	*Kontrollera alla komponenter i höftkonstruktionen för ytterligare MR-märkningsinformation

KASSERING

Kassera alla använda produkter i enlighet med lokala rutiner och riktlinjer.

SYMBOLFÖRKLARING

D/DP

DEPUY

REF

Katalognummer

LOT

Batchnummer



Försiktighet!



Läs bruksanvisningen



www.e-IFU.com
US / Canada 800-255-2500
EU: +800 8888 2020
EU: +32 2 4037222

Webbplats med elektronisk
bruksanvisning



Tillverkare



Bäst före-datum



Steril



Steriliserad genom
strålning



Får inte omsterilisas



Använd inte om
förpackningen är skadad



Får inte återanvändas



MR-villkorlig



Förpackningsenhet



Konstruktionsmaterial



Medicinteknisk produkt



Dubbel sterilt barriärsystem



Återvinningsbar

RT / LT

Höger/vänster



Tillverkad i

S

Rostfritt stål

SIZE/SZ/DIA/IN/ft/DEG/GRP/lb/OD/ID

Storlek/storlek/diameter/tum/fot/grader/grupp/pund/
ytterdiameter/innerdiameter



DePuy Ireland UC
Loughbeg, Ringaskiddy
Co. Cork
Ireland
Tel: +353 214914000
Fax: +353 214914199



IFU-0902-60-091
Rev. A